

目 录

内 科

1. 感冒..... (1)	21. 慢性肠套叠..... (47)
2. 感染性发热..... (6)	22. 肠道菌群失调症..... (49)
3. 流行性咽结膜热..... (18)	23. 脂肪肝..... (52)
4. 支气管结石..... (19)	24. 肝炎后综合征..... (58)
5. 咯血..... (20)	25. 肝脾结肠曲综 合征..... (60)
6. 肺含铁血黄素沉 着症..... (24)	26. 慢性疲劳综合征..... (61)
7. 迁延性肺嗜酸粒细 胞浸润症..... (26)	27. 结核性腹膜炎..... (64)
8. 幽门梗阻..... (27)	28. 阑尾周围脓肿..... (66)
9. 胃术后功能性排空 障碍..... (29)	29. 下肢静脉曲张..... (69)
10. 多发性胃息肉症..... (30)	30. 精索静脉曲张..... (71)
11. 胃痉挛..... (31)	31. 精子功能低下..... (73)
12. 急性单纯性胃炎..... (33)	32. 阴茎异常勃起症..... (74)
13. 急性出血性糜烂 性胃炎..... (35)	33. 阴茎硬结症..... (76)
14. 慢性糜烂性胃炎..... (36)	34. 紧张性排尿迟缓综 合征..... (78)
15. 十二指肠壅积症..... (38)	35. 高氮质血症..... (79)
16. 浅表性胃炎..... (40)	36. 肾周围脓肿..... (81)
17. 胃窦胃炎..... (41)	37. α 地中海贫血..... (82)
18. 结肠息肉..... (43)	38. β 地中海贫血..... (84)
19. 伪膜性肠炎..... (44)	39. 急性肺原性心 脏病..... (85)
20. 肠痉挛..... (46)	40. 心源性水肿..... (89)
	41. 急性心包炎..... (90)

42. 慢性心包炎..... (93)	55. 一氧化碳中毒性精神病..... (126)
43. 贫血性心绞痛 综合征..... (94)	56. 癔病性失音..... (128)
44. 慢性风湿性心脏病..... (96)	57. 神经性厌食..... (129)
45. 原发性心肌病..... (99)	58. 神经性暖气..... (132)
46. 直立性低血压..... (103)	59. 癔球症..... (133)
47. 高原性低血压型脉 压差小症..... (104)	60. 排尿性晕厥..... (134)
48. 结节性多动脉炎..... (105)	61. 结核性变态反应性 关节炎..... (136)
49. 红斑性肢痛症 (灼 热足综合征) (106)	62. 肩手综合征..... (137)
50. 椎-基底动脉供血 不足..... (108)	63. 花粉症 (过敏性综 合征) (139)
51. 血管性头痛..... (109)	64. 晕动病 (晕车 晕船) (140)
52. 痉挛性斜颈..... (120)	65. 过早衰老..... (141)
53. 腔隙性脑梗塞..... (121)	66. 阿托品依赖症..... (153)
54. 肝豆状核变性..... (123)	67. 乌头类药物中毒..... (154)
	68. 人参中毒综合征..... (156)

妇 产 科

69. 月经周期性水肿..... (158)	73. 女扎术后综合征..... (163)
70. 妊娠膀胱炎..... (159)	74. 刮宫术后出血..... (165)
71. 妊娠胆汁淤积症..... (160)	75. 妇科癌症放疗后阴 道干涩..... (166)
72. 胎儿宫内生长 迟缓..... (162)	

儿 科

76. 小儿缺锌症..... (168)	性肾炎..... (169)
77. 儿童乙型肝炎相关	78. 小儿高热惊厥..... (171)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 79. 小儿脑性瘫痪………… (180) | 81. 先天性巨结肠………… (184) |
| 80. 川崎氏病 (皮肤粘膜
淋巴结综合征) …… (183) | 82. 小儿肺不张………… (186) |

外 科

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 83. 急性附睾炎………… (188) | 88. 腰椎间盘突出症…… (198) |
| 84. 急性睾丸炎………… (189) | 89. 桡骨茎突部狭窄性
腱鞘炎………… (208) |
| 85. 蛇伤性溃疡………… (191) | 90. 屈指肌腱狭窄性腱
鞘炎………… (210) |
| 86. 糖尿病趾端坏死…… (193) | |
| 87. 急腹症术后综合
征………… (194) | |

皮 肤 科

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 91. 梅毒………… (212) | 93. 生殖器疱疹………… (221) |
| 92. 麻风………… (218) | 94. 激素制剂皮炎…… (223) |

五 官 科

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 95. 球后视神经炎…… (225) | 97. 老年性耳聋………… (233) |
| 96. 青光眼………… (228) | 98. 骨刺鲠喉………… (238) |

口 腔 科

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 99. 舌下腺囊肿………… (239) | 100. 口腔粘膜白斑…… (240) |
|-----------------------|-----------------------|

内 科

1. 感 冒

感冒，又称普通感冒（有别于流行性感冒），是一种常见病、多发病，起病较急，潜伏期较短。约1天左右。临床表现以鼻咽部炎症为主，早期症状常有咽部粗糙感、干燥或咽痛，并有喷嚏、鼻塞、流清涕等。如病变向下发展，侵入喉部、气管和支气管等时，则可出现发音嘶哑、咳嗽、胸痛等症状。体温往往不超过38℃，约3~4天热退。此外，常有全身酸痛，乏力，头痛，消化不良，腹胀等症状。

由病毒引起的感冒，需经7天左右才能痊愈。

感冒属于祖国医学的“外感风邪”范畴。中医把感冒分为外感风热（风热感冒）和外感风寒（风寒感冒）两大类。此外，尚有气虚感冒（反复发作者）也是常见类型。

辨证分型治疗

（一） 风寒感冒：鼻塞声重，喷嚏，流清涕，咽痒，咳嗽，痰多稀薄。甚则恶寒，发热，头身痛，无汗。舌淡红苔薄白，脉浮紧。治宜辛温解表，宣肺散寒。

方药：荆芥10克，防风10克，柴胡10克，薄荷10克，川芎10克，前胡10克，羌活12克，独活12克，茯苓10克，桔梗10克，枳壳10克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服3剂。

（二） 风热感冒：发热，微恶风寒，或有汗出，头痛，

鼻塞涕浊，口干渴，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠，舌红苔黄，脉浮数。治宜辛凉解表，清肺透热。

方药：银花30克，连翘30克，薄荷10克，牛蒡子20克，桔梗12克，芦根30克，淡竹叶12克，淡豆豉10克，甘草6克，水煎服。每日1剂，连服3剂。

(三) 气虚感冒：恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰白，倦怠无力，气短懒言，反复发作。舌淡苔白，脉浮无力。治宜益气解表。

方药：党参30克，苏叶10克，陈皮10克，葛根30克，茯苓15克，法半夏10克，前胡10克，桔梗10克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服4剂。

食物疗法

(一) 风寒感冒：1. 生姜适量，切细末，冲开水1杯，并加红糖或白糖少许，趁热1次服下。

2. 大蒜、生姜各15克，切细末，冲开水1杯，并加红糖或白糖适量，趁热1次服下。

3. 生姜炒米粥：生姜30~50克，切细末与炒米（即大米入锅中略炒）50克共煮成粥，加适量食盐及葱食用。

(二) 风热感冒

1. 生梨2~3个，洗净，连皮切碎，加冰糖蒸服。

2. 菊花30克，泡水服，或用市售菊花晶适量泡水饮用。

3. 白萝卜250克，洗净切片，加水3杯，煎至2杯，加白糖少许，趁热服下1杯，半小时后再服1杯；或取萝卜洗净切片，加白糖适量，一夜后取汁分次饮服。

4. 新鲜果汁适量，加白开水饮服。每日摄入液体总量宜保持2500毫升，可帮助退热发汗及排除病毒毒素。摄入液

体除果汁开水外，还可配合服豆浆、菜汤、蛋汤等。

其他辅助防治方法

(一) 常用盐水漱口常喝茶

这是一种可防治感冒的简便方法。茶叶里有单宁酸，可以杀菌、凝固细菌的活动力。茶叶里还有维生素C，能增强身体抵抗力。盐的杀菌力也极强。

在感冒流行季节，若要出入公共场所（如电影院、戏院、车站、码头、饭馆），身上带上几颗咸干果，如盐渍橄榄、咸话梅等，一出门，马上放一颗在口里，使经常有一丝丝咸味润在喉咙上，细菌便过不了这一关。回家之后，再用盐水漱口，喝几杯热茶，这样，便可起到防治作用。

(二) 干浴头面法控制感冒前驱症状

感冒在全身症状出现之前就有一些前驱征兆，如打喷嚏，鼻子发痒发酸，流清涕，头昏或脖子发沉等，这便是感冒的初起症状。一经出现上述症状，即施行干浴头面法，能取得快速治疗的效果。具体方法是：将一手自然弯曲，紧贴于后头部，以枕外粗隆及其下的风池穴为重点，来回用力摩擦，一手累了，立即换手连续不断地摩擦，并重点在两风池穴进行点、按、揉、搓，至有酸、胀、重、麻感觉为度。摩擦过程中，患者会感到摩擦的局部发热、出汗、浑身轻松，感冒早期症状便会消失。如做一次后，感冒初起症状消除不彻底，可休息片刻，再进行一次。对不易出汗者，可喝杯热开水再做上述动作，即可出汗。有的人按摩后不出汗，感冒症状也会消失。如头昏症状较重，可按揉太阳穴（即两眉梢外侧3厘米处）数十下，或捏揉耳垂及其上的软骨部分（即对耳屏）数十下，头昏即可缓解。如鼻部症状较重，可捏揉耳屏（俗称小耳朵，据中医耳诊疗法，耳屏相当于人的鼻

部)数十下。

(三) 用热水烫脚

尽管感冒是鼻病毒或其他微生物引起的,但着凉却是最常见的诱因。所以,让身体发热出汗是防治感冒较好的方法。用热水烫脚,简便易行,全身就会出汗。具体方法是:在脚盆里盛 43°C 左右的热热水,双脚侵入,热水要把整个脚背淹没,如水温有所下降可再加入热水,使整个烫洗过程的水温一直保持在 43°C 左右,10分钟左右,全身就会出少量的汗。随着出汗,头痛、身痛等感冒症状即可减轻。洗完脚后,用干毛巾擦干。穿上鞋袜,使脚的温度保持一段时间。一天洗几次热水脚,感冒症状自然会消除。

(四) 宜补锌

用补锌的方法治感冒有较好疗效。可服葡萄糖锌片或甘草锌片等。有的医生给感冒病人服用葡萄糖酸锌后,病人的头痛、发热、肌肉酸痛、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等症状皆减轻,咽痛、咳嗽也改善。医学专家认为,有些人特别容易患感冒,可能与平日体内缺锌有关。某些食物含锌丰富,如苹果、牛奶、鱼、豆类、瘦肉等。易感冒患者平时宜常吃含锌食物,特别是苹果。

(五) 随时洗手

随时洗手可预防感冒。医学家通过观察发现健康人与感冒患者握手后,或接触感冒患者刚摸过的物品后,就会把感冒病毒沾在自己手上而患感冒。而且这些感冒病毒在健康者手上可以存活70个小时左右。因此,随时洗手就能切断感冒病毒传染的途径。

(六) 用消毒加热蒸馏水滴鼻

用消毒加热的蒸馏水滴鼻防治感冒有较好效果。把消过

毒的蒸馏水放入消毒好的眼药水瓶，然后加热至43℃，即可滴鼻，每隔2小时滴1次。

(七)、配合服用大剂量维生素C

配合服用大剂量维生素C（每日2000毫克），可使感冒加速痊愈。

(八) 感冒患者七忌

1. 忌在服用四环素的同时喝牛奶。因为牛奶中含有比较丰富的钙铁等离子，这些离子同四环素发生化学反应生成难于溶解的结合物，从而影响药物疗效。

2. 忌在饭后服用抗生素类药物。这是因为，四环素、土霉素等药物在酸性的溶液中极不稳定，若在饭后服用，在大量胃酸的作用下，就会分解变成另一种物质，而不能被小肠吸收，起不到治疗作用。

3. 忌过量服用阿斯匹林。因为过量服用阿斯匹林会引起以下副作用：①导致或加重消化道溃疡，甚至引起消化道出血。②诱发或加重哮喘。③引起缺铁性贫血。④可引起耳鸣、耳聋、听力减退，并加重噪声对听力的损害。⑤如果每天服阿斯匹林4克，可使精液中前列腺素含量降低。并出现较多的异型精子，从而影响生育。⑥有出血倾向的患者服用后可延长出血时间。⑦极少数患者可诱发肝脏损伤。⑧孕妇产前若大剂量服用阿斯匹林，有增加早产儿颅内出血的可能。⑨对肾脏有损害作用，可引起蛋白尿、血尿，甚至发生急性肾小管坏死。

4. 忌洗头后马上睡觉。

5. 忌用力擤鼻涕。感冒患者如果不停地用力擤鼻涕，不仅不能减轻鼻塞症状，反而会造成逆行感染，引起鼻窦炎或中耳炎。

6. 忌献血。感冒时献血容易出现头晕脑胀，甚至晕厥。

7. 忌乘飞机。感冒时乘飞机容易引起“航空性中耳炎”，出现耳痛、耳鸣，甚至眩晕、呕吐等症状。

2. 感染性发热

健康人的体温相对稳定，口腔温度一般保持在 37°C 上下，直肠内温度一般比口腔约高 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，腋窝温度比口腔约低 $0.2\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 。不同个体的正常体温略有差异。正常体温一昼夜间有轻微的波动，晨间稍低，下午稍高，但波动范围不超过 1°C 。小儿的体温可较成人稍高，老人体温可较青壮年人稍低，妇女月经期体温可较平日为低，而在排卵期与妊娠期则稍高。

发热是指病理性的体温升高，是人体对于致病因子的一种全身性反应。一般说来，口腔温度在 37.3°C 以上，或直肠内温度在 37.6°C 以上，一昼夜波动在 1°C 以上时，可认为有发热。

体温在 39°C 以上时称为高热，在 40°C 以上时称为超高热。

引起发热的疾病很多，可分为感染性与非感染性两大类，而感染性发热占绝大多数。

感染性发热疾病包括病毒性感染、支原体感染、立克次体感染、细菌性感染、螺旋体感染、寄生虫感染等。

发热只是疾病的一个症状，而且发热的原因复杂。对于发热病人应查明原因，必须认真细致地进行全面的诊查，并

结合临床观察，以便及时确立诊断。

感染性发热属于祖国医学的“温病”、“热病”范畴。早在《内经》中就谈到发热性疾病，如《热论篇》说：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”又说：“人之伤于寒也，则为病热”。中医认为感染性高热系邪毒内侵，正邪相争，阴阳平衡破坏，导致临床的热盛急候。

关于感染性高热的病因病机，中医专家黄星垣认为“热由毒生”。温病的热，系由病原微生物的毒素及其代谢产物，在体内经过转化，破坏了机体体温的正常调节，产生内生热源从而引起产热增加，以致发热。

温热邪毒一旦侵入，一方面可以直接造成机体功能的紊乱和组织的损害，产生中毒症候；另一方面又能损害机体抗感染的防御机能，加重感染的严重程度。而清热解毒方药的药效作用，不仅能有效地解除其毒害反应，减少对机体组织的损伤，减轻感染的中毒症状，而且还能保护机体正常抗感染的防御机能，既扶正又祛邪，遏止感染的发展。

外邪是外感高热的病因，高热是邪正相争的表现。

感染性发热的治疗，宜清热解毒，祛邪撤热。

综合治疗

(一) 应急处理（下列诸法可单独使用或综合使用）

1. 物理降温（药物擦浴）

(1) 用荆芥15克，薄荷15克，煎水擦浴，得微汗而解，适用于风寒外感高热者。

(2) 用石膏煎液（20%）擦浴，尤适邪热入里之高热。

(3) 冰敷 用冰袋装入冰块，置于头颈部、腋下，腹股沟处。大热一退即停用。

(4) 刮痧 适用于高热而不恶寒者。

2. 针刺

一般选穴，上肢取曲池、合谷，配内关、手三里。下肢取足三里，阳陵泉，三阴交。手法均采用泻法。

亦可用柴胡注射液，银黄注射液进行穴位注射。常取曲池（双）、足三里（双）、每穴注射0.5~1毫升，每4~6小时1次。

3. 滴鼻

柴胡注射液滴鼻，每次每侧鼻腔3~4滴，每半小时至1小时滴1次。

4. 灌肠

生大黄15克，枳实15克，甘草10克，山药15克，寒水石20克，煎水取汁200毫升，作保留灌肠（保留30分钟），每2~4小时1次。体温下降后减少灌肠次数或停用。本方适用于各种外感高热。

5. 针剂肌肉注射

(1) 柴胡注射液或银黄注射液，每次2~4毫升，肌肉注射，每日3~4次。适用于卫分、气分发热。

(2) 醒脑静注射液 本品系安宫牛黄丸改制而成，每毫升含生药1克，肌注每次4毫升，每日1~3次。或每次10~20毫升，加入5%葡萄糖液500毫升中静滴，对肺系感染高热疗效较好。

辨证论治

(一) 卫分证

1. 风热袭表：发热微恶寒，咽喉赤痛，脉浮数，舌红苔薄黄。治宜辛凉解表。

方药：银花30克，连翘30克，桔梗10克，薄荷10克，淡

竹叶10克，荆芥10克，牛蒡子15克，芦根30克。水煎服，每日1剂，连服3剂。

2. 风寒束表：恶寒发热，头痛身痛，鼻塞清涕，脉浮紧，舌淡红苔薄白。治宜辛温解表。

方药：荆芥10克，防风10克，川芎10克，枳壳10克，羌活10克，独活10克，茯苓10克，桔梗10克，甘草10克。水煎服。每日1剂，连服3剂。

(二) 气分证

大热，大渴，出大汗，脉洪大，治宜清气撤热。

方药：生石膏30~60克，知母12克，甘草10克，粳米10克，大青叶30克，板蓝根30克，蚤休30克。水煎服，每日1剂，连服4剂。

(三) 营分证

高热，身热夜甚，神昏谵语，斑疹隐隐，口渴少饮，治宜清营解毒。

方药：犀角粉1.5克，生地30克，玄参30克，麦冬30克，银花30克，连翘15克，丹参30克，黄连10克。水煎服，每日1剂，连服5剂。

(四) 血分证

身热灼手，斑疹密布，出血，神昏谵语，舌深绛，脉细数，治宜清热凉血。

方药：犀角粉1.5克，赤芍30克，丹皮15克，生地30克，大黄10克，栀子10克，黄连10克，茅根30克，侧柏叶15克。水煎服，每日1剂，连服5剂。

专方验方治疗

1. 银花30克，紫花地丁30克，蒲公英30克，野菊花15克，紫背天葵12克，栀子10克，黄芩30克，黄连10克。水煎

剂，每日1~2剂，分6次服（昼夜兼服），连服4天。

2. 板蓝根30克，鱼腥草30克，大青叶30克，休蚤30克，黄芩30克，败酱草30克，小蓟10克。水煎服。每日1~2剂（昼夜兼服）。连服4天。

3. 安宫牛黄丸（成药），每次1丸，日3次，用于高热烦躁，神昏谵语。

4. 紫雪丹（成药），每次1丸，日3次，用于高热烦躁，神昏谵语。

5. 至宝丹（成药），每次1丸，日3次，用于高热烦躁，神昏谵语。

护理措施

1. 每2~4小时量体温1次。

2. 如高热持续不退，或体温虽不甚高而伴有恶吐、泄泻、大汗出者，应多给病人喝糖盐开水、鲜果汁、银花露、茅根汤等。饮食宜清淡，吃流质或半流汁饮食，忌吃油腻、辛辣、鱼虾，禁烟忌酒。汤药宜微温服，服药后酌加衣被，或进食少许热稀粥，以助微汗，助邪外达。

3. 除了在综合治疗中介绍的药物擦浴外，还可采用酒精擦浴。酒精擦浴主要适用于体温在40℃以上体质较好而无汗的病人。新生儿及年老体弱者禁用。方法是用30~50%酒精（如无酒精也可用60度白酒代替，1份白酒掺半份水）主要擦四肢、腋窝及背部，一般擦3~5分钟，用力适当，使皮肤血管扩张，热量随酒精蒸发而扩散。

4. 用温水擦浴：用32~36℃的温水，将毛巾浸湿后擦拭皮肤，使皮肤血管扩张，血流加快，散热增加。每擦完一遍，待皮肤上水分蒸发干后再擦第二遍，直至体温下降。擦完后盖好被，以免受凉。

5. 服大黄泻热降温：近年来研究发现，大黄有较好的降温作用，中医称之为通腑泄热，使热从肠道而泄。可用大黄粉3~5克口服，或用大黄10克、芒硝10克，泡开水当茶饮，或稍煎后顿服。此法简便有效，而且安全，无副作用。

6. 坚持用刮痧疗法降温：在综合治疗中已介绍过刮痧疗法，在此再强调一下。刮痧疗法是古老的、流传于民间的一种物理疗法，用于退热有较好效果。方法是：用瓷汤匙在背部（蘸水）上下刮，以刮出紫红色斑点为度。发热病人，轻轻一刮，就能刮出斑点（痧点），痧点呈紫红色，粒大，密布。而正常人刮痧出痧慢，需重重地刮多次才可能出现浅淡、稀疏、粒小的痧点。两者截然不同。

中医认为刮痧疗法具有以下功效：①解太阳之表邪，不使邪气内传。②通过疏通俞穴，达到调和内脏气血、阴阳之功能。③可引邪毒外出，从而减轻内脏损害。④刮痧后出现皮下出血，然后再经吸收，起到组织疗法的效果。

7. 感染性发热患者三忌：①忌喝浓茶。一般的家庭都习惯给感冒发烧的病人喝点热的浓茶。实际上这种方法不好。研究证明，发烧病人之所以不宜喝浓茶，是因为茶叶里的茶碱会提高人体的温度，并使降温药物的作用消失或减弱。②忌大便秘结。大便秘结往往可使感染性高热患者体温不降。大便通畅后，发热能较快缓解。中医认为“肺与大肠相表里”，肺炎患者服用退热通便药后，会使热随大便而泄。因此，感染性发热患者一定要保持大便通畅，必要时服点大黄，最好每日大便2~3次，更有利于降温退热。③忌不喝水。感染性发热患者应多喝水或清凉饮料，以帮助毒素的稀释和排出。笔者因上呼吸道感染，曾高烧39.5℃，大量喝水，只服用羚羊感冒片一种药，体温逐渐下降，6小时后，体温即

趋正常。可见喝水对感染性高热患者来说，是至关重要的。

治法研究

1. “截断扭转”疗法是治疗感染性高热的重要手段。何谓“截断扭转”疗法？

在临床上，对某些病症（包括感染性高热），在尚未出现下一层次的证象前，先投以下一层次的药物（如在出现卫分症状时，先投以气分药治疗），来一个急病急治，截断病势，扭转病势。这就是“截断扭转”疗法。

截断扭转疗法用于治疗感染性高热，确能缩短疗程，提高疗效。

姜春华教授首先提出了截断扭转疗法的独特见解。截断扭转疗法的指导思想是采取果断的措施和特殊功效方药，快速控制急性疾病，截断疾病的发展变化，以提高疗效，缩短疗程，避免造成复杂严重的后果。这个指导思想正是祖国医学渊深源久的传统观点的发展。《素问·阴阳应象大论》早就指出：“邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也”。说明外邪侵入人体后，如果不作果断处理，病邪就会逐步深入，侵犯重要脏器。“疾如风雨”，“善治者治皮毛”，正是对急性病（包括感染性高热）宜快速截断的重要启示。清·吴又可也有“客邪贵乎早逐”的主张。

感染性高热，来势急，易逆变，邪正相争，正气未虚，治疗重在祛邪。例如，对于具有高热症状的急性胰腺炎的治疗，采用截断扭转疗法，攻下通泄，可以促使疾病早愈。

又如对于乙型脑炎（具有高热症状）的治疗也可采用快速截断疗法，能使疗程缩短，疗效提高。

乙型脑炎，一般分卫分型、气分型、营分型、血分型等

几个证型。临床上有些病例初看起来是卫分证、气分证，每当刚投药时，迅即出现气营两燔或营血内陷的证候，病人高热，抽搐，神昏，情况严重，往往又须临时改药。如果能采取“药先于病”的快速截断疗法，不仅用足够剂量的清热解毒药（针对高热），而且把熄风、豁痰、开窍、醒脑药预先加到各个治疗阶段中去，则可缩短疗程，提高疗效。名老中医欧阳錡在“脑膜炎”流行时，只要有高热、项强、喷射性呕吐等临床症状，即投以预先煎好的加减清瘟败毒饮大剂频服，不少患者在“脑膜炎”确诊前病势已得到控制，有效地阻止了病情的发展。

截断扭转疗法，旨在“扭转病势，截断病邪”。《内经》云：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”，《内经》的这一观点实际上已寓存“截断扭转”的微旨。

治大叶性肺炎高热用鱼腥草、鸭跖草，治肠伤寒高热一开始即用大黄、黄芩、黄连苦寒之剂，不分卫气营血之步骤，疗效甚高。“截断扭转”治疗温病（包括感染性高热），有其独特的医学内涵，有着强大的生命力。其实用价值在于：①重用清热解毒，抑制病原，使病程阻断或缩短。②早用苦寒攻下，迅速排泄邪热蕴毒，能有效的截断、驱除病邪。③及时凉血化瘀，不使瘟毒热结血分，避免重症出现。

（二）中医综合疗法（包括物理降温、针刺退热、滴鼻退热、灌肠退热、针剂肌肉注射等）是治疗感染性发热的引人注目的重要方法。

中医综合疗法治疗感染性发热，是以整体观念、温病学说、针灸学、内科学等中医多种学科为理论基础，把运用现代科学技术进行剂型改革取得的成果与传统治疗手段结合，并将西医知识为我所用。中医综合疗法治疗感染性高热的疗

效优于口服中药。对中医单一疗法无效者，改用中医综合治疗，能提高疗效。

从方法论角度分析，中医综合疗法较好地解决了热病整体与局部、治本与治标的关系。它采用分兵合围，多种治法合用，多途径给药，把整体调治放在首位，同时，用刮痧、滴鼻、灌肠、针刺等手段，重在祛除邪热，保护机体正常抗感染的防御机能，祛邪又扶正，抑制感染的发展。

从作用机制看，中医综合疗法治疗感染性高热的主要特点是：

1. 加强顿挫邪热：特别是清下并用（清热解毒药加大黄等泻下药），充分发挥了泄热排毒作用。历代中医学家都很重视大黄在治疗感染性高热中的作用，大黄不仅能攻下逐邪，而且能清热解毒，活血化瘀。寒下是《内经》治疗热病的重要原则，而大黄则是寒下法的主要药物。张仲景所著《金匮要略》和《伤寒论》两书中，用大黄者89处，占全书方剂的3/4，华佗所著《中藏经》中含有大黄的方剂占全部方剂的24.2%，张子和、刘完素都是以大黄治实证、热证的名家，清代名医吴又可善治温病（包括感染性高热），善用大黄，创立“温病下不嫌早”的学说。大黄确是祖国医学治疗感染性高热的重要药物之一。

大黄的生物活性强，作用面广，临床疗效卓著。我国中西医结合治疗急腹症（大部分有感染性发热的症状）在国际上占领先地位，而大黄却是治疗急腹症的最重要的药物。感染性高热和一些原因不明确的发热用大黄治疗确有良效。

2. 清热解毒与养阴同步进行：热病最易伤阴，清热解毒与养阴同时并重是中医治疗感染性高热的重要法则。中医认为“存得一分津液，便有一分生机”。为了提高对感染性高

热的治疗效果，必须注意顾护津液。

古代医家十分重视温热病的存津保液（存阴）问题，指出“热病必消烁真阴”，“热邪不燥胃津，必耗肾液”，因而“温热存阴，最为紧要”，“能保得一分津液，便是退却一分温邪”，强调“温热为法，法在存阴”。并强调“务在先安未受邪之地”（预防伤阴）。

顾护津液可分为以下两大作用：

1. 以祛邪撤热为目的的保津护阴。
2. 以扶正为重点的养阴增液。

这两方面是相辅相成的。

祛邪撤热是治疗温病伤阴的重要措施。伤阴是温邪的特性，伤阴与发热是分不开的。在温热病的治疗上如能顿挫热势，如能及时祛邪撤热，就可避免伤阴。也可在清热解毒方药中随证酌加生地、麦冬、玄参等养阴之品，顾护津液，预防伤阴。

热由毒生，毒不去则热不除，变必生。解毒是针对发热的直接原因的一种治疗措施，能减轻邪毒对人体的直接损害，避免津血渗于脉外，避免阴液内耗，有利于正气的恢复，为正气战胜温邪创造条件。

清热解毒药及其组成的复方可以作用于急性感染性疾病的多个环节，或是能够杀灭或抑制入侵的微生物病原体，对抗、中和其毒素，或调节机体对病原体入侵所产生的反应，使过高的体温下降，改善毛细血管通透性，对抗炎症渗出，控制白细胞游走，抑制增生，兴奋肾上腺功能，提高机体的免疫功能，促进机体紊乱功能或受损组织的恢复等等。对机体的调整作用是清热解毒的中草药比抗生素尤为突出的优点。在感染性高热的治疗中，及时使用清热解毒的中草药，

可以阻止、中断病程的发展，也就相应地减少或避免阴液的耗伤。

在使用清热解毒法的同时，应配合用养阴生津或益气生津之品以补充体液。如白虎汤中即有生石膏清热泻火，知母苦寒清热以增强清热泻火除烦之作用，并能养阴生津、补充体液，再加上甘草粳米益气调中，保护生化之源。这种组方原则是应该在临床实践中大力提倡的。

在治疗感染性高热的清热解毒方剂中，应配伍芦根、麦冬、玄参、生地以顾护津液，提高疗效。

通腑泄热（急下）即是存阴。

通腑泄热法之应用，不必局限于阳明腑实证（高热便秘）。通腑泄热，能将邪毒直接排出体外，可使症状得以改善。这是釜底抽薪之计，能阻止病人继续发热。

通腑泄热（通便）存津，能缩短病程，预防伤阴。通腑泄热还兼有清热解毒、活血化瘀等作用。

高热便秘（腑实明显）宜急下存阴。只有急下，才能使燥结去，烈焰消，津液自有生存之望。例如，用通腑泄热清热解毒活血化瘀方药治疗成人急性肺炎（有高热症状），可促使肺部炎症早日吸收，可促使体温和白细胞早日恢复正常。

养阴增液也是感染性高热治疗中的重要措施，与祛邪撤热相辅相成，不能截然分开。

养阴增液（救阴）与现代医学输液，在某些方面有相似之处，如急性热病高热汗出，口渴思饮，脉洪数，舌红绛，是热甚津耗伤阴之象，此时输液可以纠正电解质紊乱，能使高热迅速下降，口渴和出汗症状改善，较之口服救阴药物见效迅速。但输液不能全部代替救阴法则。如温病邪入胃腑，

出现热结于里，大便干结者，用增液承气汤增水行舟，效若桴鼓，而输液则无能为力。又如温病末期，热邪久羁下焦，耗灼肝肾真阴，虚风内动者，须用三甲复脉汤或大定风珠等养阴清热，潜阳息风。若输液则无济于事。因此，养阴增液与输液应密切结合，取长补短，才能相辅相成，提高疗效。

祖国医学虽然没有明确提出“补液疗法”，但实际上早就已经有了与“补液疗法”性质相同的“存津保液”的治法了。怎样才能更好的存津保液？

① 如何判断伤阴？伤阴的表现有：口渴喜饮，尿少，便干，皮肤干燥，唇齿干燥，舌少津或生芒刺，发热，甚至抽搐昏迷。伤阴的表现以舌象的变化最为敏感而重要。分辨舌质的润燥，就可推测阴津的盈亏，判断伤阴的有无。

② 温病伤阴以耗伤胃腑肾脏的阴液为主。胃阴伤者，症见食少不饥，腹胀满，大便燥结，舌红少津，苔光剥，脉细数。可用甘寒生津之剂治之，如梨汁、荸荠汁、藕汁、牛奶等混合液。肾阴伤者，消瘦神疲，耳聋目瞑，低热颧红，手足心热，舌绛而干，舌体枯萎而强硬，齿干齿黑，脉虚细，可用甘润滋填之剂治之，如生地30克，麦冬30克，麻仁10克，人参叶30克，生牡蛎30克，鳖甲15克，炙甘草10克，阿胶15克，黄精30克。水煎服。

③ 撤热养阴孰主孰次？在感染性发热的治疗过程中，对于邪热盛而伤阴不甚者，治疗宜以撤热为主（清热解毒）。邪热未衰，阴伤较显著者，治疗宜撤热养阴并重。阴伤严重，邪热已去，阴液未复者，治疗应以滋阴为主。

3. 流行性咽结膜热

流行性咽结膜热系病毒性疾病，多发于夏秋之交，以8月份为发病高峰。中小學生发病居多，其中90%的患者有游泳史。

本病多由腺病毒引起。

临床表现：发热，多在39~41℃，无汗，恶寒，头晕头痛，恶心呕吐，咽痛，眼红，乏力，咽部明显充血，滤泡增生，扁桃体红肿并附有伪膜。结膜充血，有水样分泌物。少数患者伴鼻衄，淋巴结炎，咳嗽，咳痰带血，大便干燥。

实验室检查，病毒培养阳性率可达90%以上，血清抗体测定阳性率及免疫荧光快速诊断阳性率均可达90%以上。血中白血球总数可偏高。

流行性咽结膜热属于祖国医学的“风热表证”范畴。中医认为系风邪(风热)外袭，湿浊内阻，或太阳、阳明合病(便秘，发热)。治宜疏风解表，清热利咽。

方一：丹皮10克，栀子10克，蚤休15克，薄荷10克，黄芩30克，竹茹10克，白芷10克，玄参15克，赤芍15克，蒲公英30克。水煎服，每日1剂。连服3剂。

方二：生石膏30克，知母12克，银花30克，连翘30克，板蓝根30克，射干10克，藿香10克，香薷10克，荆芥10克，滑石30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服3剂。大便秘结者加大黄10克。

为避免患者呕吐，药液可少量频服，重者每日可服2剂。

方三：板蓝根30克，厚朴10克，苡仁30克，杏仁15克，

白蔻仁10克，佩兰10克，连翘30克，贯众15克，通草10克，紫花地丁30克。水煎服，每日1剂，连服3剂。

4. 支气管结石

支气管结石是临床少见的疾病。病因不明，有人认为系由于结核、组织胞浆菌病等内芽肿性病变引起部分钙化的肺门淋巴结侵入支气管腔构成。有人认为结石是由于支气管壁炎性坏死物未能及时脱落咳出，逐渐浓缩钙化而成。亦有人认为结石系由于患者胸部及肺组织受伤后，肺血管瘀血，加上卧床休息血流缓慢，血栓形成钙化所致。

支气管结石是不规则的硬性质块，系体积大小不等的钙化性石头体。这种结石常随咳嗽咳出体外，有的呈灰白色的圆形颗粒，有的形如半月状，形态不一，大小不等，质地坚硬，手不易压碎，置于75%酒精中24小时不溶解。患者常感胸闷不舒，犹如大石压胸，也有的患者自感喉中如有异物，咯之不出，咽之不下。X线检查可见致密阴影而确定诊断。

支气管结石属于祖国医学痰瘀证咯石范畴。中医认为，人之气道贵乎清顺，若外为风寒燥湿之侵，内为惊怒忧思之扰，营卫不清，气血浊败，熏蒸津液，痰乃生焉。内滞痰浊，则成症瘕积块。也就是说，痰夹瘀血，郁结日久，则可凝聚为顽痰结石。其治疗，宜理气开结，活血通络，涤痰排石。

方药：浙贝15克，川贝6克，瓜蒌30克，桔梗15克，前胡15克，法夏12克，陈皮10克，茯苓15克，生龙骨30克，生牡蛎30克，鸡内金15克，枳壳12克，皂刺15克。水煎服，每日1剂，连服14剂。

加減：小便不利加車前草、金錢草，大便秘結加生大黃，咯血加桑白皮、茅根、仙鶴草，納差加萊菔子。

5. 咯 血

咯血是指在各種致病因素下，肺內血管破裂，血液溢入肺泡或支氣管內，再通過咳嗽經口腔排出體外的病理過程。常見於支氣管擴張、肺結核、肺炎、肺癌等的出血。輕度咯血，一天出血量少於100毫升，或1次咯血50毫升以內。中度咯血，一天出血量在100～500毫升，或1次咯血50～100毫升。重度咯血，一天出血量超過500毫升，或1次咯血在100毫升以上。脈率100次/分左右，或較咯血前增加10～20次/分，血紅蛋白10克%以內，或較咯血前下降2克%以上。血壓可下降，或因咯血引起喘促、紫紺。

咯血，祖國醫學又名咳血、嗽血。血由肺來，經氣道咳嗽而出，或一咯即出，血色鮮紅，常間夾泡沫或痰血相兼。咯血突然起病，容易反復發作。好發於冬春季節。中醫認為咯血多因外感風邪燥邪，或因七情內傷，肝郁化火，或因熱病傷陰，久病陰虧，陰虛火旺，導致熱傷肺絡，迫血妄行，血隨氣逆而咯血。亦可因久病、勞倦致氣不攝血而致。中醫認為咯血的誘發因素有：常因咳嗽、肺癆等宿疾，或食辛辣，或情志郁怒而誘發。咯血的治療，宜瀉火，降氣，平肝，養陰，止血。忌用升散、燥熱之藥。

急救治療

(一) 解除病人緊張情緒，取側臥位，防止窒息。

(二) 止血：

1. 大黄醇提片(粉), 每次服3克, 每日服3次(上海香山中医医院科研制剂)。

2. 血宁冲剂, 每次服1包, 每日服4次, 此药由重庆桐君阁药厂生产, 市上有售。

(三) 大咯血应予输液、输血。出现失血性休克者应急送医院抢救。

辨证分型治疗

(一) 肺热壅盛

咳血鲜红或痰血相兼, 咳吐黄痰, 胸满气急, 口渴心烦, 或伴发热。舌红苔黄, 脉滑数。治宜清热泻肺, 降逆止血。

方药: 桑白皮30克, 地骨皮30克, 银花30克, 连翘30克, 大黄10克, 黄芩30克, 黄连10克, 生石膏30克, 杏仁15克, 仙鹤草30克, 藕节15克, 侧柏叶15克。水煎服, 每日1剂, 连服5剂。

(二) 肝火犯肺

咯血鲜红, 从口涌出, 咳而气逆, 胸胁引痛, 烦躁易怒, 口苦, 目赤, 舌红苔黄, 脉弦数。治宜平肝清热, 降气止血。

方药: 蛤壳20克, 青黛10克, 桑白皮30克, 地骨皮30克, 龙胆草12克, 栀子10克, 大黄10克(后下), 黄芩10克, 侧柏叶15克, 茜草10克。水煎服, 每日1剂, 连服5剂。

(三) 阴虚内热

咯血鲜红, 反复发作, 咳嗽痰少, 或干咳无痰, 潮热盗汗, 五心烦热, 两颧发红, 口燥咽干, 舌红少津, 无苔, 脉细数。治宜滋阴清热, 润肺止血。

方药: 知母12克, 百合30克, 川贝6克, 生地30克, 麦冬30克, 玄参30克, 白芍20克, 旱莲草30克, 白及30克, 花蕊石30克, 阿胶10克。水煎服, 每日1剂, 连服7剂。

单方验方治疗

1. 十灰散（成药），每次服10克，每日服3次，冷开水冲服。
2. 三七粉，每次服2克，每日服3次，冷开水送服。
3. 云南白药，每次服1克，每日服3次，冷开水送服。

注意事项

（一） 宜避免紧张情绪或恐惧心理

血管破裂时，血管虽能反射性的收缩，使破裂口缩小以利止血，但其止血效果与血管内压力有明显关系。如果血管内压力较低时，则很快止血，如果血管内压力很高，则这种本能的止血作用明显减弱。绝大多数咯血病人，一见咯血就非常紧张，由此可引起不良后果，一方面使交感神经兴奋，心脏收缩力增强，心率加快，血管内压升高，而不利于止血；另一方面，过度紧张，可以诱发支气管痉挛，肺内残血排出困难，易造成窒息死亡。所以，大咯血病人，要尽可能消除紧张情绪和恐惧心理，保持安静，然后请医生救治或送医院抢救。

（二） 宜让肺内残血咯出

关于大咯血时咳嗽的利弊问题，有的患者担心咳嗽能加重破裂血管的出血，因而不敢咳嗽，也有的病人害怕咯不出肺内残血而引起窒息死亡，故反复剧咳。其实，这两种观点都有一定的片面性。首先，咳嗽是机体排出呼吸道异物（如血凝块）的保护性反应，如果抑制咳嗽，也就抑制了肺内残血的咯出。如肺内残血堵塞小的支气管将导致局限性肺不张。如堵塞大的气管可引起窒息死亡。因此，咯血时不敢咳嗽，非常有害。只有咯出肺内残血，保持气道通畅，才能避免窒息的发生。从另一方面来讲，咯血时是不是咳嗽用力越

大越好呢？当然也不是。这是因为咳嗽过程中，胸腔内压力总是出现一个由负变正的大幅度变化过程。当胸腔内压力为负时，回心血量增加，血管内压力增高；当胸腔内压力为正时，肺内毛细血管压力更高，易促使血管裂口增大，加重出血。所以，当咯血病人剧咳不止时，需要给予适当的止咳药抑制咳嗽以防止加重咯血。这似乎是矛盾的。其实，这正是大咯血病人自我保护的关键所在。当咳嗽反射受到抑制时，要有意识的主动咳嗽，以防止窒息。当某种刺激引起剧咳不止时，确实能加重咯血，此时应有意识地控制咳嗽，必要时可服用较有力的止咳药。但应在有经验的医生指导下服用。总之，咳嗽而不剧，排血防窒息，剧咳要抑制，以利咯血止。这就是大咯血病人的自我保护要点。

（三） 宜向患侧侧卧以利止血

大咯血病人一般应卧床休息，卧向患侧则更能有效地止血。因为卧向患侧时，出血灶受到健侧肺脏及纵膈的压迫，有利于止血，对于肺结核大咯血者，还可以防止带有结核杆菌的血液进入健侧肺，避免引起结核杆菌的播散。一般说来，哪侧胸部出现胸闷、胸痛或痰鸣音，哪侧就是患侧肺。

（四） 宜防止便秘

便秘往往是大咯血病人复发的主要诱因。便秘时，排便过程中腹肌强有力收缩，腹腔压力骤增，胸腔压力随之上升可诱发大咯血。因此，咯血患者宜多吃纤维素较高的水果、蔬菜等，防止便秘。必要时可服些缓泻药如少量大黄等，以防止诱发大咯血（大黄可通便止血）。

（五） 患者禁忌事项

1. 忌将咯出的血咽入胃内：临床上，引起咯血的最常见病因是肺结核，由肺结核引起的大咯血，血内多含有一定

量的结核杆菌，这种被结核杆菌污染的血液，对身体危害极大，如果将其咽下，就可能引起消化道结核病。有的大咯血病人，迷信所谓的“吐破咽补”的不科学的传说，为了“补身”而将肺内咯出的带有结核杆菌的血，全部咽入胃里，结果不但不能补身，反而引起了消化道结核病，这是非常有害的。

2. 忌过度劳累：患有肺结核、支气管扩张的患者，如不注意休息，过度劳累，往往可引起咯血。因此，患者应注意休息，保证充足的睡眠，性生活也不要过度，以防止咯血发作。

3. 忌不及时治疗上呼吸道感染：肺结核、支气管扩张、肺癌患者如不及时治疗上感这类“小病”，往往可引起咯血。因此，患者应予以重视，防患于未然。

6. 肺含铁血黄素沉着症

肺含铁血黄素沉着症是因肺毛细血管反复出血，渗出的血液中珠蛋白部分被吸收，含铁血黄素沉着于肺组织而引起的反应，可分为特发性和继发性肺含铁血黄素沉着症两类。

继发性肺含铁血黄素沉着症多见于风湿性心脏病并发二尖瓣狭窄患者。特发性肺含铁血黄素沉着症为少见的疾病。多发生在1~7岁的儿童，也见于成年人。其特征是反复咯血、咳嗽、呼吸困难和紫绀。

本病临床症状和病程取决于肺内出血的程度及期限。持续轻度出血者有慢性干咳、痰中带血、疲乏、面色苍白，患儿体重不增加。急性症状可持续数小时乃至数日。中度出血者除上述症状外，尚伴胸骨后或上腹部疼痛和胸部紧束感，

可有中度发热。若出血停止，在数周或数月内症状消失。但出血往往反复发生，此时患者有心悸、呼吸困难及严重贫血。有时发生大量咯血导致窒息。

由于铁从咯血中大量丢失，患者出现中等度缺铁性贫血，血清铁降低，冷凝集素试验可阳性，痰中可找到吞噬多量含铁血黄素颗粒的巨噬细胞，尿液中可出现蛋白及红细胞。

根据临床表现、X线检查，特别是痰中找到吞噬含铁血黄素的巨噬细胞，本病即可确诊。

肺含铁血黄素沉着症属于祖国医学的“咯血”范畴。热病伤阴或久病阴亏，阴虚火旺，导致热伤肺络，迫血妄行，血随气逆而咯血。本病病位在肺，病根在心、肾。肺为水上之源，水不清，凝为痰，痰不降而牵动血。《景岳全书》云：“血本阴精不宜动，动则为病，血主营血不宜损，而损则为病，盖动者多由于火，火盛则迫血妄行，损者，多由于气，气伤则血无以存”。由于本病多属阴虚肺热，治宜清肺凉血，益气养阴，活血化痰。

方一：沙参30克，百合30克，连翘10克，麦冬30克，黄芩15克，丹皮12克，炒山栀10克，茅根30克，藕节15克。水煎服，每日1剂，连服1个月。

方二：大黄醇提片，每次服3片，每日服3次，视病情轻重及大便次数多少而调整用量，一般为每次2~4片，每日服3次，直至咯血停止。

肺与大肠相表里，由于大黄有缓泻诱导作用而使血液下行，减少了上部特别是肺部的充血而达到止血的目的，也即发挥了大黄活血止血的药理作用。

方三：沙参30克，当归30克，赤芍30克，川芎10克，五

味子10克，淮牛膝30克，桃仁10克，白芨30克。水煎服，每日1剂，连服两个月。并需配合用下列单方：

干蕺菜80克，煎水取汁，煮鸡蛋1个，每日早晨服，连服两个月。

蕺菜性凉味辛，清热解毒，为治痰热壅肺，肺壅吐脓血之要药。现代药理证实蕺菜有镇痛、止咳、止血，抑制浆液分泌，促进组织再生等作用，还能防止毛细血管的脆性，增强人体白细胞的吞噬功能。鸡蛋是培补佳品。蕺菜蛋既有祛除病邪功效，又有扶正固本作用。肺含铁血黄素沉着症患者常服蕺菜蛋，久之自见功效。

7. 迁延性肺嗜酸粒细胞浸润症

迁延性肺嗜酸粒细胞浸润症，又称慢性嗜酸粒细胞性肺炎，属于肺嗜酸粒细胞浸润症的一种类型。临床特点是血嗜酸粒细胞增多，伴有呼吸系统症状如咳嗽、胸闷、气急、哮喘。X线检查，肺部有斑片、云雾状的散在或游走性浸润灶。

病因多与过敏有关，如寄生虫感染、药物反应、吸入某些花粉等。

临床表现：发热，体温38~40℃。热型不规则，有的患者夜汗甚多，体重下降，咳嗽明显，咳粘痰，个别有呼吸困难。

周围血象嗜酸粒细胞大都增高至20~40%，白细胞总数常在10000/立方毫米以上。

迁延性肺嗜酸粒细胞浸润症属于祖国医学的“咳嗽”、

“哮喘”范畴。中医认为系痰湿阻肺，肺气不宣所致。《症因脉治》说：“外感风寒，皮毛受邪，郁于肌表，则身热而喘逆”。《太平圣惠方》说：“邪气与正气相搏，不得宣通，胸中痞塞，痰饮留滞，……昼夜常嗽，不得睡卧也”。其治疗，宜疏风清肝，润肺止咳。

方一：柴胡30克，黄芩30克，生石膏30克，麻黄6克，杏仁15克，大青叶30克，桑白皮15克，鱼腥草30克，石苇30克。水煎服，每天1剂。连服30剂。

方二：杏仁15克，防风12克，生姜10克，白术30克，茯苓30克，苏叶12克，柴胡30克，白芍40克。水煎服，每天1剂。连服30剂。

方三：冬瓜子30克，苡仁30克，大黄10克，丹皮15克，赤芍30克，黄芩30克，黄芪30克，地龙30克，青黛10克。水煎服，每天1剂，连服30剂。

鉴于迁延性肺嗜酸粒细胞浸润症经治疗数日症状即见好转，2~4周内肺部X线病灶也可能消失，但停药后较易复发。因此，当患者症状好转、肺部X线病灶消失后，还宜常服抗过敏、扶正气的黄芪建中丸等，以巩固疗效，防止复发。

8. 幽门梗阻

十二指肠球部溃疡或幽门溃疡可引起幽门痉挛，溃疡的周围组织可有炎性水肿，均能妨碍幽门过道的通畅，造成暂时性的幽门梗阻。随着溃疡好转，这种暂时性的幽门梗阻即可消失。在溃疡愈合时，可因疤痕形成或与周围组织粘连而

引起持久性的器质性幽门狭窄致幽门梗阻。幽门梗阻多见于溃疡病，癌肿也能引起幽门梗阻。

幽门梗阻的临床症状表现为餐后上腹部饱胀疼痛，常伴有胃蠕动波、蠕动音、拍水声，后期无蠕动波，但可见扩大的胃型轮廓。往往有大量呕吐。吐后，上述症状可减轻或缓解。呕吐物多为不消化食物。严重者可引起失水、电解质紊乱、酸碱平衡紊乱和营养缺乏。

幽门梗阻属于祖国医学的“胃反”、“呕吐”范畴。中医认为，“人身以胃为主，赖之以容受五谷，但有所伤，非不能食，且有呕吐之患”（《医方类聚》）。“人之阴阳升降，三焦调顺，脾胃和匀，乃能腐熟水谷，变化糟粕，…若脾胃虚冷，水谷不化，则阴阳否隔，三焦不调，浊阴之气，不能下行，奔冲于上，故发为呕吐”。中医认为幽门梗阻的发病机理主要是中虚有寒，命门火衰，不能腐熟运化水谷，胃失和降，久而尽吐而出，甚则食下昼夜而吐出。正如《圣济总录》所说，“日久反出，是无火也”。其治疗，宜和胃降逆，消食破积。

方一：白术10克，制附片10克（先熬），藿香10克，神曲10克，干姜6克，肉桂6克，砂仁6克，姜半夏15克，炙甘草5克。水煎服，每天1剂，连服6剂。

加减：上腹部胀痛甚加厚朴、大腹皮各10克，伴有烧灼感者加黄连6克。

方二：桃仁15克，柏子仁15克，郁李仁15克，制大黄15克，郁金20克，槟榔15克，厚朴15克，柿蒂10克，木香10克，法半夏15克，水煎服，每日1剂，连服6剂。呕吐严重者可分多次频频饮服。

方三：代赭石30克，枳实10克，大黄6克，玄明粉10克

(冲服)，葶苈子15克，防己10克，椒目10克，玄参12克，芦根30克。水煎服，服后可泻下硬粪，再用黄芪建中汤调理。

方四：芒硝、大黄、甘草各5克，共放入带盖茶杯，加开水200毫升冲泡，15分钟后饮用，首次将药液饮下，以后续泡当茶饮，鼓励多饮，每日1剂。饮后可泻下积粪，随着大便通调而腹胀呕吐等症状缓解。

9. 胃术后功能性排空障碍

胃术后功能性排空障碍，又名吻合口排空障碍，是胃部分切除术后一种并非罕见的近期并发症，其发生率约为3~4%。症状多在胃术后数日由流食改为半流食时出现，但也可在开始进食时即发生。

临床表现：进食后上腹部有膨胀感，频繁的溢出性呕吐。呕吐物为所进食物和含胆汁或不含胆汁的大量液体。有时上腹部可扪到有压痛的包块。如放置胃减压管则可吸出大量液体而症状消失，但停止减压再进食后症状又出现，一般持续10~20日后始自行缓解，在少数情况下可长达30~40日。症状一旦开始缓解，胃排空障碍很快消失，2~3日内即可进食通畅无阻。

X线检查可见输出袢空肠痉挛，吻合口水肿。

胃术后功能性排空障碍，属于祖国医学的“呕吐”范畴。系由脾胃气伤，中阳失运，水饮停胃所致。手术对机体无疑是一种创伤，必然累及气血的运行，而气血的瘀滞则可直接导致水饮的停聚，所谓“气壅即水塞”，“血不利则为水”。水

饮中阻，胃失和降，致成呕吐。其治疗，宜理气通腑。

方药：姜半夏15克，生姜10克，竹茹10克，猪苓10克，芦根20克，苡仁20克，太子参10克，木香10克，陈皮10克，甘草6克，加水浓煎，能口服者少量多次口服。不能口服者将浓煎的药汁（100~200毫升）从胃管内注入，保留1小时，日服3~4次，连服10~20天。或将药液作直肠灌注亦可。同时，应配合禁食、胃肠减压、支持疗法等。

方中的半夏燥湿化痰、降逆止呕；生姜温中和胃，走而不守，两药协同，实有散饮止呕的功效。现代药理研究认为，半夏的止呕作用主要与抑制呕吐中枢兴奋有关，与生姜配伍，则有消除胃肠瘀积，缓解平滑肌痉挛的作用。

（此部分文字在原文中较为模糊，推测为关于半夏药理作用的进一步说明，但无法准确转录，故在此处省略。）

（此部分文字在原文中较为模糊，推测为关于半夏配伍的进一步说明，但无法准确转录，故在此处省略。）

10. 多发性胃息肉症

（此部分文字在原文中较为模糊，推测为关于胃息肉症的定义，但无法准确转录，故在此处省略。）

胃息肉症是指胃部分粘膜或全部粘膜表面散布着大量致密的大小不等的息肉，可分真性和假性两种。假性息肉症为炎症粘膜增生而形成。真性息肉症是新生性腺瘤样息肉病，由于易发生恶变，而被认为是癌前病变。

胃息肉症多发生于年龄较大者，男性较多见。由于多伴有胃酸缺乏或低下，因而常有上腹不适，恶心，厌食，消化不良，腹泻，体重下降，腹胀，失眠等症状。较大息肉偶可滑入幽门管引起梗阻症状。息肉表面糜烂可发生出血。X线钡餐检查常可见胃内有多数斑点状充盈缺损。纤维光束胃镜检查 and 活体组织检查对于本病的确诊极有帮助。

祖国医学无“多发性胃息肉症”病名，根据其临床表现似属“瘤”的范畴。《圣济总录》说：“瘤之为义，留滞而不去”

也，气血流行不失其常，则形体和平，或无余赘，及郁结壅塞，则乘虚投隙，瘤所以生。”中医认为瘤的病因不外乎外因和内因两个方面。外因是外感邪毒，内因是正气不足，阴阳长期失调（免疫降低），郁瘀壅结而形成。治宜扶正固本，软坚化瘀散结。

方药：沙参30克，百合30克，苡仁30克，苍耳子10克，海藻30克，枸杞15克，知母10克，杜仲15克，柏子仁30克，夜交藤30克，生谷芽20克，地鳖虫10克。水煎服，2日1剂，须连服40~60剂。

方中沙参、百合、知母、生谷芽甘寒养胃，苡仁健脾祛湿，百合、知母与夜交藤同用又能润肺养心安神，杜仲、枸杞补肾填精，增强机体抗病能力，苍耳子有疗恶肉之功，海藻主治瘰瘤结气，地鳖虫破瘀消积，生谷芽开胃进食，与沙参等相伍还能顾护胃气。综观全方，既有扶正固本，健脾补肾养阴之品，又有破瘀散结，活血化瘀之药，攻补兼施，药证合拍。

由于本病系痰气郁结，郁久化热所致，病程较长，因而疗程应相对延长，宜守方长服，不可功亏一篑。

11. 胃 痉 挛

胃痉挛，表现为胃部突然剧痛，持续性呈抽掣样疼痛，夜间尤甚，发作时喜按，腹软，剑突下有明显压痛，胃脘部可隆起，肌张力增加，不发烧，无呕吐腹泻。发作时患者双腿微屈，辗转反侧，汗出，面色苍白，痛楚异常。痉挛时间

最长可持续3天，最短持续疼痛2小时。胃镜检查或X线钡餐检查可确诊（无器质性病变）。

胃痉挛属于祖国医学“胃脘痛”范畴。中医认为系寒气客于胃腑，气血郁滞，和降失司。《局方发挥》说：“中寒则仓卒感受，其病即发而暴……”。《景岳全书》说：“……寒气客于胃肠之间则卒然而痛……”。其治疗，宜温阳散寒，理气止痛。

中药治疗

方一：高良姜10克，吴萸10克，砂仁6克，木香10克，香附15克，厚朴15克，苏梗10克，法半夏10克，丹参30克，白芍30克，甘草10克，鸡内金15克，檀香3克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

全方温阳散寒，理气活血，宽胃畅中，理气止痛，缓急解痉，疗效可靠。

方二：白芍60克，生甘草10克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

白芍柔肝养血，缓急止痛，甘草也能缓急止痛，为治疗胃痉挛的有效良方。科学实验证明，芍药甘草汤对横纹肌、平滑肌的挛急，不论是中枢性的或末梢性的，均有镇静作用，不论对表在性的躯体和四肢的横纹肌有缓急止痛作用，而且对深在的平滑肌性的脏器如胃、肠、输卵管、子宫、膀胱、尿道或血管等也有缓急止痛作用。

针灸治疗

（一）针刺承山，深1.5~2寸，平补平泻，留针40分钟，每10分钟行针1次。

（二）针刺鸠尾穴，向下方斜刺，深1.5寸，得气后，再针刺中脘，得气后，再针刺足三里。每穴均留针30分钟。

每10分钟行针1次。

推拿按摩治疗

按揉小野氏点。小野氏点为日本小野氏所创用，位于髌骨前上嵴与髌胫关节上端连一直线，再从髌骨最顶缘中心向该线垂直的交点。治疗时右侧点较左侧点敏感。定准此点后，用拇指腹顺时针方向用力按揉。局部即出现有酸麻胀沉的按揉效应，并可向下肢发生感传。当感传达到小腿足跟部时，胃痉挛的剧痛可缓解。此法安全有效。

12. 急性单纯性胃炎

急性单纯性胃炎是急性胃炎的一种，可由化学刺激、物理刺激、细菌或细菌毒素等引起。化学刺激包括饮烈性酒、咖啡、浓茶、辛辣食物和浓郁香料等，均可损伤胃粘膜，发生炎变。物理刺激包括摄入过烫和过于粗糙的食物，以及胃放射治疗、胃冷冻治疗造成胃粘膜损伤，引起炎性改变。临床上最常见的急性单纯性胃炎多由于饱餐、酗酒所致，或由于被污染食物中的细菌或其毒素所引起，特别是沙门氏菌引起中毒为常见。沙门氏菌属常在家畜、家禽、肉、鱼、蛋中生长（特别是皮蛋）。这些食物可在生产、制作过程中被病菌污染。

某些药物如水杨酸盐类、磺胺药、抗生素、毛地黄、氯化钡、氨茶碱等均可刺激胃粘膜，引起急性单纯性胃炎。

临床表现：由于酗酒、刺激性饮食或药品引起的单纯性胃炎，多有腹痛、恶心、呕吐等症状，一般不很严重。细菌

性感染所致的急性单纯性胃炎一般在进食后数小时至24小时内发病，表现为腹痛，甚至剧烈的腹绞痛，恶心，呕吐，水样腹泻，严重者可有发热，失水，酸中毒，休克等。

急性单纯性胃炎属于祖国医学的“胃脘痛”、“泄泻”范畴。《明医指掌》说：“热厥心痛（指胃痛）者，其人必纵酒，蓄热在胃，偶遇寒邪而发”。《医学正传》说：“致病之由，多因纵恣口腹，喜好辛酸，恣饮热酒煎燂，复餐寒凉生冷，朝伤暮损……妨碍升降，故胃脘疼痛”。中医认为本病多由饮食生冷饱败，寒滞伤中，胃阳窒痹，中焦运化受阻。其治疗宜和胃降逆，温中止呕。

中药治疗

方一：干姜6克，丁香6克，制大黄6克，青皮10克，陈皮10克，焦山楂30克，神曲30克，莱菔子15克。木香10克，法夏10克。水煎服，每日1剂。连服5~7剂。

加减：呕吐甚者加生姜10克、竹茹10克。发热加黄芩30克、连翘30克。腹泻加秦皮30克、苦参30克。

方二：藿香10克，佩兰10克，法夏10克，厚朴10克，枳实10克，柴胡10克，木香10克，麦芽30克，竹茹10克，陈皮10克，香附10克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

针灸治疗

针刺足三里、中脘、内关、太冲、曲池。隔姜艾灸脐中。

耳针取穴胃、脾。

治疗急性单纯性胃炎，必须去除病因，卧床休息，大量饮水。饮食护理尤为重要。《医学入门》说：“疼止恣食即发。故疼时必须暂时禁食，只喝淡盐水或糖水。服药止疼后，胃气渐苏，只予稀粥及菜汁，半饱而止。”《医编》指

出：“呕吐，津液既出必渴，宜生津”。说明补充水液对治疗急性单纯性胃炎具有重要意义。

13. 急性出血性糜烂性胃炎

急性出血性糜烂性胃炎，是一种以胃粘膜糜烂和出血为特征的胃炎。又称急性糜烂性胃炎、急性出血性胃炎、急性胃粘膜出血。本病的诱发因素有：①服用某些药物如水杨酸制剂（尤其是阿斯匹林）、保泰松、消炎痛，肾上腺皮质激素、抗生素、洋地黄、利血平、组织胺等均可诱发本病。②酒精中毒也可诱发本病。③严重创伤、败血症、严重灼伤、大手术、恶性肿瘤均可诱发本病。

临床表现：上消化道出血（呕血、黑便）是出血性糜烂性胃炎的主要表现。其出血呈间歇发作，这与溃疡病有别。半数以上病人有消化道症状如上腹部不适、疼痛、食欲减退、头昏、软弱。上腹部可有压痛。如果使用肾上腺皮质激素可掩盖症状。

本病须经胃镜检查方能确诊。

急性出血性糜烂性胃炎属于祖国医学的“吐血”、“呕血”、“黑便”范畴。血由胃来，从口而出，常夹食物残渣。大便色黑如漆，甚则呈暗红色。中医认为急性糜烂性胃炎的病因病机多由饮食不节，胃中积热，情志失和，肝郁化火，致火盛气逆，迫血妄行。其治疗，宜清热泻火，降气止血。

急救处理

1. 严重出血者应禁食，绝对卧床休息，取平卧位，床

上大小便，注意适当保暖。

2. 止血措施

方一：大黄醇提片（粉），每次服3~6克，日服3次，冷开水送服（上海香山中医院研制）。

方二：血宁冲剂1包，每日服4次（成都中医学院附属医院研制，重庆桐君阁药厂生产）。

辨证分型治疗

1. 胃中积热：吐血紫暗或呈咖啡色，甚则鲜红，常混有食物残渣，大便色黑如漆。口干口臭，喜冷饮，或胃脘胀闷灼痛。舌红苔黄，脉滑数。治宜清胃泻火，降逆止血。

方药：水牛角屑30克，生大黄10克，黄连10克，茜草根10克，丹皮15克，地榆10克，虎杖30克。水煎服，每天1剂，连服5~7剂。

2. 肝火犯胃：吐血鲜红或紫暗，大便色黑，胃脘痛，口苦目赤，心烦易怒，失眠多梦，舌红苔黄，脉弦数。治宜清肝泻火，降逆止血。

方药：龙胆草12克，栀子10克，丹皮10克，夏枯草30克，黄芩30克，生地30克，侧柏叶15克，地榆15克，旱莲草30克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

单方治疗

三七粉6克（全天量），冷开水送服（分3次服，每次服2克）。连服5~7天。

14. 慢性糜烂性胃炎

慢性糜烂性胃炎系慢性胃炎的一个特殊的类型，又称之

为持续糜烂性胃炎，也称之为慢性胃粘膜糜烂。本病多发生在40岁以上，以50~60岁之间最多，30~70%合并有十二指肠溃疡、胃溃疡或其他胃炎。临床上可有消化道症状如反复胃痛，痛连胸胁，口干口苦，暖气，泛酸，腹胀，纳呆等，还可有胃出血，也可毫无自觉症状。现代医学认为，胆汁返流胃内，破坏胃粘膜屏障，是导致胃粘膜糜烂的原因之一。胃镜检查可见胃粘膜呈丘疹样或疣状隆起。直径5~15毫米，顶端有脐样凹陷，中心部有糜烂形成，也可见炎性渗出性病变，隆起不明显，呈斑点状，中央凹陷浅。

糜烂性胃炎属祖国医学“胃脘痛”范畴。中医认为多与情志失调及饮食所伤有关。饮食不节，损伤脾胃，肝气郁结，横逆犯胃，胃失和降，是导致本病的主要病因病机。《症因脉治》说：“内伤胃脘痛之因：饮食不节，伤其胃口，太阴升降之令凝结壅闭，则食积之痛作矣；脾胃素弱，日饮水谷不能消受，停积中脘，则成痰饮而痛；七情六欲之火，时动于中，膏粱炙搏之热，日积于内，热久成燥，积热之痛作矣；……怒则气上，思则气结，忧思日积，气不宣行，则气滞而成痛……”。慢性糜烂性胃炎的治疗，宜疏肝，和胃，健脾，清泄胃热。

辨证分型治疗

1. 肝胃不和：胃脘胀痛，痛连胸胁，暖气泛酸，口干口苦，或恶心呕吐，大便秘结，舌红苔薄黄，脉弦数。治宜疏肝和胃。

方药：柴胡15克，白芍15克，枳实10克，甘草10克，郁金15克，大黄6克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

2. 脾胃湿热：胃脘胀痛满闷，食后腹胀，心烦，泛酸，口臭粘腻，大便不爽，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜清泄

胃热。

方药：苡仁30克，杏仁12克，白豆蔻10克，藿香10克，佩兰10克，泽泻30克，猪苓30克，山梔10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

3. 肝郁脾虚：胃脘隐痛，胸胁胀满，食后腹胀，纳差，神疲乏力，暖气，口苦，便溏，舌淡苔白，脉细无力。治宜疏肝健脾。

方药：柴胡10克，木香10克，砂仁6克，党参30克，白芍15克，白术15克，茯苓15克，甘草10克，枳实10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

4. 脾虚胃热：胃脘灼痛，嘈杂不适，饥不欲食，食后腹胀，口干苦，神疲乏力，便秘便溏交替出现，舌淡苔薄黄，脉弦细。治宜健脾清胃热。

方药：法夏10克，黄芩15克，黄连10克，瓜蒌15克，生石膏30克，山楂30克，麦冬15克，神曲30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

15. 十二指肠壅积症

十二指肠壅积症是指由各种原因引起十二指肠远端或十二指肠空肠交界处的梗阻，以致十二指肠近端扩张，内容物壅积，从而产生的一种临床综合征。

引起十二指肠壅积的原因有某些肠道疾病、胃部疾病、胆囊疾病、胰腺疾病及某些肾脏疾病、血管疾病、肿瘤等。

十二指肠壅积症可发生于任何年龄，女性多于男性，且多见于体型纤瘦者。病程较长，可达10年以上，多呈间歇发作。主要症状有：

1. 呕吐：进食后呕吐是十二指肠壅积症的特征，呕吐量多，呈喷射状，吐出物有宿食及胆汁。呕吐后疼痛减轻或消失。

2. 疼痛：多为上腹部疼痛或脐部疼痛（绞痛），多数病例仅感上腹部闷痛、胀痛。多于餐后1~4小时出现。体位改变时（如俯卧或膝胸位）可使疼痛明显减轻。

此外，尚有嗳气、恶心、腹胀、肠鸣、贫血、消瘦、偏头痛、荨麻疹等伴随症状。严重者失水，电解质和酸碱平衡紊乱。本病经X线检查可确诊。

十二指肠壅积症属于祖国医学的“呕吐”、“胃脘痛”范畴。《素问》说：“所谓食则呕者，物盛满而上溢，故呕也”。《三因极一病证方论》说：“病者胸腹胀闷，……食入即呕，……名曰食呕”。《明医指掌》说：“食郁，停宿食不克化，新壳不化而反出，……”《证治准绳》说：“……膈咽不通，食则为食痹者，谓食已心下痛，吐出乃止。”。中医认为十二指肠壅积症系脾胃虚弱，瘀阻胃络。治宜活血通络，益气和中。

方药：小活络丹（成药），每次服一丸，每日服三次。服用五天后改服补中益气丸（成药），每次服10克，每日服三次，连服10~15天。并练简易气功（意守丹田，适当作深呼吸，舌抵上腭）调理。

16. 浅表性胃炎

浅表性胃炎是慢性胃炎的一种类型。有时可与萎缩性胃炎同时存在。胃镜检查有时在胃的下部见到浅表性胃炎，而在胃上部为萎缩性胃炎。此种病症也称为浅表-萎缩性胃炎。浅表性胃炎有可能完全治愈，也可转变为萎缩性胃炎。

多数浅表性胃炎患者无症状，有些患者有腹胀（饭后上腹部感觉不适，有饱满及压迫感）、泛酸、嗝气等自觉症状。少数患者有食欲减退、恶心、腹部灼痛等症状，但呕吐较少见。轻型浅表性胃炎钡餐检查很少有阳性发现。浅表性胃炎经胃镜检查可以确诊。胃镜检查显示粘膜充血，有时可见到糜烂和出血点，粘膜表面有大量粘液。

浅表性胃炎属于祖国医学的“胃脘痛”范畴。《东医宝鉴》说：“胃伤之证，不思饮食，胸腹胀痛，呕哕恶心，噫气吞酸……”，中医认为多系肝胃气滞，脾失健运所致。其治疗，宜以理气为主，正如《景岳全书》所说：“……当以理气为主……，食滞者兼乎消导，寒滞者兼乎温中，若因气逆则理其气病自愈矣”。

中药治疗

方一：滑石，元胡，甘草各等份，研细末，和匀，过细筛，装空心胶囊，每囊装0.5克。成人每次服3~5克，每日服3次，开水吞服，40天为1疗程。

方二：白术15克，党参30克，茯苓15克，甘草10克，白芍15克，元胡10克，佛手10克，枳壳10克，鸡内金10克。水

煎服，每日1剂，连服30剂。

方三：三九胃泰（成药），照说明书的剂量服用，连服30天。

按摩治疗

1. 用力按揉内关（双侧）、足三里（双侧），操作5～10分钟。

2. 用力推三阴交至阴陵泉（双侧），操作5～10分钟。

3. 用力按压肝俞、脾俞、胆俞、胃俞、膈俞，每穴按压1分钟。按压后施以轻揉，以消除按压的酸胀不适感。

4. 拇指点按中脘穴，中指点按天枢穴，操作1～2分钟。

5. 病人仰卧，医生坐其侧，以掌心置神阙穴上，以脐为中心，先作顺时针方向旋转5～10分钟，再作逆时针方向旋转团摩5～10分钟。手法宜轻柔，旋转团摩频率宜慢。这种治疗方法应在饭后1小时后施行。

6. 病人直坐，医生站其侧，医生以一手掌心置于患者胸骨璇玑穴处，另一手掌心横置于背部上方大椎穴处，自上向下沿胸、背正中线各摩动至胸前中脘穴处及背部下方至阳穴处止，反复操作3～5分钟。操作要领为：两手在胸、背前后应同时摩动。操作时用力应均匀而有节律。

17. 胃 窦 胃 炎

胃窦胃炎属慢性胃炎。近年来，有不少学者主张将慢性胃炎按解剖部位分为胃体（底）炎和胃窦炎两种。其理由是

胃体（底）部粘膜的腺体主要分泌盐酸与蛋白酶，与只分泌粘液和胃泌素的胃窦部在腺体结构上和功能上很不相同。

胃窦胃炎的临床表现：病程迁延，部分患者可无任何自觉症状，但大多数患者可有程度不同的消化不良症状。上腹部疼痛和不适是主要症状，疼痛的性质不一，可为饥饿样不适感、钝痛、胀痛、灼痛等。疼痛可于晚间睡前或半夜出现。嗳气，泛酸，恶心，呕吐可单独出现或伴同疼痛出现。可有反复的上消化道出血及消瘦、贫血。

胃窦胃炎可通过胃镜检查及X线钡餐检查确诊。

胃窦胃炎属于祖国医学“胃脘痛”范畴。《临证指南医案》说：“阳明乃十二经脉之长，其作痛之因甚多。盖胃者，汇也，乃冲繁要道，为患最易。虚邪贼邪之乘机窃发，其时消长不一，……”《灵枢》说：“寒温不适，饮食不节，而病生于肠胃”。中医认为胃窦胃炎多因饮食不节，嗜食生冷辛辣，损伤脾胃所致。脾胃升降失常，寒热互结，中焦痞阻，枢机不利。治宜调和胃气，健脾通络。

方一：法半夏15克，黄芩10克，黄连10克，甘草10克，干姜10克，党参30克，大枣30克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

加减：痛甚加玄胡、五灵脂。呕吐泛酸减干姜、甘草、大枣，加竹茹、吴茱萸、乌贼骨。热重湿甚减干姜、大枣，加佩兰、藿香、茵陈、木通。嗳气呃逆加旋覆花、代赭石、柿蒂。上腹饱胀减甘草、大枣，加厚朴、木香。纳差加山楂、神曲。便秘加大黄。

方中半夏干姜辛开温里散寒，党参甘草大枣益气健脾。全方寒温并用，补而开泄，使胃气得和，寒热调平，痞阻自除。

方二：百合30克，乌药10克，当归10克，川芎10克，玄胡10克，香附10克，白芍30克，白术10克，茯苓10克，五灵脂12克，威灵仙12克，三七粉6克（冲服），生蒲黄10克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

18. 结肠息肉

结肠息肉有家族遗传特点，且与肠癌关系密切。患者有腹泻、腹痛腹胀、便血和粘液便。息肉局限于结肠内，可波及整个结肠粘膜，但很少发生于小肠。息肉为腺瘤样息肉，呈多发性，也有单发者。

结肠息肉的病因迄今尚未明了，多认为是结肠慢性炎症刺激增生所致。

结肠息肉经X线检查及结肠纤维镜检查可确诊。

结肠息肉属于祖国医学“泄泻”范畴。中医认为系湿阻中焦所致。《金匱要略心典》说：“中湿者，亦必先有内湿而后感外湿，故其人平日土德不及而湿动于中，由气化不速而湿浸于外，外内合邪”。说明外湿与内湿在发病机理上是密切相关的。湿浊久留，困阻脾土，影响运化。湿郁化热，内阻肠道，气机失畅。其治疗，宜燥湿健脾。

方一：黄芩30克，黄连10克，黄柏10克，苍术30克，草果10克，砂仁6克，白蔻10克，木香10克，厚朴10克，枳实10克，槟榔10克，莱菔子10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方二：云南白药4克，锡类散0.6克，温水100毫升。将

上药用温水溶解，作保留灌肠，每次30分钟，每晚睡前灌1次，2周为1疗程，需治疗1~3疗程。并内服活血化瘀方药：归尾30克，桃仁10克，红花10克，三棱10克，莪术10克，赤芍30克，苡仁30克，银花30克，黄芪30克，鸡内金15克。水煎服，每日1剂，连服14~45剂。

19. 伪膜性肠炎

伪膜性肠炎，又称假膜性肠炎，是一种肠道急性炎症。多见于抗生素应用后和手术后引起肠道菌群失调所致，但也有因结肠梗阻或心肾疾病而发病的。伪膜性肠炎的特点是限于粘膜坏死和假膜形成。肠粘膜表面有许多局限病灶，严重时整个肠段全为假膜所覆盖。

多数病人在应用抗生素或手术后1周内出现症状。腹泻是最突出的症状，典型大便呈淡绿色或“蛋花汤”水样便，含有许多粘液和脱落的假粘膜，轻型者多不呈血性，隐血试验也往往为阴性。腹泻次数可随病程的发展而增多，以致大量的体液丢失，引起脱水和电解质紊乱。

轻症病人除腹泻外，尚有体温升高，脉数，腹胀腹痛，恶心呕吐。重症病人，起病即有高热，严重腹泻、呕吐和腹肌紧张，数小时内即出现休克（休克前腹泻症状反而不突出），呕吐物和大便内可含血，死亡率很高。

近年来，由于临床上大量使用广谱抗生素，致使肠道菌群失调，继发伪膜性肠炎相应增加。肠道内的杆菌被抑制，耐药的金黄色葡萄球菌迅速繁殖，产生大量的凝血浆蛋白毒

素，引起整个或部分肠粘膜损害，以致出现细菌及其毒素所引起的感染、毒血症、急性肠炎、脱水、休克等严重的全身症状。

凡应用抗生素后和手术后出现腹泻，出现典型的淡绿色和蛋花样水样便，伪膜涂片检查找到大量革兰氏阳性球菌，结合乙状结肠镜检查，即可确诊本病。

伪膜性肠炎属于祖国医学“泄泻”、“濡泄”、“飧泄”等范畴。本病的发生，多由湿热中阻，升降失司，清浊不分以致倾泻无度。其治疗，宜分利清浊，清热解毒，健脾利湿。

辨证分型治疗

(一) 热毒炽盛：高热烦渴，倾泻暴注，下利色青或蛋花样水稀便，衄血，尿短赤，舌红苔黄脉数。治宜清热解毒。

方药：银花30克，连翘30克，蒲公英30克，败酱草30克，黄芩30克，黄连10克，紫花地丁30克，大青叶30克，栀子10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。另服安宫牛黄丸1粒、紫雪丹1支。

(二) 热盛阴耗：素体阴亏，或术后产后，高热不退或日晡潮热，便稀泻频作，口干欲饮或不欲饮，五心烦热，颧红，尿短赤，舌红无苔脉细数。治宜益气养阴，清热解毒。

方药：西洋参10克，元参30克，生地30克，麦冬30克，石斛30克，丹皮15克，青蒿30克(后下)，败酱草30克，茅根30克，连翘15克，黄芩30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

(三) 脾虚湿盛：腹泻频频，面色晄白，口渴不欲饮，食少纳呆，神疲懒言，或见畏寒怕冷，浮肿，苔白，脉沉细。治宜健脾利湿。

方药：党参60克，猪苓20克，泽泻30克，白术20克，山

药30克，扁豆12克，麦冬30克，五味子15克，苍术20克，吴茱萸10克，葛根30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

(四) 阳虚欲脱：腹泻暴注，四肢逆冷，形体清瘦，畏寒蜷卧，腹胀，下肢浮肿，肛门外翻，舌卷，阴囊收缩，脉微欲绝。治宜回阳救逆。

方药：制附片15克(先熬)，干姜10克，党参30克，茯苓30克，白术15克，红参10克，吴茱萸10克，葛根30克。加水急煎频服，每日1~2剂，连服3~7天。病情危急者应静脉注射参附针(无参附针也可用参麦针)。

20. 肠 痉 挛

肠痉挛是由肠壁平滑肌强烈收缩引起的阵发性腹痛。检查胃肠无器质性病变，也非其他疾病引起。

临床表现：患者突然剧烈腹痛，呕吐，腹胀，但症状持续时间较短，一般不超过数小时，呕吐物为胃内容物，从无“呕粪”症状，症状消失迅速，恢复后即无任何不适。发作时X线腹部平片检查可见肠内积气，结肠积气尤为明显。患者常有多年来类似发作的历史，每次发作经注射止痛或抗痉挛剂后可自行消失。全身营养状况并无不良改变。有的病例曾因误诊为急性肠梗阻而施行手术，术后症状仍然发作。小儿肠痉挛时，可出现阵发性哭闹，一般持续时间不长，发作也无规律，与早期肠套叠易混淆。事实上个别患儿肠痉挛就是肠套叠的前驱病变。

诊断肠痉挛的主要依据为突然发作和突然消失的间歇性

剧烈腹痛，肠蠕动音减弱但不消失，无明显腹胀，腹部无肿物，无压痛，无便血。X线腹部平片检查对鉴别诊断有较大帮助。

肠痉挛属于祖国医学的“腹痛”、“呕吐”范畴。中医认为多系气滞寒痛。《素问》说：“寒气客于肠胃之间，…小络引急故痛”。《医学启源》说：“寒主拘缩，故急痛也，寒极则血脉凝涩，故坚痞而腹痛也”。《东医宝鉴》说：“寒气客于脉外则脉寒，脉寒则缩卷，缩卷则脉绌急，绌急则外引小络故卒然而痛”。中医还认为，小儿肠痉挛多因小儿脏腑幼嫩，形气未充，易受寒邪侵袭，或脏腑气血失调而发生。其治疗，宜温中散寒，行气止痛。

方一：香附15克，干姜12克，白芍60克，甘草10克，玄胡12克，陈皮12克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

方二：高良姜15克，木香10克，川楝子12克，吴茱萸12克，白芍60克，甘草10克，青皮10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

21. 慢性肠套叠

一段肠管套入其相连（相邻）的肠管腔内称为肠套叠。肠套叠可分为原发性和继发性两种。原发性肠套叠病因不明，目前一般是以痉挛学说来解释。婴儿肠痉挛除体质上的特点外，最可能与食物过敏有关。此外，原发性肠套叠也可并发于手术后、蛔虫病、过敏性紫癜等。原发性肠套叠多见于6个月至1.5岁的婴儿。

继发性肠套叠则是由于肠腔内的肿物（如息肉、肿瘤、先天性回肠憩室内翻、阑尾残端翻入）被蠕动推至远侧而将肿物所附着的肠壁折叠带入远侧肠腔所致。可发生于任何年龄。

肠套叠可分为急性、亚急性、慢性三种类型。婴儿肠套叠以急性为常见，肠痉挛缺血严重而持续，可造成急性肠梗阻。亚急性肠套叠多见于2~3岁以上幼儿，肠痉挛不严重且持续时间不长，所造成的肠梗阻为不完全性。慢性肠套叠多见于成年患者，只是近端肠管的套入，基本上无严重痉挛，也无肠梗阻。

急性和亚急性肠套叠应到医院作灌肠治疗或手术治疗。成人慢性肠套叠可用中药治疗（不愿手术者）。

肠套叠的症状如下（急性、慢性肠套叠均可出现，只是程度不同）：

1. 腹痛：为阵发性绞痛，发作比较有规律，约每20~60分钟发作一次。

2. 便血：呈红果酱样。大约腹痛6小时后开始便血。最初混有黄色大便，排便2~3次后，很快完全成为小量红果酱样血便。

3. 肿物：为光滑短粗的香肠样，一般为2厘米直径，长5厘米，多位于脐右上方，亦可出现于腹部任何部位，有一定的活动度，发作时肿物较固定而硬。成人慢性肠套叠可在直肠内摸到子宫颈样肿物，甚至象脱肛样从肛门脱出。病人自诉有坠胀感。

中医认为成人慢性肠套叠系升降失常，气虚下陷。其治疗，宜益气固脱，扶正补中。

方药：黄芪60克，陈皮10克，柴胡10克，枳实30克，党

参60克，炙甘草10克，当归15克，白术15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

22. 肠道菌群失调症

肠道菌群失调症是以慢性腹泻为主要表现的疾病。

健康人肠道内经常寄生一些细菌，在正常情况下，由于人体有一定抵抗力，与肠内寄生的菌群之间相互适应，保持平衡状态。虽然肠道内存在很多细菌，并不引起疾病。但是生态平衡是相对的，不是绝对的。一旦机体内外环境发生变化，或机体受到某种因素的影响，例如长期、大量使用抗生素时，破坏了肠道正常菌群的生理性组合，在新的条件下进行新的组合，就可产生菌群失调。菌群失调并不都引起疾病，只有在机体抵抗力降低时才会出现症状，称为菌群失调症。

恶性肿瘤、糖尿病、甲状腺机能亢进症、肾炎、肝炎、外伤、烧伤、休克、极度营养不良症重症患者，虚弱的老年人和早产儿，由于机体抵抗力降低，容易引起菌群失调症。放射线、免疫抑制剂、激素、抗菌素等使用不当，也容易导致菌群失调症。先天性免疫防御机能缺陷疾患，如慢性肉芽肿、色素缺乏易感性增高综合症、髓过氧化酶缺乏症、补体缺乏症、无丙种球蛋白症、先天性胸腺发育不良综合征、共济失调毛细血管扩张症等都可引起肠道菌群失调症。

肠道菌群失调症以严重腹泻和慢性腹泻为主要临床表现。在应用抗菌素治疗过程中，如突然发生腹泻，或原有腹

泻加重，即有可能发生肠道菌群失调症。腹泻多为淡黄绿色水样便，有时如蛋花样。真菌感染可呈带泡沫样稀便，有腥臭味，脓血便。个别病例粪便中漂浮有呈粉红色粘膜样碎片，大小不一。腹泻多数顽固，每日5~10次，甚至每日腹泻20余次。腹痛较轻，少数病例伴恶心、呕吐，多有水、电解质紊乱。重症可发生休克。

肠道菌群失调症常见的类型如下：

(一) 葡萄球菌性肠炎：多见于长期应用抗菌素（四环素类、氨基青霉素等）、肾上腺皮质激素和进行肠道手术的老年患者或慢性病患者。当体内的大肠杆菌等菌群因抗生素的应用被抑制或杀灭后，耐药的金黄色葡萄球菌即乘机繁殖，而产生肠毒素，并引起以腹泻为主的临床症状。腹泻多于手术后或用药后3~6日开始，每日排黄绿色稀便3~20余次，伴腹胀。吐泻严重者可出现脱水，水、电解质紊乱、血压下降。

(二) 白色念珠菌性肠炎：这是肠道菌群失调症最常见的一种。多见于瘦弱的婴儿、消化不良、营养不良、糖尿病、恶性肿瘤或长期应用抗生素和激素的患者。鹅口疮常是白色念珠菌性肠炎最早的信号。白色念珠菌性肠炎可出现频繁而无臭粘液脓性粪便，有时带血，也可呈水泻。

(三) 其他类型的肠道感染

1. 产气荚膜杆菌性急性坏死性肠炎：轻者吐泻，重者便血，甚至发生毒血症以至休克、死亡。

2. 其他肠道阴性杆菌的双重感染：

(1) 绿脓杆菌肠道感染：粪便带绿色，但并不经常引起腹泻。

(2) 变形杆菌肠道感染：可引起食物中毒，上吐下

泻，也可引起婴幼儿夏季腹泻。

(3) 肺炎杆菌肠道感染：引起小儿严重腹泻。

凡长期使用放射线、免疫抑制剂、激素、抗菌素等，临床出现高热、腹痛、腹胀、腹泻等症状，并有淡黄绿色水样便，应考虑有肠道菌群失调症的可能，应及时作有关的实验室检查，明确诊断。

肠道菌群失调症属于祖国医学的“泄泻”范畴。《医学入门丹台玉案》说：“泄者，如水之泄也，势犹舒缓；泻者，势似直泻，微有不同，而其病则一，故总名之曰泄泻。”中医认为，胃为水谷之海，脾主运化精微，如果脾胃受病，对饮食的消化吸收都发生障碍，致使清浊不分，混杂而下，则形成泄泻。《景岳全书》说：“泄泻之本，无不由于脾胃。盖胃为水谷之海，而脾主运化，使脾健胃和，则水谷腐熟而化，气化血，以行营卫。若饮食失节，起居不时，以致脾胃受伤，则水反为湿，谷反为滞，精华之气，不能输化，致合污下降而泻利作矣。”《不居集》说：“虚损泄泻一症，最不可忽略，……”虚损泄泻，与现代医学所指的机体免疫功能低下引起肠道菌群失调而导致的泄泻，有类似之处。其治疗的总原则，宜健脾补虚。

辨证分型治疗

(1) 肠胃湿热：腹泻黄绿色水样便，伴腹痛，心烦口渴，小便短赤，舌红苔厚腻，脉滑数。治宜清热利湿健脾。

方药：葛根30克，黄芩15克，黄连10克，木香10克，苦参30克，猪苓30克，蒲公英30克，鱼腥草30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

(二) 脾胃虚弱：腹泻，腹胀，水谷不化，不思饮食，神疲倦怠，舌淡苔白，脉弱。治宜补脾健胃。

方药：党参30克，白术15克，茯苓15克，水线草（白花蛇舌草）30克，猪苓30克，茵灵芝30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

(三) 脾肾阳虚：腹泻，腰酸，腹部畏寒，下肢觉冷，纳差，舌淡苔白脉细弱。治宜健脾补肾。

方药：吴茱萸10克，补骨脂10克，仙灵脾30克，五味子10克，水线草30克，黄芪30克，党参30克，苡仁30克，干姜10克，猪苓30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

验方治疗

方药：水线草（白花蛇舌草）30克，鱼腥草30克，猪苓30克，党参30克，茵灵芝30克，苦参30克，蒲公英30克，仙灵脾30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方中水线草（白花蛇舌草）、蒲公英不仅清热解毒，且能促进抗体生成。苦参能抑制真菌。鱼腥草清热消炎，且能提高备解素浓度，对提高机体免疫功能有利。党参、猪苓、茵灵芝能促进单核巨细胞的吞噬功能。仙灵脾能增强T细胞功能。诸药合用，既能清热解毒，又能增强人体免疫功能，是治疗肠道菌群失调症的有效良方。

23. 脂肪肝

脂肪肝系指肝内脂质过多。可由肥胖、营养过度、嗜酒、糖尿病及药物中毒等而引起，如不积极治疗，可发展为肝硬化。

脂肪肝患者可有肝肿大、肝功能异常、血脂升高等表

现，体型肥胖。

脂肪肝属于祖国医学“血瘀证”范畴。中医认为系肝之疏泄失常，湿热蕴结，瘀血阻络所致。《血证论》说：“一切不治之证，总由不善去瘀之故。凡治血者，必先以去瘀为要”。《读医随笔》说：“……久病必治络。……病久气血推行不利，血络之中必有瘀厥，故致病气缠延不去，必疏其络而病气可尽也”。脂肪肝的治疗，宜疏肝养血，活血祛瘀。

中药疗法

方一：泽泻60克，三七粉6克（冲服），虎杖30克，枸杞15克，杜仲15克，水牛角粉10克（先煎），夜交藤30克，桑寄生30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方二：制首乌30克，山楂30克，丹参30克，益母草30克，菊花15克，草决明30克，柴胡15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

食物疗法

1. 冬瓜粥：鲜冬瓜（带皮）100克，糯米、苡仁各30克，共煮粥食用，每日吃1次。

2. 赤豆鲫鱼汤：赤小豆60克、鲫鱼1尾（约200克）、紫皮大蒜1枚、葱白1段（约15厘米）。将鲫鱼去鳞及内脏，同上药一起用文火炖熟，吃鱼喝汤。

3. 茯苓百合粥：茯苓、百合各30克，粳米60克，将茯苓、百合磨成细粉，同粳米共煮成粥食用，每日吃1次。

4. 三鲜饮：鲜白萝卜100克，鲜荷叶15克，鲜山楂20克，水煎共取汁350毫升。加蜂蜜少量代茶饮。

5. 玉米花生大蒜粥：玉米粉50克，花生米50克，大蒜15克，粳米100克，共煮成粥食用（大蒜及玉米粉后下，尤其是大蒜，稍煮即可，勿煮久）。玉米可抑制胆固醇吸收，有

降血脂的作用。花生营养丰富，含植物脂肪约45%，其中不饱和脂肪酸占80%以上，具有降血脂的作用。大蒜能降低血清胆固醇、甘油三脂，对防治脂肪肝非常有益。

6. 香薷红枣粥：香薷20克，红枣30克，大米100克，共煮成粥食用。香薷含多种氨基酸及多种微量元素，有降血脂的作用，包括血清甘油三脂、磷脂、总脂、非脂型脂肪酸都有下降，对脂肪肝患者甚为适宜。红枣除能降低血清胆固醇外，尚有保肝、强身等作用。

7. 红辣椒烧带鱼：红辣椒适量，切丝备用。带鱼250克，洗净切段（但勿洗去白色的带鱼鳞油），加植物油煎带鱼，加入红辣椒丝及酱油等调料，佐餐。

8. 苹果牛奶羹：苹果100克，去皮切成薄片备用。牛奶250克，湿淀粉适量。将牛奶煮开放入湿淀粉，使成羹状，放入苹果薄片，稍煮即可，食用时可加适量白糖或蜂蜜。牛奶中含有一种叫乳清酸的物质，能抑制肝脏合成胆固醇，降低血液中胆固醇的总量。牛奶中还含有大量的钙质，钙与血中的胆固醇化合物结合，沉积为骨，能减少血中的脂类含量。苹果有降低胆固醇的作用。其机理是：一是苹果本身不含胆固醇，二是苹果中含有大量果胶。果胶能阻止肠内胆固醇的重吸收，使之排出体外，三是苹果在肠道内分解出的乙酸，有利于胆固醇的分解代谢。另外，苹果中含的丰富的维生素C、果糖、微量元素镁，均能降低胆固醇。

9. 葵瓜子大豆粥：大豆（黄豆）50克（先煮烂），大米100克，葵瓜子（去壳）30克。先将煮烂的大豆与大米共煮成粥，待粥煮好时放入葵瓜子（去壳），稍煮即离火。吃时可加盐等调味品。科学研究证实，进食大豆后，可将中性胆固醇从粪便中排出体外，从而减少体内血液中脂质的含

量。常吃大豆（黄豆）降脂效果好。葵瓜子所含的总磷脂能降低血脂，对防治脂肪肝有益无害。葵瓜子中的亚油酸部分能抑制实验性血栓的形成，还能预防中风。

10. 五花茶：玫瑰花、茉莉花、白扁豆花、白菊花、金银花各10克，乌龙茶或龙井茶适量，掺和均匀，每取6克泡茶饮用。科学研究证实，绿茶能减轻血清胆固醇的浓度和胆固醇及磷脂的比值。并能减轻动脉硬化的程度。常饮茶对脂肪肝患者大有好处。

11. 鲜蘑菇洋葱炒肉片：鲜蘑菇（或鲜平菇等）250克，洋葱100克，瘦猪肉片100克。瘦肉先伴以湿淀粉并加适量酱油，铁锅烧热，加入植物油先炒肉片，起锅，再炒洋葱，加好调料（盐）、倒入鲜蘑菇片，略炒，加入已炒熟的肉片，翻炒和匀，即可起锅食用（佐餐）。洋葱有降血脂的作用，鲜蘑菇降血脂的作用也非常好。因鲜蘑菇中含有降血脂的物质，其降血脂的作用与增强机体代谢有关，蘑菇在体内具有改变血脂平衡分布的作用。

体育疗法

脂肪肝如果不是急进型（病程进展很快）的，除了采用中药疗法和食物疗法外，还可配合采用体育疗法。因为体育疗法对降低血脂的效果也非常好。

人体的肝脏每天能合成1~1.2克胆固醇。从食物中摄取的胆固醇和身体自制的胆固醇，两者相互平衡。摄入的多，自制就少。如果人得了病，胆固醇的平衡就遭到破坏。

人体内的胆固醇，经消化吸收，多余的随胆汁流入小肠，少量的随粪便排出体外。

胆固醇在体内无所不在，脑和肾上腺含量最高，骨中含量最少。胆固醇是人体不可缺少的脂类物质。营养物质的吸

收和废物的排出，药物效果的产生，信息的传递，免疫反应的引起，都和生物膜（胆固醇是生物膜的重要原料）有关。胆汁酸的主要成分也是胆固醇。胆固醇能转变成激素（包括性激素、肾上腺皮质激素等）、维生素D₃等。以上是胆固醇的“功劳”。胆固醇也有“罪过”，动脉硬化与胆固醇在血管壁内的堆积和沉淀有直接关系。脂肪肝也是胆固醇等脂质在肝内代谢不良所致。

人体需要胆固醇，问题是如何防止胆固醇等脂质的代谢不良。

体育运动特别是慢跑，可改善胆固醇等脂质的代谢。

人体内胆固醇是与脂蛋白结合在一起的。脂蛋白可分为高密度脂蛋白和低密度脂蛋白两类。低密度脂蛋白把胆固醇堆积在血管壁上，形成动脉粥样硬化斑块，而高密度脂蛋白能把动脉粥样硬化斑上的胆固醇转移走。在血管里，高密度脂蛋白与低密度脂蛋白对胆固醇有竞争作用。人体高密度脂蛋白含量多，就能够防止动脉粥样硬化，也能够防止脂肪肝。喜欢运动的人的血液中高密度的脂蛋白含量就多。如果每天坚持慢跑半小时，几个月后高密度脂蛋白就会比原来高10%以上。在长寿家族成员中的血液中高密度脂蛋白与低密度脂蛋白的比例为1:1，而一般人的比例为1:2.5。

为了使血液中高密度脂蛋白的含量增多，为了改善胆固醇等脂质的代谢，为了防治脂肪肝，劝君积极参加体育锻炼，最好是坚持慢跑。

脂肪肝患者禁忌

脂肪肝患者，由于胆固醇等脂质的代谢发生障碍，平时宜少吃富含胆固醇的食物。

常用食物胆固醇的含量

食物名称 (毫克/100克)	胆固醇	食物名称 (毫克/100克)	胆固醇	食物名称 (毫克/100克)	胆固醇
猪肉(肥)	107	鸭肉	80	蟹黄(鲜)	466
猪肉(瘦)	77	鸭肝	515	蚬子	454
猪肝	368	鸭肫	180	蚶肉	238
猪肺	314	鸽肉	110	螺肉	161
猪心	158	鲤鱼	83	海蜇头	5
猪肾	405	鲫鱼	93	海蜇皮	16
猪肚	159	白鱼	76	海参	0
猪肠	180	鲢鱼	103	鸡蛋(全)	680
猪舌	116	花鲢	97	鸡蛋黄	1705
猪脑	3100	青鱼	90	蛋黄粉	2303
猪肉松	163	草鱼	81	鸭蛋(全)	634
腊肠(北京)	72	黄鳝	117	鸭蛋黄	1522
腊肠(广式)	123	甲鱼	265	松花皮蛋(全)	649
牛肉(瘦)	63	带鱼	97	鹅蛋(全)	704
牛肉(肥)	194	鳗鱼	186	鹅蛋黄	1813
牛肝	259	大黄鱼	79	鹌鹑蛋(全)	674
牛肚	132	马鲛鱼	82	牛奶	13
牛脑	2670	鲳鱼	68	奶粉(全脂)	104
羊肉(瘦)	65	鲑鱼	86	奶粉(脱脂)	28
羊肉(肥)	173	梭鱼	128	羊奶	34
羊肝	323	乌贼	275	猪油	85
羊肚	124	鱿鱼	265	牛油	89
羊脑	2099	对虾	150	羊油	110
兔肉	83	青虾	158	鸡油	107
鸡肉	117	白虾	54	黄油	295
鸡肝	429	小虾米	738		
鸡肫	229	螃蟹(全)	235		

附注：脂肪肝患者宜多吃富含多链不饱和脂肪酸的食物如胡桃、大豆油、玉米油、棉子油、花生油、芝麻油等。因为，多链不饱和脂肪酸可促进肝内胆固醇氧化为胆酸而排出，且与胆固醇结合成酯而向血管外转移，又可形成磷脂而稳定脂蛋白分子，防止胆固醇及其酯化物沉积。故脂肪肝患者平时宜多吃富含多链不饱和脂肪酸的食物。

脂肪肝患者禁忌吃大量甜食。

脂肪肝患者忌长期精神紧张，以免引起内源性血脂增高。有1例高血脂患者平时坚持体育锻炼，平时也很少吃富含胆固醇的食物及高糖食物，照说不会出现高血脂症，可是他工作繁忙，大脑皮层长期处于紧张状态，以致内源性血脂增高。故脂肪肝患者也应以此为戒，尽量使自己的精神放松，工作学习不要过分紧张，这样，就不会引起内源性血脂增高，有助于防治脂肪肝。

24. 肝炎后综合征

肝炎后综合征是指急性肝炎恢复期病人主观症状持久不消失，但客观检查并未发现肝脏损害。肝功能检查连续3次正常，肝脾未触及。这种情况已属急性肝炎临床治愈，但患者自觉症状如胁痛、腹胀、纳差、恶心、便溏、失眠、头晕、乏力等依然存在，不能正常工作。

肝炎后综合征属于祖国医学“郁证”、“胁痛”范畴。中医认为“思伤脾”、“怒伤肝”，由于患者对肝炎存在着恐惧心理，惶惶不可终日，因而造成虽然已属临床治愈，但主观症

状持久不消这种状态。治宜滋补肝肾，镇静安神。

方药：沙参20克，麦冬20克，枸杞15克，当归30克，生地30克，炙甘草10克，大枣30克，浮小麦30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

加减：胁痛加元胡、川楝子。腹胀加木香、莱菔子、厚朴。纳差加山楂、神曲。恶心加藿香、竹茹、法夏。失眠加夜交藤、酸枣仁。头晕加女贞子、旱莲草。乏力加党参、黄芪。便溏加山药。

本病多发生于对肝炎后果有一定了解的，或神经类型不稳定的患者，由于病人对肝癌有恐惧心理，怕自己的肝病未彻底治愈而转为肝癌。故这类病人现已很常见，严重者终日惶惶，四处求医。其症状虽复杂，但综观脉证，以肝肾阴虚、肝失条达、神不守舍为主。若用疏肝理气药，每致耗液伤气，反使病情增剧。故治疗肝炎后综合征，宜用滋养肝肾的沙参、麦冬、生地、当归、枸杞；安神养心的浮小麦、甘草、大枣，本方和中缓急，使肝体得养，肝气条达，心神镇定，故可获效。

肝炎后综合征患者“恐癌”情绪严重，还须配合心理治疗，应向病人耐心解释，解除其思想顾虑，最好找已经治愈的患者现身说法，说明肝炎不是不治之症，何况肝功能检查连续三次都已正常，又何必硬要把肝炎这顶帽子强加在自己头上。通过耐心解释，多数病人是能消除肝炎后综合征的。本征预后良好。

25. 肝脾结肠曲综合征

肝脾结肠曲综合征系指结肠的肝弯曲部或脾弯曲部聚积了过多的气体，而引起腹胀、腹痛的一组病症。根据本病临床表现的不同，分为肝曲综合征（症状是右上腹或右胁肋部疼痛、胀闷、可伴放射痛及恶心、呕吐）和脾曲综合征（以左小腹或左胁肋部疼痛、膨胀满闷为主症）及肝脾曲综合征（兼见上述两种症状）。本病以胀痛为特征，疼痛程度可轻可重，一般入夜痛甚，排气或采取一定体位时，疼痛可缓解。本病多见于女性，多有神经官能症、胃痛及习惯性便秘病史，发病前往往有着凉、神经紧张等诱发因素，具有上腹部持续性疼痛、呕吐、腹胀、便秘、发热等五大症状、查体可见上腹部局限性隆起、压痛、肠型及蠕动波，肠鸣音减弱或消失。X线腹部透视提示膈肌运动减弱，结肠肝曲或结肠脾曲明显广泛性胀气，无游离气体及梗阻液平面。血浆 CO_2 cp降低。本病还需作B超、心电图、肝功能、淀粉酶等检查，除外肝、胆、胃、肠、胰等脏器的器质性病变。

肝脾结肠曲综合征属于祖国医学的“腹痛”、“腹胀”范畴。本病病位在脾胃肝和大肠，多属实证，少数为虚实夹杂证，多因气机郁滞，升降出入功能失调所致。中医认为“清气在下，则生飧泄，浊气在上，则生腹胀”。脾胃共处中焦，为人体气机升降之枢纽。脾胃为后天之本，是人体一切能量的来源。脾气升，方能运化水谷精微以灌溉四旁；胃气降，方能受纳、腐熟水谷，传送糟粕于体外。脾气上行则肝气随

之上升；胃气下行则胆火随之下降。若升降失调，则腹痛腹胀作矣。其治疗，宜理气通腑。

方一：木香10克，枳壳10克，大腹皮10克，香附15克，玫瑰花10克，青皮6克，陈皮10克，砂仁6克，厚朴10克，蒲公英30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂（本方适用于肝曲综合征）。

方二：乌药10克，枳实12克，沉香3克，木香10克，槟榔10克，生大黄10克（后下）。水煎服，每日1剂，连服15~30剂（本方适用于脾曲综合征）。

方三：浮小麦100克（先煎），木香10克，大枣30克，甘草10克，玄胡10克，白芍30克，九香虫6克，熟大黄6克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂（本方适用于肝脾曲综合征）。

方四：生甘草10克，天花粉20克，蜂蜜30克。用法：生甘草、天花粉加水500毫升，煎成200毫升，然后将蜂蜜放入药液内冲服，每日1剂，分4次服，连服15~30剂。

加减：便秘加生大黄15克（后下）、芒硝10克（冲服）。腹胀明显加厚朴15克、枳实10克、青皮10克、木香10克。腹痛加白芍30克。食欲不振加神曲12克、莱菔子12克（本方适用于肝脾曲综合征）。

肝脾结肠曲综合征宜配合心理治疗，嘱患者保持乐观情绪，加强腹部肌肉锻炼，以加快肠蠕动，促使肛门排气、而助康复。

26. 慢性疲劳综合征

慢性疲劳综合征在实际生活中并不少见，患者大多数为

中年女性，病情复杂。其系列症状是：疲倦，低热，恶寒，喉痛，头昏头痛，自汗或盗汗，肌肉关节疼痛酸楚，食欲不振，注意力分散，记忆力衰退，神情默默，有的患者对光线敏感，颈部淋巴结触痛。虽然此病不会致死，却可使人的工作效率下降，生活情绪淡薄，身体虚弱不堪。因此，应引起人们的高度重视。

慢性疲劳综合征的发生与长期劳累过度或休息不当有关，心理因素也起着重要作用。由于中年人工作和家务负担都比较重，精神压力亦比其他年龄组大，又往往休息不好，所以，患病率较高。中年女性接近更年期或正处于更年期，由于内分泌的作用，情绪易被激惹，而且，家务和精神负担又较男人为重，因此患病率更高。

慢性疲劳综合征属于祖国医学的“虚劳”、“虚损”范畴，中医认为多系元气真阴不足所致。《万病回春》说：“虚怯症者，皆因元气不足，心肾有亏，或劳伤气血，……渐至真阴亏损，相火随旺。火旺则消真阴，而为嗽，为痰，为热，……为盗汗，……脚手心热皮焦，午后怕寒，夜间发热，或日夜不退，……头目眩晕，腰背酸疼，四肢困倦无力……”。《素问·阴阳应象大论》说：“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”。《难经》说：“损其肺者，益其气；损其心者，调其荣卫；损其脾者，调其饮食，适其寒温；损其肝者，缓其中；损其肾者，益其精。此治损之法也”。说明中医对慢性疲劳综合征的治疗，宜补中益气，健脾补肾。

辨证分型治疗

(一) 外损型（外感致虚损）：未病之前，体素虚弱，既病之后，又似外感（恶寒，低热，头昏头痛，肌肉关节疼痛酸楚等等），又似内伤虚劳（疲倦，食欲不振，注意力分

散，记忆力衰退等等)。治宜补中托里。

方药：黄芪60克，党参30克，当归30克，白术15克，茯苓30克，木瓜30克，佩兰12克，秦艽15克，荆芥10克，防风10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

(二) 气虚挟郁型：天性怯弱，心神不舒，肝气郁结，闷闷不乐，少气懒言，面色皖白，纳差。治宜益气开郁，健脾益胃。

方药：党参60克，白术20克，陈皮10克，砂仁10克，厚朴10克，山楂30克，神曲30克，当归30克，枸杞15克，淮牛膝30克，杜仲15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

专方治疗

方药：白花蛇舌草（水线草）30克，菌灵芝30克，枸杞15克，黄芪60克，人参叶30克，川芎15克，杜仲15克，制首乌15克，白术20克，茯苓30克，青蒿30克（后下）。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

针灸治疗

针刺足三里（双侧）、内关（双侧），得气后留针30分钟。每日1次，7天为1疗程，需治疗4个疗程。

灸肾俞、命门。每日1次，7天为1疗程，需治疗4个疗程。

慢性疲劳综合征的注意事项

1. 生活宜有规律，要劳逸结合，切忌过度劳累。人到中年更不能搞突击性劳动，不做力不能及的事。

2. 学会科学地休息，每天保证7~8小时睡眠。培养一两项业余爱好，调节、丰富生活。如果业余生活单调、枯燥，会促使慢性疲劳综合症的产生。

3. 讲究心理卫生。心胸要开阔，多交朋友，常与亲人

和朋友谈心，善于宣泄内心的消极情绪，不断实现新的心理平衡。

4. 过好星期天。要善于在星期天放松自己的身心，走出家门，和亲人、朋友一起到大自然中去沐浴阳光，欣赏风景，呼吸新鲜空气，从而使身体和精神都放松，心情舒畅、愉快，消除一周来的疲劳。

如果星期天过得比平时还要紧张或苦闷，则会促进慢性疲劳综合症的发生。

27. 结核性腹膜炎

结核性腹膜炎是由结核杆菌感染引起的慢性弥漫性腹膜炎，绝大多数继发于其他结核病灶，例如肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核等。本病可见于任何年龄，以青壮年多见。根据本病的病理解剖主要特点，可分为渗出型、粘连型、干酪型三种。结核性腹膜炎随原发病灶、感染途径、病理类型及人体反应性的不同，临床表现也各异。一般起病缓慢，症状较轻，常于发病后数周以至数月才就医诊治。少数发病急骤，以急性腹痛或骤起高热为主要表现。其临床表现主要为以下几点。

1. 发热：以间歇性低热为最多见，也有弛张性高热，有时高达 40°C ，伴有明显中毒症状，可有盗汗。后期病人常有消瘦、营养不良、浮肿、贫血、口角炎、维生素A缺乏症等。

2. 腹痛、腹泻：腹痛多位于脐周、全腹、下腹或活动

性病变部位。腹泻一般每日2~4次，以糊状粪便居多，有时粪量很多。

3. 腹胀、腹水：患者可有腹胀感，也可因大量腹水而感腹胀。少量腹水在临床检查中不易察觉，腹水超过1000~2000毫升，才能发现有移动性浊音。

4. 腹壁柔韧感：亦可认为是一种“揉面感”。

5. 腹块：常位于脐周，也可在其他部位，大小不一，边缘不整，表面不平，有时呈结节状、块质多固定。压之剧痛，可误认为肿瘤或肿大的内脏。

腹水型患者腹部逐渐膨胀。若腹水量大，腹壁皮肤可有光泽与妊娠样条纹。可有腿部水肿，呼吸变浅而呈胸式。

粘连型的体征不明显，腹壁扪诊可有特殊的柔韧感和橡皮样抗力。

干酪型患者可呈重病容，显著消瘦，腹部膨胀而柔韧，压痛明显，可扪及腹块。

结核性腹膜炎的典型病例，诊断一般无困难。主要依据为：青壮年病人有结核病史，发热原因不明达2周以上，伴有腹胀、腹痛、腹泻、腹水、腹壁柔韧感、腹部肿块。腹腔穿刺可获得腹水，呈渗出性。一般细菌培养阴性，结核杆菌培养可能出现阳性。X线检查可发现肠粘连等征象。由于本病的临床表现不典型，往往给诊断带来困难，误诊率相当高，因此必须提高警惕，认真进行鉴别诊断。

结核性腹膜炎属于祖国医学的“癆瘵”范畴。中医认为系邪留阴分，骨蒸潮热，腠理疏豁，盗汗病作，脾虚湿胜，下肢浮肿，腹部膨胀。“诸湿肿满，皆属于脾”。其治疗，宜健脾利水，养阴益气，活血化瘀。

方一：地骨皮30克，银紫胡15克，银花30克，连翘30

克，青蒿30克（后下），秦艽15克，生牡蛎30克，炙鳖甲15克。水煎服，每日1剂。连服10~20剂。本方适用于结核性腹膜炎之低热症候，如出现高热，可加服紫雪丹1支。

方二：银花30克，连翘30克，玄胡10克，乳香10克，没药10克，黄芩30克，黄连10克，黄柏10克，木香10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。本方适用于结核性腹膜炎之腹痛腹泻症状突出者。

方三：党参30克，茯苓30克，白术30克，冬瓜仁30克，车前子15克，泽泻30克，丹皮10克，麦冬30克，天冬30克，百部10克，黄精30克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。本方适用于结核性腹膜炎腹水明显者。

方四：黄芪60克，当归30克，川芎10克，赤芍30克，桃仁10克，红花10克，丹参30克，三七粉3克（冲服），三棱10克，莪术10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。本方适用于结核性腹膜炎腹中硬块明显者。

23. 阑尾周围脓肿

阑尾周围脓肿系化脓性阑尾炎穿孔后，以大网膜及其邻近的肠袢所包围而形成的局限的炎性包块。其症状有：右下腹痛，触及肿块，发烧；若脓肿压迫肠管，可形成不完全梗阻，腹胀，呕吐；若脓肿与膀胱接近，可出现尿频尿急尿痛。

阑尾周围脓肿，通过B超检查可确诊。诊断性腹穿刺，大部分可吸出脓液（脓少者不易吸出）。实验室检查，白细

胞总数增高，中性粒细胞增多。

阑尾周围脓肿属于祖国医学的“肠痈”范畴。《金匱要略》说：“肠痈者，少腹肿痞，按之急痛，如淋，小便自调，时时发热……”，《外科正宗》指出：“初起小腹疼痛，脉芤数者，瘀血也，宜下之，……肠痈溃后，疼痛淋漓不已……”。中医认为肠痈多由嗜食膏粱厚味或急暴奔走，跌仆损伤，或暴怒忧思，或寒温失调，致肠胃受损，运化失职，糟粕积滞，生湿生热，气血不和，留为败瘀，积于肠道而成。中医还认为，阑尾周围脓肿的主要矛盾是“热”与“毒”，气血为毒邪壅塞不通所致，其基本病理变化为热、瘀、闭、症、积。其治疗，宜清热解毒，活血化瘀，通里攻下。

辨证分型治疗

(一) 毒热型（脓肿型）：发热恶寒或但热不寒，面红目赤，右下腹可扪到肿块，触痛明显，大便秘结，舌红绛，苔黄燥，脉洪大或弦数。治宜清热解毒，行气活血，通里攻下。

方药：大黄（后下）15克，丹皮15克，红花10克，赤芍30克，败酱草30克，桃仁12克，银花30克，连翘30克。水煎服，每日1剂，连服5~10剂。

(二) 瘀热相搏型：腹膜炎征象遍及全腹或超过腹部两个象限，体温及白细胞明显升高。严重者可伴有中毒性休克表现。舌红绛，苔黄腻，脉洪数或细数。治宜清热解毒，祛瘀散结。

方药：莪术12克，败酱草30克，苡仁30克，冬瓜仁30克，红藤30克，山甲15克，皂刺15克，大黄（后下）15克，丹皮15克，蒲公英30克，紫花地丁30克。水煎服，每日1剂，连服5~10剂。

专方验方治疗

方一：制附片20~40克（先熬2小时），苡仁60克，冬瓜仁30克，鱼腥草30克，大黄15克，白芍30克，甘草10克，法半夏15克。水煎服，每日1剂，连服5~10剂。

本方重用附片温阳祛寒，苡仁燥湿，大黄通里攻下，鱼腥草清热解毒，白芍缓急止痛，冬瓜仁利水散结，法半夏加重祛湿之力又消痰核，可使炎性包块较快吸收消散。

方二：红藤30~60克，乳香10克，紫花地丁30克，连翘30克，大黄15克，银花30克，赤芍30克，没药10克，丹皮15克，枳壳15克，玄胡10克，甘草10克。水煎服，成人每日1剂，重症者每日2剂，小儿酌减。连服5~10日。

加减：腹胀痛甚者加木香、厚朴各10克，呕吐者加竹茹、法夏各15克。包块消退缓慢者加三棱、莪术各15克。积脓较多者加苡仁30克、败酱草30克。

方三：天花粉15克，当归30克，甲珠15克，皂刺15克，白芷10克，浙贝10克，蒲公英30克，大黄15克，银花30克，三棱10克，莪术10克。水煎服，每日1剂，连服5~10剂。

外敷药物治疗

方一：生桐油1份，生石膏粉2份。两者混合搅匀成糊状物即成。用时以油纸或塑料薄膜盛上药适量外敷于右下腹阑尾脓肿体表投影区，外层盖一棉垫，然后以胶布固定，每日换药2次，炎症严重者可增加换药次数。

敷药后有腹泻，勿需处理。泻出热毒，有利于治疗。

方二：虎杖30克，生石膏30克，冰片2克，共研细末加凡士林为膏，外敷患处，每日换药2次。

方三：大蒜30克，芒硝60克，捣如泥，于肿块皮肤上用5~6层油纱布隔离，将大蒜芒硝泥敷于油纱布上，包裹其泥

汁，以保持敷药湿润。每天换药2次，至包块缩小或消失为止。

大蒜芒硝糊清热解毒，润燥软坚，泻热通便，敷于患处可促进炎症的吸收消散，并可使肠蠕动增加，加快有毒物质的排出。

方四：生大黄25克，生山栀25克，生南星25克，生川乌10克，生草乌10克，细辛10克，桃仁10克，肉桂10克，乳香10克，没药10克，红花10克，共研细末，加适量面粉和黄酒调成糊状，匀摊于塑料薄膜上，厚5毫米，应超过肿块或压痛区，盖纱布固定，每日换药1次。因酒易挥发干燥，宜每6小时加酒润湿药糊。

29. 下肢静脉曲张

下肢静脉曲张是常见病。长时间站立劳动的人容易得这种病。得了这种病，患者自觉下肢沉重，发胀，麻木，隐痛，容易疲劳，脚背内和外踝部常有肿胀，下肢（腿肚）静脉显得很粗而突出，如蚯蚓状。

中医认为下肢静脉曲张系气滞血瘀所致。《圣济总录》说：“脉者血之腑，血行脉中，贯于肉理，环周一身，因其肌体外固，经隧内通，乃能流注，不失其常。若因折伤，内动经络，血行之道，不得宣通，淤积不散，则为肿为痛。”中医认为瘀血阻滞经脉，不得畅通，遂致肿胀。其治疗，宜活血化瘀。

方药：当归30克，川芎10克，赤芍30克，熟地30克，桃

仁10克，红花10克，桂枝10克，黄芪60克，细辛6克。水煎服，每日1剂，连服60~90剂。每服10剂可间歇1~2天。

注意事项：

(一) 宜采用快速步行的方法配合治疗。医学家发现，对下肢静脉曲张的患者，如果能每天坚持快速步行4次，每次15分钟，就可以有效地治疗这种病。因为在快速步行时，腓肠肌的运动加大，活动不断，静脉血管就象抽水泵一样将积存在处于曲张状态的静脉中的血液往心脏方面提送。同时，由于局部微循环的加快，使曲张的静脉的新陈代谢也加快，静脉也能较快恢复正常。快速步行后，最好能将脚抬高，躺下休息，脚高于身体平面，躺15分钟左右。这样，就有助于康复。

(二) 宜作爬行运动。爬行运动简单易行，男女老幼都会做。医学家们经过观察发现，爬行动物很少患动脉硬化、冠心病、痔疮、下肢静脉曲张等疾病。于是，有的医学家就用爬行疗法来治疗下肢静脉曲张。

爬行运动有很多好处，对上肢、腿、脊柱、腰、心脏等的功能都有帮助。而爬行运动不需要场地和设备，如能戴上手套和护膝，那就更好了。同时，还要循序渐进，距离由短到长，速度由慢到快，还要注意时间的安排，不要在饭前饭后爬，以免影响消化。

(三) 宜穿长筒弹力袜。长筒弹力袜穿上后，能使皮肤表面产生一股保护力，促使曲张的静脉不再向外膨胀，因而对曲张的血管有保护作用。因此，下肢静脉曲张患者宜穿长筒弹力袜。

(四) 禁忌事项：①忌长时间站立。如果长时间站立，易使下肢血液循环不畅，久而久之则导致下肢静脉曲张。为

了预防下肢静脉曲张，为了使已经曲张的下肢静脉恢复正常，要争取适当休息，哪怕1小时坐下休息几分钟也好。②忌下肢活动过少或下肢长时间下垂不动。③忌用收缩血管的药物如麻黄素等。

30. 精索静脉曲张

精索蔓状静脉丛扩张、弯曲、伸长，称为精索静脉曲张。多因静脉血回流不畅而形成。多见于20～30岁青年男性，其中95%发生在左侧，右侧与双侧则少见。

病因：精索内静脉无瓣膜，或因静脉管壁发育不良，因此精索静脉易曲张。左侧精索静脉相对比右侧为长；左侧精索静脉成直角进入肾静脉，血液回流阻力较大，左侧还易受压于乙状结肠等原因，因此左侧精索静脉曲张发病较多。其他疾病也可使精索静脉受压、梗阻而继发精索静脉曲张（如肾静脉内癌栓、腹膜后肿瘤、肾肿瘤、肾积水等），称为继发性精索静脉曲张。

精索静脉曲张患者平时无症状，在长久站立和重体力活动后感到患侧阴囊下坠和胀痛，甚至由于疼痛和坠痛不便行走。平卧后症状消失。由于血液回流影响睾丸血液循环，致同侧睾丸萎缩，生精能力减弱，影响生育。科学研究证明，精索静脉曲张会损害睾丸的生精细胞和干扰附睾精子的正常发育，因而导致男性不育。

根据年轻男性左侧阴囊胀痛、下坠感，体力活动或久立后症状明显，平卧位症状减轻，站立检查时，左侧阴囊松

弛，表面可见弯曲静脉扩张（阴囊青筋暴露），扪诊时阴囊内如盛有一袋条虫样物，同侧睾丸位置较下垂等表现，即可确诊为精索静脉曲张。

精索静脉曲张属于祖国医学的“肾囊瘀血证”范畴。王清任说：“青筋暴露，非筋也，现于皮肤者，血管也。血管青者，内有瘀血也”。瘀久则蕴毒生热，煎熬肾精，耗损阳气，致令肾亏精弱。中医还认为，足厥阴肝经绕阴器，肝失疏泄，气血不畅，津聚为痰，血停为瘀，阻于肝脉而致精索静脉曲张。治宜疏肝活血，益肾通脉。

方一：生地30克，熟地30克，当归30克，川芎10克，丹皮10克，丹参30克，泽兰叶30克，川牛膝15克，杜仲15克，鹿角霜15克。肉苁蓉15克，鸡血藤30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

加减：全精液异常加菟丝子、紫河车。精子成活率低或活动力弱者加仙灵脾、黄芪、苡仁。精液中有脓细胞加土茯苓、萆薢、龙胆草、银花。阴囊冷湿、少腹抽痛加台乌、小茴、元胡、橘核。

方二：柴胡15克，乌药10克，郁金20克，桃仁10克，元胡10克，地鳖虫10克，川牛膝30克，白术15克，茯苓15克，菖蒲15克，黄芪60克，当归30克。水煎服，每日1剂，须连服30~60剂。

方中川牛膝“走而能补，性善下行”，长于活血通络，又能祛瘀止痛，为本方之要药，用量不应少于30克。

护理注意事项

1. 宜用阴囊托带将阴囊托起、托高，使阴囊不致下坠，为血液回流通畅创造条件。
2. 每晚临睡前，用冷水洗敷阴囊，以刺激阴囊收缩，

帮助精索静脉内的血液回流，以利康复。

3. 精索静脉曲张患者还要注意保持大便通畅。如果大便秘结，解便时就要久蹲厕所，用力努挣，这样就会使阴囊更加下坠，加重精索静脉曲张的程度。

31. 精子功能低下

精子功能低下是男性不育症的原因之一。表现为精子运动迟缓，原地打转，不能作直线运动，活动力弱，无法与卵子结合。患者性欲淡漠，排精质稀量少，腰酸痛，形寒肢冷，疲乏无力。

精子功能低下属于祖国医学的“肾阳虚”范畴。中医认为，肾为生殖之本，肾阳不足，则精气清冷，精虫活动功能低下。《太平圣惠方》说：“夫肾脏者，元气之根，精神所舍。若其气虚弱，则阴气有余，阳气不足，……腰脚酸痛……嗜卧无力，则是肾气不足之候也”。《黄帝内经素问》说：“形不足者，温之以气，精不足者，补之以味”。《难经》说：“损其肾者，益其精”。精子功能低下的治疗，宜温补肾阳。

方一：仙灵脾30克，仙茅10克，熟地30克，覆盆子10克，菟丝子30克，金樱子30克，枸杞子15克，巴戟10克，锁阳15克，胡芦巴10克，肉苁蓉10克。水煎服，每日或隔日1剂，连服30~60剂。

方二：五子衍宗丸（成药），照说明书剂量加1~2倍服用），连服2~4个月。

方三：八味肾气丸（成药），每次服18克，每日服3次，连服2~4个月。

以上三方，均系通过补肾而增强精子功能，须连续服药，坚持治疗。由于患者体质个体差异甚大，故疗程宜长不宜短。有的患者连续服药30剂即见效，显微镜检查可见精子活跃，呈直线运动，精子数量也较服药前大为增多，而有的患者则须延长治疗时间方能奏效。

32. 阴茎异常勃起症

阴茎异常勃起症是一种长时间无性欲要求的海绵体痛性勃起（勃起而疼痛），阴茎无故而持续性坚硬勃起，久久不痿。具有发病急，易留有永久性阳痿后遗症的特点。

阴茎异常勃起症属于祖国医学的“强中”、“阴举不衰”、“阳强不倒”、“茎强不萎”、“阴纵不收”等范畴，俗称“硬速痧”。中医认为其病因病机为：肝肾阴虚，或湿热蕴于下焦，或房室不节，相火妄动，或过食金石丹及过服温补升阳之药如鹿茸；腰骶或阴部损伤，瘀血进入阴茎脉络；好酒贪杯，恣食膏粱厚味，酿生痰热，痰火互结而下注阴器；虚火上炎，肺金之气不能下行以生肾水，水亏火旺而致阳强不倒。其治疗，宜滋阴潜阳，清肝泻火，活血化瘀，祛痰利湿。

辨证分型治疗

（一）火不归元型：阴茎勃起不倒，龟头颜色鲜红，包皮不皱，皮肤枯燥失润，颧红唇赤，手足心热。治宜引火归元。

方药：泽泻30克，肉桂3克，制附片10克，山药30克，熟地15克，丹皮12克，茯苓皮30克，黄柏15克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

（二）阴虚阳亢型：阴茎勃起，持续不萎，龟头前部在裤上擦破，渗出黄水，自遗精液，头晕，眼胀痛充血，耳鸣腰痛，口苦咽干，心烦，舌红少苔，脉细数，治宜滋阴潜阳。

方药：知母12克，黄柏12克，生地30克，丹皮12克，泽泻30克，茯苓皮30克，生牡蛎30克，酸枣仁12克，淡竹叶12克，麦冬30克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

（三）肝经湿热型：阴茎异常勃起时间较长，疼痛较剧烈，排尿困难，尿赤涩痛，便秘口干，舌红苔黄，脉弦有力。治宜清肝泻火。

方药：龙胆草15克，木通10克，泽泻30克，柴胡15克，车前草30克，生地30克，栀子10克，黄芩12克，知母15克，黄柏15克，川牛膝30克，山甲珠15克，桃仁10克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

（四）阴虚火旺型：阴茎异常勃起持续时间较短，阴茎色青灰，疼痛轻，或时有精液自出，口干，舌红，脉细数。治宜滋阴降火。

方药：知母12克，黄柏12克，熟地30克，山萸12克，山药15克，泽泻30克，丹皮15克，茯苓15克，龟板30克，麦冬30克，玄参30克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

（五）气滞血瘀型：有局部外伤史，阴茎异常勃起日久不衰，久治不愈，阴茎色素紫，坚硬无弹性或疼痛剧烈，唇舌有瘀斑，脉细涩。治宜活血化瘀。

方药：山甲15克，当归30克，赤芍30克，益智仁10克，路路通10克，黄芪60克，三棱10克，莪术10克，丹参30克，

桃仁10克，红花10克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂，并用红花30克煎汤外敷阴茎。

(六) 痰火郁结型：体质肥胖，平素嗜酒，姿食肥甘厚味。阴茎异常勃起，较坚硬，伴口苦而腻，渴不欲饮，便秘或粘腻不爽，尿赤，舌红，苔黄厚或黄腻。治宜泻火化痰。

方药：胆南星10克，地骨皮30克，远志10克，夏枯草30克，知母12克，黄柏12克，竹茹10克，龙胆草12克，车前草30克，元明粉10克（冲服），大黄10克。水煎服，每日1剂，连服3~10剂。

针灸治疗

取穴：蠡沟（双侧），用泻法。照海（双侧），用平补平泻法。每日针刺1次，连续3~10日。

单方治疗

1. 泽泻15克，煎汤代茶饮，每日1剂，连服7~10剂。

注：阴茎异常勃起症处理不当，极易产生阳痿等后遗症，正如《石室秘录》所说：“阳强不倒……若用黄柏、知母二味煎汤饮之，立时消散，然自倒之后，经岁终年不能重振，亦是苦也……。”

2. 芒硝100克，让病人两手分握，并用细带分别缠包患者握芒硝的双手，3小时左右，阴茎开始萎软，疼痛减轻。

如以后又复发，仍可用此单方治疗。

33. 阴茎硬结症

阴茎硬结症即阴茎海绵体纤维化，是海绵体白膜与阴茎

筋膜之间产生纤维性硬结。病因不明，可能与外伤、维生素E缺乏、硬化性炎症、退行性疾病、梅毒等有关。早期在结缔组织中小血管周围有炎性细胞浸润，以后形成增厚的纤维组织斑块，可有钙化或骨化。还有学者认为本病发病过程中可能有阴茎微循环障碍，微血管出血或血栓形成，从而导致血栓机化，形成硬结。

阴茎硬结症多见于中年时期，平时无异常感觉，勃起时阴茎疼痛、弯曲，弯曲的程度决定于纤维化的范围。严重者可影响性生活。但多不影响排尿，也无破溃。检查时在阴囊背侧可触及条索状物或斑块或结节，质较硬，表面不光滑，不能移动。阴茎X线检查可能发现钙化或骨化阴影。

阴茎硬结症属于祖国医学的“玉茎结疽”范畴。根据阴茎皮色不变、皮温不高、结节较硬、疼痛不甚、从不溃破等特点，中医认为玉茎结疽多属阴证。部分患者同时兼有腰酸痛、怕冷、排尿不畅、少腹胀痛、便溏、失眠、早泄或阳萎等症状，中医认为本病多系脾肾阳虚、寒湿凝结、经络阻遏。中医认为肾为先天之本，肾阳不足，命门火衰，火不生土，则脾阳失健，久之导致脾肾阳虚。肾者，作强之官，伎巧出焉。《太平圣惠方》说：“夫肾脏者，元气之根，精神所舍。若其气虚弱，则阴气有余，阳气不足，故令心悬少气，小腹胀急，……腰脚酸痛，……则是肾气不足之候也”。《血证论》说：“一切不治之证，总由不善去瘀之故。凡治血者，必先以去瘀为要”。《临证指南医案》说：“初病胀痛无形，久则形坚似梗，是初为气结在经，久则血伤入络”。阴茎硬结症患者，脾肾俱虚，气滞血瘀。治宜温肾健脾，活血通络。

方一：山药30克，熟地30克，生地20克，肉桂6克，白芥子10克，当归30克，玄参15克，丹参30克，丝瓜络30克，

橘核30克，莪术10克，鸡血藤30克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

加减：腰酸、早泄、阳痿明显者加续断30克、寄生30克、狗脊30克、仙灵脾30克。少腹胀满、尿意不尽者，加乌药10克、木通10克、琥珀粉6克。阴茎硬结肿痛明显者加元胡10克、川楝子10克。硬结日久不消，舌有瘀斑瘀点者加三棱10克、桃仁10克、红花10克。

方二：夏枯草30克，皂刺15克，莪术12克，苡仁30克，乳香10克，没药10克，白芷10克，柴胡15克，白芍30克，山药30克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

方三：六味地黄丸（成药）或金匱肾气丸（成药）合大黄廔虫丸（成药）服用，每次各服10克，每日服3次，开水吞服。连服1~2个月。

注：方一或方二须与方三交替服用，以不停药为好。

方四：阳和解凝膏或黑布膏药，敷贴患处。

患者注意事项：阴茎硬结症系良性疾患，能治好。患者应保持乐观情绪，消除恐惧心理，坚持服药（疗程长），并要忌房事，还可配合服用维生素E（较长期服用）。

34. 紧张性排尿迟缓综合征

紧张性排尿迟缓综合征，由精神紧张造成，尿液不能顺利排出，但无器质性病变。

患者尿意明显，但却一时排不出尿，特别是有他人在场，排尿愈显得迟缓，愈觉得排不出尿。患者平时心烦，急躁，

手足心热，易出汗。

紧张性排尿迟缓综合征属于祖国医学的“小便难”范畴。《医碥》说：“……六淫七情，……内外诸邪，皆能闭气……肝脉过阴器，肝火郁不伸则癃闭……”。说明古代中医已认识到排尿不利可由精神因素所造成。其治疗，宜清心滋肾，通关利尿。

方一：知母10克，黄柏10克，肉桂10克，生地10克，竹叶10克。水煎服，每日1剂，1周为1疗程。一般1~2疗程即可。

方中知母、黄柏苦寒，清热泄火，肉桂温阳散结，生地养阴生津，竹叶清心利尿。知母与黄柏合用，可使神经系统的兴奋性降低，使大脑皮层的兴奋、抑制过程趋向平衡，使排尿反射协调配合而消除紧张心理，从而使排尿正常。

方二：茯苓30克，琥珀粉10克（冲服），白术15克，泽泻30克，猪苓30克，肉桂3克，滑石30克。水煎服，每日1剂，连服1~2周。

方中茯苓、琥珀合用，安心神而利尿，可消除排尿时的紧张心理，白术、泽泻、猪苓、滑石均能利尿除湿，加肉桂通阳散结，诸药合用，增强利尿功效，尿意急迫，久之不论他人在场与否，均能顺利将尿排出。

35. 高氮质血症

高氮质血症是出现在慢性肾炎晚期阶段的一种病症，也即肾功能衰竭的一个阶段。治疗高氮质血症对于防治尿毒症

有重要意义。

肾脏疾病发生发展的各个阶段，按照肾功能损害程度可分为4期：①肾功能正常期，血尿素氮 $<20\text{mg/dl}$ ，血肌酐 $<1.5\text{mg/dl}$ 。②肾功能不全期，血尿素氮 $20\sim35\text{mg/dl}$ ，血肌酐 $2\sim3\text{mg/dl}$ （此期除有原发疾病表现外，尚无其他症状）。③肾功能失代偿期（即氮质血症期），血尿素氮 $36\sim60\text{mg/dl}$ ，血肌酐 $3\sim5\text{mg/dl}$ 。此期患者肾脏的代偿储备功能近于耗竭，有乏力、食欲减退、呕吐腹泻、贫血等症状。氮质血症期出现的临床症状即高氮质血症。氮质血症期如肾脏负荷继续加重，如感染、失水等，病情加重，代谢产物（含氮物质）潴留于体内，就会出现尿毒症的各种症状，进入尿毒症期。④尿毒症期：血尿素氮 $>60\text{mg/dl}$ ，血肌酐 $>5\text{mg/dl}$ 。

高氮质血症属于祖国医学的“肾元虚衰”、“血瘀”范畴。高氮质血症多由慢性肾炎发展而来，原本因肾气不足，精关不固，最终导致精气下泄。其治疗既要扶正补虚，又要降浊化瘀，使含氮物质从二便排出。

内治法

方药：黄芪60克，仙灵脾30克，菟丝子30克，生地20克，制首乌30克，枸杞15克，生大黄10克，白术15克，茯苓30克，益母草30克。水煎服，每日1剂，重症患者每日可服2剂。

加减：阴虚加女贞子、旱莲草、麦冬、丹皮。阳虚加肉苁蓉、巴戟、补骨脂。胸痞呕恶加法半夏、厚朴。水肿加冬瓜皮、车前草。

外治法

方药：附子100克，细辛100克，红花100克，川芎100克，

炮山甲片100克，王不留行100克，苍术100克，大黄60克。以上诸药投入麻油中煎熬，黄丹收膏。外敷双侧肾区。

用时先清洗皮肤，将膏药(硬膏)加温后敷于双侧肾区，每周换药1次，疗程不限。

灌肠法

方药：大黄30克，生牡蛎30克，蒲公英30克，丹参30克。加水浓煎至300毫升，待药液温度达到37℃时，用大号导尿管插入肛门30厘米，缓慢注入药液，作保留灌肠，保留2小时，每晚1次，10天为1疗程，可进行3个疗程。灌肠期间，每日大便以3次为妥。如大便次数过多，可隔日灌肠1次。

灌肠降浊是治疗高氮质血症的重要而有效的方法，通过灌肠，大便次数增加，血中含氮物质随大便排出，高氮质血症症状很快改善。脾胃虚弱的患者更适合用灌肠法治疗。灌肠疗法治疗高氮质血症疗效可靠，方法简便，已受到医学界的公认（尿毒症也可采用灌肠疗法）。

36. 肾周围脓肿

患皮肤疖、疔或齿龈炎、扁桃体炎、呼吸道感染时，细菌可经血行感染肾，引起肾皮质多发性脓肿。肾的脓肿可以经肾被膜蔓延到肾周围脂肪囊，形成肾周围脓肿。肾周围形成较大的脓肿时，可刺激同侧腰大肌使髋关节屈曲，同侧的膈肌升高和活动幅度减小。

临床表现：恶寒发热，肾区隆起，有叩击痛，腰肌强直，下肢水肿，弯曲受限，活动不便，白细胞总数及中性细胞可

增高，B超检查有助于确诊。

肾周围脓肿属于祖国医学的“内痈”范畴。多由火热之毒所致。《医宗金鉴》云：“痈毒原是火毒生，经络阻隔气血凝”。中医认为湿热之邪蕴结下焦，经脉不通，发为痈肿，乃是内痈的病机。治宜清热解毒，活血排脓。

方一：大黄15克，桔梗15克，丹皮15克，桃仁10克，苡仁30~60克，冬瓜仁30克，败酱草30克，鱼腥草30克，紫花地丁30克。水煎服，每日1剂，连服7~12剂。

方二：苡仁60克，黄柏20克，知母15克，苍术30克，黄芪60克，淮牛膝30克，鸡血藤30克，赤芍30克，丹皮15克，车前草30克，红藤30克。水煎服，每日1剂，连服7~12剂。

37. α 地中海贫血

地中海贫血因首先在地中海地区发现而得名。实际上此病决不只限于地中海地区，在赤道附近，南北温带的广大地区，包括我国南方各省均有较多发现。

α 地中海贫血是地中海贫血的一大类型。是一种由于遗传基因异常所致的慢性贫血性疾病，表现为严重贫血、溶血、肝脾肿大等现象。可分为以下三型：

(一) 轻型：可无临床症状，或红细胞形态正常，或出现轻度低色素性贫血。

(二) 中间型 (HbH病)：起病缓慢，多在儿童期或成年期出现症状，表现为轻度或中度贫血，在妊娠、感染及服氧化剂后加重。贫血为小细胞低色素性。脾多肿大，肝肿大。

少见。出现轻度或隐性黄疸。骨骼改变大都不明显或较轻。实验室检查：红细胞脆性减低，包涵体生成试验阳性，血红蛋白电泳分析出HbH。由于本病病人贫血较轻，常存活至老年。

(三) Hb Bart's胎儿水肿病，为最严重的 α 地中海贫血，见于东南亚一带，我国也有报道，因Hb Bart's对氧的亲合力极高，故组织严重缺氧，致使胎儿在母体内死亡或出生后1小时内死亡。

α 地中海贫血经红细胞脆性试验、包涵体生成试验、血红蛋白电泳等检查可确诊。

α 地中海贫血属祖国医学的“血虚”、“虚劳”等范畴。中医认为，肾为先天之本，主骨生髓，脾为气血生化之源，肾阳不足，脾失温煦，运运无力。脾肾两虚，则进一步导致血虚。其治疗，宜健脾补肾，益气补血。

方药：党参30克，白术10克，茯苓10克，炙甘草5克，黄精10克，枸杞10克，熟地10克，山药10克，黄芪15克，当归10克，白芍10克，紫河车粉3克（兑服），川芎5克。水煎服，每日1剂，连服50~100剂。

地中海贫血是一种遗传性疾病，严重的患者往往靠输血才能维持生命，相当一部分患者在儿童期即死亡，目前尚无有效的根治办法。轻型患者虽然没有明显症状，但在婚配后，可能生育出具有严重症状的后代。因此，患者必须采取措施，怀孕后做好产前诊断，杜绝这类遗传病胎儿出生，提高人口素质，于国于己，都有好处。

38. β 地中海贫血

地中海贫血是一组珠蛋白肽链量异常的血红蛋白病。临床特征为自幼发生的慢性、进行性溶血性贫血，呈小细胞、低色素性，伴有较多靶形细胞，肝脾肿大，并有种族和家族特性。

地中海贫血可分为 β 地中海贫血和 α 地中海贫血。

β 地中海贫血，是在我国较多见的Hb病，除多见于广东、广西外，浙江、上海、江苏、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、宁夏、西藏、内蒙古、台湾等均有报道。临床上根据其症状轻重不同分为：轻型、重型、中间型三种类型。

(一) 轻型：贫血轻微，肝脾大小正常或轻度肿大，成熟红细胞形态大小不等，异形和靶形-红细胞脆性减低。

(二) 重型：初生时多无症状，仅在分析脐带血时才能确诊。多数在出生后6~11个月发病。呈进行性小细胞低色素性贫血。肝脾明显肿大。轻度黄疸。病儿呈特殊面容，头大，额、顶、枕骨圆突，颧骨突出，鼻梁凹陷，两眼距离增宽。骨质疏松。颅骨板障增厚，内外板变薄。患儿发育迟缓，智力不受影响。皮肤及内脏可有铁粒沉积。常并发感染及缺铁性贫血。因贫血严重，患儿常发生充血性心力衰竭。实验室检查除有溶血性贫血的改变外，红细胞形态改变明显，常有靶形红细胞明显增加（达50~90%）。患儿的血红蛋白明显降低，网织红细胞增加多不明显。

重型 β 地中海贫血预后不良。

(三) 中间型: 多于4~5岁起病, 可活到成年。呈慢性贫血, 程度轻。患儿可有脾肿大, 包涵体形成较少。生长发育不受影响, 骨骼改变较轻。HbF明显增加。实验室检查有较多的靶形红细胞出现, 结合红细胞脆性试验、血红蛋白电泳, 即可确诊。

β 地中海贫血属祖国医学的“虚劳”范畴。根据患者面、唇、指甲苍白无华, 头昏眼花, 嗜睡乏力, 四肢不温, 手足心热, 心悸气短等表现, 属气血两虚, 治宜养阴助阳, 益气补血。

方药: 党参30克, 黄芪30克, 当归10克, 生地10克, 白芍10克, 熟地10克, 制附片10克(先熬1小时), 生姜5克, 大枣10克, 川芎5克, 麦冬10克, 肉桂3克。水煎服, 每日1剂, 连服2~3个月。

方中党参、黄芪益气, 四物汤补血, 附片、肉桂温阳, 生地、麦冬养阴, 共奏气血双补、养阴助阳之功效。

如患者阳虚症状(四肢不温)不明显, 可去附片、肉桂。如患者阴虚症状(手足心热)不明显, 可去生地、麦冬。

39. 急性肺原性心脏病

急性肺原性心脏病在我国较为少见, 其主要病因为肺动脉总干或大支的栓塞, 使肺循环突然大部分受阻, 引起反射性肺血管挛缩, 支气管痉挛及小气道闭塞, 产生肺动脉高压, 导致右心室扩张和急性右心衰竭。肺动脉栓塞还可引起

肺梗塞。

任何能引起肺循环阻力骤然增加的原因，都可导致急性肺原性心脏病。急性肺心病绝大多数都是由于严重肺动脉栓塞所致。这种栓塞主要是右心或周围静脉内血栓脱落所形成。

急性肺心病的症状：小的肺栓塞可不引起症状，大块或多发性肺栓塞时，患者可突然出现呼吸困难和紫绀，有胸闷、心悸和窒息感。肺栓塞引起较大范围的肺梗塞时，可有剧烈咳嗽、咯血，咳出紫黑色或鲜红色或大量泡沫性血痰。常有中度发热。病变累及胸膜时可出现剧烈胸痛。胸痛可短暂存在或持续几天。一般胸痛常位于下胸部，也可放射到肩部。肺栓塞引起急性肺原性心脏病时，患者心悸、焦虑、烦躁、出冷汗、恶心、呕吐、昏厥、血压急剧下降甚至休克，大小便失禁，可迅速死亡。如果患者能度过低血压阶段，可出现由肺动脉压增高引起的右心衰竭症状，患者亦可死于右心衰竭。有些患者可发生类似心绞痛的胸痛。

患者肺部叩诊可发现浊音，心率增快，可出现各种心律失常，呼吸急促，辗转不安，皮色苍白或有紫绀，冷汗淋漓，四肢厥冷，脉搏细弱不清。出现右心衰时，三尖瓣区可有收缩期杂音，颈静脉怒张，肝肿大并有压痛，可有黄疸，相继出现下肢水肿。

患者白细胞增高，中性粒细胞增多，血沉可增快。X线检查、心电图检查、心电向量图检查、肺扫描等有助于诊断。

急性肺原性心脏病属于祖国医学的“厥脱”、“水肿”、“心悸怔忡”、“胁痛”等范畴。中医认为厥脱症（休克）多由邪毒内陷或脏气受损，气血流行不畅所致。心肺同居上焦，

肺主气，心主血，气为血帅，气不煦则血不濡，肺朝百脉辅心而行血脉，故血的运行虽为心所主，但须赖肺气的宣通，方能贯心脉而通达全身。肺脏脉络瘀阻，导致心血不能流畅，出现心悸怔忡危候。肺为水之上源，肺气不宣，水道失于通调，又可导致水肿。水气凌心则心悸，气短加重，即造成心力衰竭。

急性肺原性心脏病的治疗，宜益气养阴，活血化瘀，回阳救逆，尤宜用多种剂型、多种投药途径的联合治疗（其治疗与慢性肺心病急性发作不同）。

抢救休克的急救处理

1. 宜静卧、忌搬动，采用头低脚高位，使精血充盈，滋润心脑。

2. 输液救阴：即用养阴针和增液注射液2000～4000毫升静脉滴注。

3. 回阳救逆：艾条灸关元穴15分钟，艾火与皮肤表面的距离以病人能够耐受为度。并用参附注射液20毫升加25%葡萄糖水20毫升静脉缓慢推注，每15～30分钟1次，连续3～5次。

神昏者，针刺人中、涌泉、足三里穴，或用清开灵注射液10毫升加25%葡萄糖水20毫升静脉注射，每隔1～2小时可重复1次，连续3～5次。

脉微欲绝或不能触及者，立即用参附青注射液20毫升加25%葡萄糖水20毫升静脉缓慢注射；或用枳实注射液5～10毫升加25%葡萄糖水20毫升静脉缓慢注射。

抢救心衰的急救处理

1. 针刺内关、心俞、肺俞、膻中、足三里、三阴交。不留针。

2. 参麦针或生脉针。每次20毫升加入25%葡萄糖水20毫升，静脉缓慢推注，每隔10~15分钟1次，连续3~5次。

辨证分型治疗

(一) 气阴耗伤型：神萎，面眈，气短，口渴，汗出，四肢欠温，舌淡红，脉细数无力。治宜益气养阴。

方药：人参15克，黄芪15克，麦冬15克，五味子10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

(二) 阳气暴脱型：神志淡漠，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，体温不升。舌淡，脉微弱欲绝或不能触及。治宜回阳固脱。

方药：红参15克，制附片（先熬）30克，干姜12克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

(三) 血瘀气滞型：突发气短，唇舌紫暗，咳紫黑色血痰，剧烈胸痛，痛有定处。舌紫，苔厚腻，脉弦涩。治宜活血化瘀。

方药：葶苈30克，大枣30克，三七粉6克（冲服），红参15克（另炖），桃仁10克，红花10克，赤芍30克，当归30克，川芎10克，苏木10克，熟地15克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

针灸治疗

1. 电针：取穴人中、素髎，或加内关、涌泉。轻者取单穴，重者取双穴或3穴。

方法：电针仪。

电压：6~9伏。

频率：106~120次。

2. 耳针：取穴肾上腺、皮质下、心。

方法：两耳交叉取穴，间歇留针，留针1~2小时。

40. 心源性水肿

心源性水肿系指冠心病心衰水肿、风心病心衰水肿、肺心病心衰水肿等，临床表现为下肢水肿、腹水、肝肿大、口唇紫绀、舌质紫暗或有瘀斑瘀点，尿少，颈静脉充盈。

心源性水肿属于祖国医学的“心悸”、“水肿”等范畴。《华氏中藏经》说：“人中百病难疗者，莫过于水也……。有肿于头目者，有肿于腰脚者，有肿于四肢者，有肿于双目者，有因嗽而发者，有因劳而生者，有因凝滞而起者，有因虚乏而成者，有因五脏而出者，有因六腑而来者，类目多种而状各不同”。《金匱要略》认为“心水者，其身重而少气，不得卧，烦而躁……”《奇效良方》说：“盖水之始起也，未尝不自心、肾而作”。《医方类聚》说：“夫水气之为疾，皆因脾元虚惫，土不制水。水属肾所主，土弱则水妄行，泛滥于四肢，始则注于皮肤，久则伤及五脏。……救之不早，败证出焉”。中医将水肿分为实证、虚证两大类，心源性水肿多属虚证，多由心、脾、肾阳虚，不能运化水湿所致。治宜益气健脾，通阳利水。

方一：茯苓50克，黄芪60克，人参叶30克，~~麦冬30克~~，夏枯草30克，葶苈子15克。水煎服，每日1剂，~~连服10~15剂~~连服10~15剂。

方二：桂枝15克，茯苓50克，白术30克，~~泽泻60克~~，泽泻60克，夏枯草30克，人参叶30克。水煎服，每日1剂，~~连服10~15剂~~连服10~15剂。

注：1. 茯苓用量在25克以下，利尿作用不显，欲达利尿，用量须在30克以上，有人用茯苓量达100克/日，利尿作用最强，未见中毒表现，唯用量在75克/日以上时，血中氯离子明显下降，宜用氯化钾或氯化铵调节。

2. 夏枯草既能利水，又能补钾。

3. 瞿麦为利水峻剂，有明显的丢钾作用，禁用于心源性水肿，请注意。

41. 急性心包炎

心包炎是心包膜的脏层和壁层发生炎症的一种疾病，它常是全身疾病的局部表现，或由邻近组织病变所波及。临床分急性心包炎和慢性心包炎两种。急性心包炎常伴有心包渗液。

急性心包炎的病因，常由肺结核、纵膈淋巴结核及胸膜结核直接蔓延或借淋巴、血行播散而侵犯心包，但有时不易发现原发病灶。本病多见于儿童及青年。常继发于菌血症、败血症或脓毒血症。可由放射菌、念珠菌、笄状菌等引起，也可由柯萨奇病毒、流感病毒、埃可病毒等引起，也可由寄生虫引起。此外，亦可由风湿、尿毒症、心肌梗塞、药物过敏、肿瘤转移、放射线损伤、胆固醇在心包液中形成结晶等引起。

临床表现：主要症状有发烧、心前区胀闷疼痛、心悸、呼吸困难、颈静脉怒张、肝肿大、胸水、腹水等。

具体症状可根据病因不同及人体反应不同而异。感染性

者多有发热、出汗、倦怠、厌食等。结核性心包炎起病较慢，有午后潮热，盗汗。化脓性者起病急，常有寒战、高热、大汗，中毒症状严重。非感染性心包炎症状较轻。肿瘤转移引起的心包炎可无发热。

心包炎患者的心前区疼痛多为锐痛或钝痛，可局限于胸骨后或心前区，亦可引起左肩、左臂、左肩胛区、颈部或上腹部的牵涉痛。炎症波及胸膜膈肌时，疼痛可随呼吸、咳嗽、吞咽、呃逆、扭动身躯、左侧卧、仰卧而加剧，身躯前倾时或采取坐位时疼痛可减轻。

急性非特异性心包炎常伴胸膜炎，疼痛特别明显。结核性心包炎及尿毒症性心包炎疼痛很轻。

大量心包积液可压迫周围器官引起一系列症状，如气管受压可产生咳嗽，气管、支气管及肺脏受压可产生呼吸困难。这些症状都在仰卧时加重，坐位时减轻。喉神经受压可致声嘶，食管受压可致吞咽困难。

心包炎患者听诊时可有心包摩擦音。在诊断上具有特征性价值。

测量血压时，可发现呼气期收缩压较吸气期高出10毫米汞柱以上，称为“奇脉”。

大量心包积液时，心脏可被推移向后，可压迫左后下肺，造成压缩性肺不张。检查时可发现左肩胛下角处叩诊变浊，触觉震颤增强，有支气管呼吸音，称“伊瓦征”。

心脏超声心动图检查、X线检查、心电图检查等有助于确诊。

急性心包炎属于祖国医学的“温病”、“内伤发热”、“心悸怔忡”、“支饮”、“胸痹”等范畴。中医认为多由风湿热邪留连日久，化毒损阴，或因温邪伤津，肾阴不足，痰浊淤

血，壅遏心包；或因邪热与痰饮互结上焦；或因饮邪内停所致。

辨证分型及治疗

(一) 风湿热型：午后低烧，周身发痒，心悸胸痛，目胀头昏，纳差，二便欠畅，舌红，苔黄腻、脉浮数。治宜祛风除湿，清热解毒，兼养心阴。

方药：银花30克，竹叶15克，黄连10克，芦根30克，茯苓30克，麦冬30克，琥珀粉10克，生牡蛎30克。水煎服，每日1剂，症状减轻后继以养心健脾、育阴潜阳等药物调治。

(二) 热伤阴津型：午后发烧，面色潮红，胸痛心悸，烦躁不安，五心烦热，舌红无苔，脉细数。治宜滋阴清心，凉血祛瘀，除痰宁心。

方药：生地30克，玄参30克，麦冬30克，丹皮15克，黄连10克，胆南星10克，炙远志10克，赤芍30克，茯苓30克，沙参30克，生牡蛎30克。水煎服，每日1剂，症状消失后继以归脾汤加减善后。

(三) 痰热互结型：身热面赤，胸闷，呼吸急促，大便秘，舌红，苔黄腻或燥，脉滑数。治宜清热化痰，逐饮散结。

方药：黄连10克，法半夏12克，瓜蒌30克，薤白30克，竹茹10克，大黄10克，丹皮12克，柴胡30克，赤芍30克，麦冬30克，银花30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

(四) 饮邪内停型：胸痛气憋，咳逆喘息，不得平卧，头昏心悸，肢体浮肿，小便短少。治宜利水逐饮。

方药：葶苈子30克，大枣30克，茯苓皮30克，苡仁30克，芦根30克，川椒10克，瓜蒌30克，车前草30克，白术30克，泽泻30克，生姜皮10克，桑白皮30克，麦冬30克，地骨

皮30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

42. 慢性心包炎

慢性心包炎又称缩窄性心包炎，继发于急性心包炎。

急性心包炎以后，可在心包上留下瘢痕粘连和钙质沉着。大多数患者只有轻微的瘢痕形成和疏松的局部的粘连，心包无明显增厚，不影响心脏功能，称为慢性粘连性心包炎，在临床上无重要意义。少数患者由于形成坚厚的瘢痕组织，心包失去伸缩性，明显地影响心脏的收缩和舒张功能，产生一系列临床症状，称为缩窄性心包炎（慢性心包炎）。换言之，慢性心包炎易发生心包缩窄。

慢性心包炎的症状有：劳累后呼吸困难常为缩窄性心包炎的最早期症状。后期可因大量的胸腔积液、腹水将膈抬高和肺部充血，以致休息时也发生呼吸困难，甚至出现端坐呼吸。大量腹水和肿大的肝脏压迫腹内脏器，可产生腹部膨胀感。此外可有乏力、胃纳减退、眩晕、衰弱、心悸、咳嗽、上腹疼痛、水肿等。

慢性心包炎可通过心电图检查、X线检查、心导管检查等确诊。

慢性心包炎属于祖国医学的“支饮”、“心悸怔忡”等范畴。中医认为系气滞血瘀，病久入络。其治疗宜活血祛瘀。

方药：桃仁10克，红花10克，当归30克，川芎10克，赤芍30克，玄胡10克，丹皮10克，香附15克，枳壳15克，乌药10克，桑白皮30克，茯苓皮30克。水煎服，每日1剂，连服

1~2个月。

43. 贫血性心绞痛综合征

贫血性心绞痛是一种由心肌一过性（暂时）缺血缺氧引起的以胸痛为主的临床症候群。

当血红蛋白低于7克，血液循环就有明显的代偿变化，出现心动过速，脉压增加，循环时间缩短，心输出量增加，心脏出现杂音等。当血红蛋白低于3克时，可引起心绞痛、全心扩大、心力衰竭等，特别当劳累、感染、妊娠时，心绞痛发生率更高。

贫血性心绞痛综合征的特点是阵发性胸前区疼痛、压迫感或难以名状的不适感，患者往往不能准确地描述。疼痛主要位于胸骨后，可放射至心前区、左上肢或颈与下颌部，劳累、精神刺激常可诱发，可持续数分钟之久。经休息或舌下含化硝酸甘油片，疼痛迅速消失。除冠状动脉病变以外，高脂血症、红细胞增多症、一氧化碳中毒、贫血、血红蛋白氧合曲线离解异常、心瓣膜病、心肌病、机体代谢增加、胆囊炎、低血糖等许多凡能导致心肌一过性供血供氧不足的疾病，均可出现“心绞痛”症状。

贫血性心绞痛综合征属于祖国医学“胸痹心痛”、“真心痛”等范畴。其病机责之于“本虚标实”，本虚者，或因体虚，思虑过度，耗伤心脾引起心之阴阳气血不足，尤以血虚证候突出。标实者，可因七情、膏粱厚味（高脂血症）产生之气滞，血瘀，痰浊，热结，阻遏胸阳，闭塞心络，痹而致

痛。其治疗宜补心气，养心阴。

急救处理

1. 寒心舒气雾剂，对准舌下，每次喷雾1~2下。
2. 热心舒气雾剂，对准舌下，每次喷雾1~2下。
3. 速效救心丸，1~2丸含服。
4. 心绞痛宁膏，贴敷心前区。
5. 苏合香丸1丸，嚼碎含化。

辨证治疗

(一) 心脾两虚：面色㿔白，心悸头晕，疲倦乏力，纳差。

方药：归脾丸，每次服6克，开水吞服，每日服3次。连服1~2个月。

(二) 气阴两虚：心前区隐痛阵作，气短乏力，五心烦热，汗多口干，眩晕耳鸣，面色少华，纳差腕胀。

方药：红参6克，麦冬30克，当归30克，熟地30克，黄精30克，制首乌15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

针灸治疗

取穴：内关、足三里、三阴交。

方法：每日针刺1次，获得针感，留针30分钟。

贫血性心绞痛综合征患者如果发作频繁（每日3次以上），程度较重者，应卧床休息。病情稳定时宜强调适量活动，以助气血流畅，但要量力而行，以不引发心痛为度。患者还应解除顾虑及恐惧心理，减少情绪波动，首先要纠正贫血，积极治疗，常服补血益气药如八珍汤、十全大补汤（丸）等，气旺血升，气血运行正常，则心悸、胸痛等症状自能痊愈。

44. 慢性风湿性心脏病

慢性风湿性心脏病是指急性风湿性心脏病后所遗留下来的心脏病变，以心脏瓣膜病变最为显著，即风湿性心瓣膜病或简称风湿性心脏病（风心病）。在慢性瓣膜病的基础上，还可以有活动性风湿炎症的反复发作，称为风湿活动。瓣膜发生病变后，闭锁不全与狭窄多同时存在，单独的狭窄或闭锁不全亦可发生。临床以二尖瓣狭窄和二尖瓣闭锁不全最为常见。听诊可有收缩期杂音，并向左腋部传导。自觉症状有心悸、疲倦乏力、呼吸困难、颧部和口唇紫绀，形成所谓“二尖瓣面容”，肝肿大与压痛，下肢水肿，腹水。X线检查、心电图检查、超声心动图检查有助于确诊。

慢性风湿性心脏病属于祖国医学的“心痹”、“心悸怔忡”、“水肿”等范畴。中医认为多由感受寒湿之邪，内犯于心，心气痹阻，气血亏虚，以致心慌、悸动不安，并可突发气喘（呼吸困难）、胸中窒闷，肢软乏力，下肢水肿等症。治宜养心祛邪，活血通脉。

辨证分型治疗

（一）心脉瘀阻：两颧紫红，唇甲青灰，头晕乏力，心悸怔忡，咳嗽甚则咯血，或有心痛，唇紫，舌质青紫或有瘀斑，脉细数或结代。治宜活血化瘀。

方药：桂枝10克，赤芍30克，丹参30克，红花10克，桃仁10克，远志10克，郁金15克，玄胡10克，党参30克，麦冬30克，五味子15克。水煎服，每日1剂，连服2~3个月。

(二) 气血两亏：心悸，动则尤甚，气短，汗出，面色苍白或萎黄，失眠。舌质淡胖有齿印，脉细弱。治宜益气养血。

方药：党参30克，黄芪30克，当归15克，桂枝10克，熟地20克，酸枣仁15克，龙眼肉15克，制首乌20克，大枣30克，炙甘草10克。水煎服，每日1剂，连服2~3个月。

(三) 心肾阳虚：面色晦暗，心悸浮肿，咳嗽喘急，重者不能平卧，手足欠温，舌淡苔薄，脉结代细弱。治宜温阳利水。

方药：制附片15~30克（先熬2小时），茯苓30克，桂枝10克，甘草6克，黄芪30克，麦冬30克，五味子15克，红参10克。水煎服，每日1剂，连服2~3个月。

食物疗法

口服柠檬汁：第一天服10毫升，以后每天加服10毫升，一直加服到每日300毫升为止，然后又逐日减少10毫升，直至减少到最初的每日10毫升为止。

柠檬汁具有抑制导致风湿病的链球菌的能力。医学做过实验，将纯柠檬汁倒在培养器皿内，15分钟后，培养器内的链球菌死亡率达89%，20分钟后死亡率达94.6%。

患者注意事项

(一) 要积极控制感冒或感染：风湿性心脏病与乙型A组溶血性链球菌感染有密切关系，当出现急性扁桃腺炎、咽喉炎、猩红热等乙型A组溶血性链球菌感染时，必须及时注射抗生素以控制感染，以免加重病情。当感冒或感染，特别是肺部的感染时，如不及时控制住感染，会加重心脏的负担，造成心功能不全。另外，感冒或感染会使患者防御机能减弱，对风心病极为不利。预防感冒或感染的主要方法是参

加适当的锻炼，经常到室外呼吸新鲜空气，提高身体对外界气候变化的适应能力。

(二) 要正确处理动与静的关系：风湿性心脏病患者的休息，应动静结合。适当的运动和体力劳动可增加心脏的代偿能力。没有出现心功能不全的患者可以照常工作和生活，只是应避免剧烈的运动和重体力劳动，尤其是主动脉瓣受累者应避免剧烈运动。

休息可减轻心脏负担，是治疗心功能不全的必要措施。轻度心功能不全者需要限制一般的体力活动。重者应限制日常生活活动，每天至少卧床休息12~14小时。严重者务必完全卧床休息，直至心功能改善为止。否则就会因心脏负担加重，造成心力衰竭而死亡。

(三) 要限制食盐的摄入量：风湿性心脏病到后期，由于心功能不全，常使体内潴留大量的钠而发生水肿。因此，风湿性心脏病患者在日常生活中，必须限制食盐的摄入量。钠摄入过多，体内的钠离子就会更加增多，无法排出，造成严重水肿，反过来又增加心脏负担。风心病人每天摄入的盐量应控制在1~5克。

(四) 宜节制性生活：风心病患者如果未见心脏扩大，并且从未发生过心力衰竭，则对结婚、生育、哺乳等无多大妨碍。由于性生活会使心跳加快，血压升高，心脏负荷加重，因此，风心病患者宜节制性生活。如果患者的心功能为Ⅱ~Ⅲ级，则不宜妊娠。如果患者的心功能为Ⅳ级，最好不结婚，待身体状况好转后再考虑结婚。

(五) 患者三忌

1. 忌吃香蕉。香蕉含钠较多，常吃香蕉会增加钠盐潴留，引起水肿，对风心病十分不利。

2. 忌吃高脂肪饮食。高脂肪饮食不易消化，会增加心脏负担。有的风心病患者一吃高脂肪饮食，立即引起心动过速。因此，风心病患者忌吃高脂肪饮食。

3. 忌精神紧张和情绪激动。不少风心病患者每当紧张、激动时，会突然发生心动过速，久久不能平静，甚至需药物帮助才能缓解。因此，患者要尽可能避免激动或紧张。

45. 原发性心肌病

近些年来，“心肌病”一词已渐渐地为人们所熟悉。随着心脏超声心动图等新技术的展开，医务人员已发现原发性心肌病的发病率和死亡率均在心血管疾患中占有十分重要的地位。

原发性心肌病迄今原因尚未清楚，发病率近年来似有上升趋势。

心肌病是指病人出现的病征，全部或主要是由于心脏功能失调所致的一种疾病。有一类是以全身性疾病的一部分形式出现，称作继发性心肌损害；有一类叫做原发性心肌病，或称特发性心肌病。一般将这类心肌病分作三大类。

(一) 充血型心肌病：这是心肌病中最常见的一种类型，多发生于20岁以上的成年人，也可见于儿童，其临床特点为心脏扩大，故也称扩张型心肌病。心脏瓣膜无异常。病变可侵犯传导系统，造成各种传导阻滞。

患者常于不知不觉中发病，经过数月或数年后才出现心功能不全的症状和体征。常表现为全心功能不全，常可出现

各种类型的心律失常，如心动过速、过早搏动、病态窦房结综合征等。在发病早期心脏尚无明显扩大时，可发生致命性的阵发室性心动过速、心室颤动或高度房室传导阻滞而猝死。心电图可出现多样异变的异常图形，如心室肥厚，ST段和T波改变等等。X线检查可见心脏向两侧扩大。

扩张型心肌病的发病原因大致有长期饮酒（包括啤酒在内）、营养不良、产后、病毒感染等。最近有人从体液免疫及淋巴细胞免疫的角度试图寻找导致本病的根源。

总之，此类心肌病为多种病因所致。为此，凡遇不明原因的心脏扩大、心力衰竭、心律失常或伴有血管栓塞现象出现时，需想到心肌病的可能，患者应及时到医院去作详细检查，进一步明确诊断。

（二）肥厚性心肌病：本型较少见，多发于儿童或青年，男女比例约为4:1，这是一种具有较强的家族遗传性心脏疾患，其主要表现为心肌不均匀的增厚，造成心脏排血障碍和心肌的柔顺性降低，病人表现头晕、胸痛、血压下降等，病变至晚期也会发生心力衰竭。因此，年龄在40岁以下，出现上述症状者，应作进一步检查，超声心动图对本病的诊断具有特异价值。

（三）限制型心肌病：本型心肌病极少见，是一种特殊类型的心肌病，主要表现为心脏舒张受到限制，不能有足够量的血液排出，导致肝脏肿大、浮肿、头晕、乏力、面色苍白、血压下降等一系列病态。这种心肌病常易与肝脏疾病、结核性心包炎等病相混淆。因此，遇到类似的病征时，应该认真加以区别。

原发性心肌病属于祖国医学的“气阴两虚”、“结代脉”等范畴。中医认为，心主血脉，脉为血之隧道，血虚则心失所

养。气为血之帅，心气虚则推动血液运行动力低下，故出现心衰及心脏进行性增大等一系列危候。其治疗宜益气养阴，养心活血。

方一：参麦注射液50毫升加入50%葡萄糖液40毫升作静脉推注，每日1~2次。也可将50毫升参麦注射液作直肠灌注，每日2次，灌注前嘱患者排尽大便。灌注后侧卧15分钟。病情严重者须连续使用参麦注射液3个月至一年。

方二：黄芪60克，人参叶30克，麦冬30克，五味子15克，黄精30克。水煎服，每日1剂。也可将煎液加热浓缩后放冷作直肠灌注。直肠灌注比口服效果好。直肠给药能保持药物性能，作用较快。肠道给药可以避免上消化道的酸碱度和酶对药物的影响，部分药物不通过肝脏而直接进入大循环，减少药物在肝中发生化学变化，因而能较好地保证药效的完整性。而且大肠吸收药物的速度较口服的快，其粘膜吸收在用药之后就立即开始。有人将安定注射液注入直肠，10分钟血中浓度即达高峰，维持1小时以上，与肌肉注射效果相当，有人用异戊巴比妥钠直肠和静脉给药进行抗惊厥实验，结果直肠和静脉给药显效速度无显著差异。直肠给药操作方便，在基层医院和家庭病床也能应用（见《中医急症通讯》1986年第10期）。

参麦注射液对病毒性心肌炎有较好疗效，对心肌病的治疗也显示出强心升压的良好前景，可代替能量合剂。

参麦注射液由人参、麦冬两味药组成，人参性微温味甘微苦，入脾肺二经，有大补元气，补脾益气，生津，宁神，益智等作用，麦冬甘微寒，味甘微苦，有润肺清心，养胃生津之功能。先贤对“参冬饮”方义早有阐述，如李士材《本草图解》云“人病困乏无力，身重气短，人参甘温，能益元气，

麦冬甘寒润燥气而清水源，殊有妙用。黄官繡《本草求真》云：“夫人参之所以能益人寿，以真力能补虚耳。同麦冬则可以生脉”。近年来制成针剂，对其作用机制更进一步深入研究，如四川省中药研究所邓文龙等人归纳了参麦针有10大作用：①有明显抗内毒素作用；②有明显激活机体网状内皮系统的作用；③有兴奋垂体-肾上腺皮质系统的作用；④有明显降低毛细血管通透性的作用；⑤有显著抑制IgE抗体引起过敏体质的作用；⑥可激活机体的细胞免疫；⑦有增强机体耐缺氧的能力；⑧有强心升压改善微循环作用；⑨有扩张冠状动脉改善冠脉流量的作用；⑩有双相调节作用。这10大奇用展现了参麦针的广泛用途。

患者注意事项

1. 宜注意休息。因劳累可增加心脏负担，使心律失常加重，甚至可致猝死。本病轻症须至少休息3个月，重症应休息1年以上。
2. 宜配合用能量合剂及大剂量维生素C，以改善心肌营养和代谢。
3. 解除思想顾虑，保证良好的睡眠。
4. 饮食宜淡，限制钠盐的摄入。忌吃香蕉。
5. 并发细菌感染者应及时作抗感染治疗。
6. 宜避免洋地黄中毒（地高辛等不能长期大剂量服用）。
7. 忌剧烈活动。
8. 忌房事，忌饮酒，忌抽烟，忌饮浓茶。
9. 忌猪肝与维生素C同时食入，因猪肝含丰富的微量元素铜，铜元素与维生素C同时摄入，能破坏维生素C。
10. 宜每天食用猪心，作为辅助治疗。这一食物疗法

对患者有益无害。这也是中医学中的脏器疗法，体现了“相同脏器相益”的全息相关性。李时珍把脏器疗法概括为24个字：“以胃治胃，以心归心，以血导血，以骨入骨，以髓补髓，以皮治皮”。这不无道理。因为哺乳动物脏器，不但与人体相应的脏器形似，而且，细胞结构、生化特性、生理功能也“质近”，富含营养物质，又具治疗相应脏器的有效成分。现已从动物心脏中提取到细胞色素C和激素，细胞色素C适于组织缺氧的治疗，对心肌病有效。心激素可治疗心力衰竭。

46. 直立性低血压

直立性低血压又称体位性低血压。多见于老年人，尤其多见于一些患有脑血管疾病的人，起床过猛、过快常会突然昏倒。患有直立性低血压的人久蹲、久站都会突然感到头昏眼花，甚至昏倒。这种直立性低血压对患有脑动脉硬化、冠心病、高血压的病人会造成一过性的大脑缺血、缺氧，容易诱发脑血管意外（中风）、心律失常以致心原性休克。

直立性低血压属于祖国医学的“眩晕”范畴。《证治汇补》说：“有早起眩晕，须臾自定，日以为常，谓之晨晕。”这种“晨晕”就是直立性低血压的具体表现。其治疗，宜益气补肾。

方药：人参6克（嚼服），黄精30克，菌灵芝30克（先煎）五味子15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

患有直立性低血压的人，夜间起床小便或早晨起床之前，

先宜活动四肢，或伸一下懒腰，这样活动片刻之后再慢慢起床，千万不要一醒来就猛然起床，以预防一过性大脑缺血。也可以在站立之前，先闭合双眼，颈前屈到最大限度，而后慢慢站立起来，持续约10~15秒钟后再走动，即可达到预防直立性低血压的目的。

47. 高原性低血压型脉压差小症

高原性低血压型脉压差小症是一种慢性高原适应不全症。多在移居高原较久或世居高原（在海拔4000米以上）的人群中发现。可有高原反应及低血压的症状，血压经多次测量均约在11.9/6kPa(90/60毫米汞柱)以下，脉压差小于2.66644kPa(<20毫米汞柱)。患者自觉症状有头晕、头昏、心慌气短、腰腿酸软、身疲乏力、烦躁少寐等。发病原因由于长期缺氧，心肌受损，体内组织胺含量过多及肾上腺皮质功能低下，而出现收缩压降低脉压差变小。

高原性低血压型脉压差小症属于祖国医学的“眩晕”、“怔忡”范畴。患者移居高原缺氧环境之中，则“天气不足”，而又饮食劳倦，肺气失充，肾水渐亏，复因劳倦，致气虚下陷，水火不济而致头晕心悸气短。治宜补气升陷，益阴补阳。

方药：生黄芪15克，党参30克，升麻10克，桔梗10克，柴胡10克，白芍10克，生地10克，枸杞子30克，生甘草15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

附注：本方为经验方，对高原性低血压型脉压差小症有良效。

48. 结节性多动脉炎

结节性多动脉炎为一种全身性疾病，又称变应性结节性皮肤血管炎，其主要病变为多个器官或系统的坏死性中、小动脉炎。皮损为多形性，但以沿小动脉分布的结节最多见。内脏病变以肾脏为主，常伴有发热、多汗和关节酸痛等症状。

本病病因尚不十分清楚，可能和感染（特别是病毒、链球菌）、药物（磺胺药、砷剂、碘化物、青霉素等）以及注射血清有关。

病损表现主要为结节，自黄豆大至杨梅大不等，主要分布于小腿，其它部位较少见。一般对称分布。颜色初期鲜红，后期色紫。结节中心可发生坏死，形成溃疡。

患者白细胞明显增多，中性粒细胞亦增加，有的患者嗜酸性粒细胞增多，血沉加快，丙种球蛋白增高。病变波及肾脏时，可有蛋白尿、血尿和管型尿。

本病症状错综复杂，易于误诊。须详细检查并作皮肤和肌肉的活组织检查才能确诊。

结节性多动脉炎属于祖国医学的“血证”范围。中医认为本病局部疼痛明显，痛有定处，呈现结节性块状物，多数患者舌紫，属血瘀为患。治宜活血化瘀。

方一：白花蛇舌草（水线草）30克，生地30克，当归30克，赤芍30克，川芎15克，川牛膝30克，银花30克，连翘30克，黄柏15克，知母12克。水煎服（本方适宜于结节性多动

脉炎前期服用)，每日1剂，连服1~2个月。

方二：制附片15克（先熬），桂枝10克，黄芪30克，川牛膝30克，当归30克，丹参30克，黄柏12克，三棱10克，莪术10克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月（本方适宜于结节性多动脉炎后期服用）。

以上两方均有改善局部血液循环，促进炎症吸收，调整组织的再生修复等作用。

49. 红斑性肢痛症(灼热足综合征)

红斑性肢痛症是一种少见的原发性血管性疾病，病因不明，可能与植物神经功能紊乱等有关。据观察，患者均发病于低温过后（特别是严冬季节），说明低温可诱发本病。患者绝大多数为青少年，女性偏多。本病为自限性疾病，无全身症状，病变主要发生在四肢远端（尤其是下肢），以对称性发作性疼痛为特征，夜间发作频繁。局部皮肤潮红、肿胀，有灼热感。双足下垂则疼痛加剧。疼痛呈阵发性（一般持续3~5分钟），刺痛或刀割样痛，个别患者疼痛难以忍受。本病遇热加重，遇凉则舒，发作时因为两足灼热，患者常赤足在室内行走，或将足伸出被外，或将足蹬在墙壁上，严重时，患者将足泡在冷水内才感舒适。只有少数病人在气温低时有畏寒感觉。

本病患者阵痛发作的间歇期则感患肢麻木胀痛不适，严重时行走困难。

原发性红斑性肢痛症红肿热痛症状严重，患者常抱足呼

叫。

有人把没有原发病者称为原发性红斑性肢痛症，而把其他疾病并发红斑性肢痛症者称为继发性红斑性肢痛症（可继发于脓胸、肾炎、结核等疾病），因为主要是两足发病（灼热疼痛），故有人又称为灼热足综合征。

红斑性肢痛症（灼热足综合征）属于祖国医学的“热痹”范畴。《石室秘录》中有“脚板红”、“手足痛”、“人脚中色红如火……”等论述。《症因脉治》说：“热痹之症，肌肉热极，……筋骨痛不可按，……阳气多，阴气少，阳独盛，故为热痹之症”。《类证治裁》说：“初因风寒湿邪郁痹阴分，久则化热攻痛”。中医认为本病多系湿邪侵袭，气血运行不畅，筋骨肌肉疼痛肿胀，甚至灼热难忍。其治疗，宜清热利湿，化瘀止痛。

辨证分型及治疗

（一） 湿热蕴结型：四肢末端发作性灼热疼痛、重着，痛处潮红。得冷则舒，得热加重，口苦，纳呆，便溏，舌红，苔黄，脉数。治宜清热化湿，通络止痛。

方药：苍术15克，黄柏15克，苡仁30克，川牛膝30克，知母12克，防己12克，赤芍30克，木瓜30克，丹参30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

（二） 瘀热互结型：肢端疼痛，反复发作，夜间尤甚，皮肤潮红，扪之灼手，痛不可近，得冷痛减，便秘，舌红绛，舌有瘀点瘀斑，脉数。治宜清热凉血，祛瘀止痛。

方药：生地30克，赤芍30克，白芍30克，丹皮12克，地龙15克，黄柏12克，僵蚕10克，大黄10克，玄胡10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

（三） 邪热伤阴型：肢端隐痛，缠绵不休，反复不愈，

夜间为甚，口干咽燥，舌红少津，脉细数。治宜清热养阴，通络止痛。

方药：生石膏30克，知母12克，甘草10克，白芍30克，玄参20克，生地30克，麦冬30克，银花30克，川芎10克，土茯苓30克，地龙30克，僵蚕10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

50. 椎-基底动脉供血不足

椎-基底动脉供血不足为前庭中枢性眩晕的脑血管疾病，多发生于中老年患者。患者多有动脉硬化史或颈椎病史。临床表现为一过性缺血发作（眩晕），发作后无明显后遗症。患者多于睡醒后突感天旋地转，头晕目眩，头痛如裂，稍变换体位或头项转侧，则眩晕增剧。患者除眩晕外，至少有一项下列神经系统症状或体征：一过性视力障碍、意识障碍、轻偏瘫、共济失调、各类感觉障碍、位置性眼震（均为一过性）。无中风先兆症状，也应排除耳源性眩晕（耳源性眩晕不是一过性的）。X线摄片检查可提示颈椎呈增生性改变。脑阻抗血流图检查可提示椎-基底动脉血流量减低。

椎-基底动脉供血不足属祖国医学的“眩晕”范畴。中医认为“诸风掉眩，皆属于肝”，又认为“无痰不作眩”。故肝风内旋，痰热上扰，皆能导致眩晕。而且本病多发生于中老年人，年迈体虚，精气亏乏，升降失常，气血无以化生，脏腑经络无所禀受，清阳不能出于上窍，而致头晕目眩。其治疗宜补益中气，平肝和胃，利湿化痰。

方一：白术15克，黄芪60克，当归30克，陈皮10克，升麻10克，清半夏10克，葛根30克，柴胡10克，党参30克，川芎15克、薄荷10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

方二：钩藤30克（后下），生地30克，白蒺藜15克，白芍30克，夏枯草30克，陈皮10克，天麻10克，草决明30克，泽泻30克，太子参30克，川芎15克，茯苓30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

方三：黄芪40克，制首乌30克，益母草20克，川芎20克，当归20克，地龙15克，赤芍30克，葛根30克，川牛膝30克，茯苓20克，生龙骨30克，生牡蛎30克，法半夏10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

加减：阴虚加生地、熟地各20克，偏于阳虚者加仙灵脾30克，血压高者加杜仲15克，颈椎增生加威灵仙15克、木瓜30克、白芍30克。

51. 血管性头痛

血管性头痛，又称血管神经性头痛。病因尚未明了。一般认为系血管舒缩功能障碍及大脑皮层功能失调所致。

血管性头痛可分为偏头痛型和非偏头痛型血管性头痛两大类。

偏头痛是由于发作性血管舒缩功能不稳定，以及某些体液物质暂时性改变所引起的疼痛，可有视幻觉、偏盲等脑功能短暂障碍的先兆，发作时可有恶心、呕吐等植物神经功能紊乱的表现。

临床表现

(一) 典型偏头痛：女性多见，常于青春期起病，呈周期性发作，至中年后逐渐减少。通常在清晨醒来时或白天发病。如有火星或五色彩光在眼前闪动，继而转为视野缺损，面、唇、肢体有麻刺感及轻度失语等。此种先兆症状历时数分钟至30分钟后消退。而后开始出现一侧性头痛。通常始自颞部、眼眶或前额部，扩展至半侧头部，也有遍及全头者。痛为搏动性钻痛、钝痛或刺痛，在1小时左右达到高峰，以后转为持续性头痛。头痛剧烈时常伴恶心、呕吐、便秘，偶有腹泻。病人畏光闭目，颞浅动脉搏动增强，眼、鼻充血和分泌增多。每次头痛持续数小时，有的可达1~2天。发作后大多疲倦思睡。有的数星期、数月发作1次，有的1年发作1次。女性病人头痛发作与月经周期有密切关系。间歇期病人完全正常。

(二) 普通型偏头痛：无明确的先兆症状，有一些前驱症状发生在头痛前数小时或数天，包括精神障碍、胃肠道症状以及体液平衡变化。头痛发作持续数天，双侧头痛，伴植物神经功能紊乱。通常有家族史。

(三) 丛集性头痛（也称偏头痛性神经痛或组织胺性头痛）：是一连串密集的头痛发作，每日一次或数次，持续数十分钟，最长不超过1小时。间歇期可数周甚至数年。一般于20~40岁起病，发作随年龄增长而减少，男较女多3~6倍。患者常在夜间睡眠中突然痛醒，为剧烈灼痛。伴随症状有流泪、眼结膜充血、鼻塞、流涕等。

(四) 基底动脉偏头痛：主要发生在少年或青年女性，与经期有显著关系。先兆症状为双侧视觉变化如黑蒙，还可有短暂性遗忘、呐吃、眩晕、耳鸣、步态不稳及双侧手足或

口周感觉异常等。在10~15分钟以后出现搏动性头痛，伴有恶心、呕吐。

以上各型偏头痛在发作期和间歇期中，脑电图检查可发现轻度异常。

非偏头痛型血管性头痛多数由脑动脉扩张引起，呈现弥漫的、深在的、两侧性钝痛与跳痛，常为头部震动或强烈摇动所加剧。本症可由高血压、脑循环供血不足、全身感染、缺氧、一氧化碳中毒、重金属中毒、亚硝酸盐中毒、癫痫发作后、慢性酒精中毒等引起。

血管性头痛属于祖国医学的“头风”、“脑风”、“头痛”、“偏头痛”等范畴。本病发作痛势剧烈，痛处固定，反复发作，缠绵不愈是其特点。中医认为，头为“诸阳之会”、“清阴之府”，乃髓海之所在，五脏精华之血与六腑清阳之气皆上注于头。故凡外邪上犯巅顶，稽留阻抑清阳，或内伤气血，淤阻经络，或情志不畅，用脑过度，皆可使脑失所养而发病。《医学精要》说：“头风即头痛也，浅而近者为头痛，解散之即安，深而远者为头风，作止无常，屡触屡发也”。《张氏医通》说：“头者，天之象，阳之分也。六腑清阳之气，五脏精华之血，皆朝会于高巅。天气所发，六淫之邪，人气所变，五贼之运，皆能犯上而为灾害。或蔽复其清，或坠遏其经隧，与正气相搏，郁而成热则脉满而痛”。《脉因证治》说：“头痛之症，或在半边，或两边……恼怒即发，痛引胁下，此肝火攻冲痛也，以上皆内伤之症。……诸经气滞亦头痛，乃经气聚而不行也”。《太平圣惠方》说：“夫头偏痛者，由人气血俱虚，客风入于诸阳之经，偏伤于脑中故也。又有因新沐之后，露卧当风，或读学用心，牵劳细视，经络虚损，风邪入于肝而引目系急，故令头偏痛也”。

血管性头痛的治疗，宜熄风止痉，活血化淤，补气益血。

辨证论治

(一) 气滞血瘀头痛：痛如针刺，钻痛，其痛多在头之一侧，可自行缓解，易反复发作，其痛每因情志刺激而发，女性则月经涩滞量少，经行腹痛，唇紫黯，舌紫或有瘀斑，脉细弦或细涩。治宜行气活血。

方药：延胡15克，当归30克，蜈蚣1条，全蝎3克，桃仁10克，红花10克，川芎15克，川牛膝30克，柴胡10克，枳壳10克，赤芍30克，桔梗10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(二) 风热夹瘀头痛：头痛偏于一侧，发作频繁，疼痛剧烈，痛处有跳动感。伴恶心、口苦、烦躁、便秘、尿短赤。舌红苔黄，脉浮弦数。治宜清热化瘀。

方药：川芎15克，白芍30克，黄芩30克，僵蚕10克，葱白3根，生姜10克，桃仁10克，菊花30克，龙胆草10克，夏枯草15克，地龙20克，蜈蚣2条，柴胡15克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(三) 血虚夹瘀头痛：头痛时作时止，日久不愈，或隐隐作痛，或剧痛难忍，痛处固定不移，伴头昏眼花，面黄肌瘦，手足麻木，心悸失眠。妇女每于经前或经期头痛发作或加剧。舌紫有瘀斑或瘀点，脉细涩。治宜养血祛瘀。

方药：当归30克，细辛6克，赤芍30克，熟地20克，川芎15克，桃仁10克，红花10克，鸡血藤30克，全蝎3克，蜈蚣1条。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(四) 风寒兼瘀头痛：头痛或偏或正，或巅顶连后头作痛，以胀痛或钻痛为多，遇风寒则痛作或加剧，伴肢体酸

痛，恶寒，鼻塞。舌质暗或有瘀斑，苔薄白，脉浮。治宜散寒祛瘀。

方药：川芎15克，荆芥10克，防风10克，白芷10克，羌活10克，当归30克，细辛6克，僵蚕10克，桃仁10克，红花10克，柴胡10克，蜈蚣1条。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(五) 血虚风动头痛：头脑昏胀而痛，左右交替痛作，或全头均痛，缠绵不愈，时有加剧，伴头目眩晕，恶心，手臂发麻，面色无华，舌淡苔白，脉细弱。治宜补血熄风。

方药：当归30克，白芍30克，熟地20克，川芎15克，细辛6克，鸡血藤30克，阿胶10克，地龙15克，枸杞15克，蜈蚣1条，全蝎3克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(六) 脾虚痰阻头痛：头脑昏沉而痛，晕多痛少，缠绵不休，遇阴雨则痛甚。面黄无华，两耳听力减退，便溏食少，眩晕怔忡，困倦体重，脘痞恶心，泛吐痰涎清水。舌淡胖，苔白腻，脉濡细。治宜健脾祛痰。

方药：茯苓30克，法夏10克，陈皮10克，当归30克，白术30克，竹茹10克，党参30克，细辛6克，苍术30克，牛蒡子20克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

在上述辨证分型治疗中，主要采用补血行瘀之法。补血首推四物汤（当归、熟地、白芍、川芎），行瘀首选血府逐瘀汤（桃仁、红花、赤芍、生地、当归、川芎、牛膝、柴胡、枳壳、桔梗、甘草）。分析诸药性能，可知：桃仁、红花去瘀生新，生地、赤芍凉血行瘀，当归养血活血，使瘀去而正不伤。川芎上行善散，有行血中之气，祛血中之风的功能，为活血止痛，治疗头痛之良药。牛膝导下，与川芎相伍，一升一降，通达上下，则气畅血行。柴胡疏肝解郁，升

祛清阳。枳壳、桔梗疏理气机，以畅血络，甘草调和诸药。诸药同用，共奏行气理血止痛之功。四物汤为调补全身营血的总方，熟地大补精血，当归补血行血（用量30克治头痛效果良好，用量少于30克效果较差），白芍和血敛阴，川芎活血定痛（治头痛用量15克以上效果良好，少于15克效果较差）。熟地、白芍为血中之血药，川芎、当归为血中之气药，两相配伍，可使补而不滞，营血调和，用于治疗头痛，寓“治风先治血，血行风自灭”之意。

辨病治疗

（一）典型偏头痛：

方药：川芎20克，川牛膝30克，琥珀粉10克（冲服），蔓荆子15克，僵蚕10克，生石决明50克（先煎），牛蒡子20克，当归30克，细辛6克。水煎服，每日1剂，重症病人每日可服2剂。连服10~15日。

（二）普通型偏头痛：

方药：葛根40克，蝉衣6克，川芎15克，白芍30克，白芷12克，细辛6克，柴胡15克，苍术15克，羌活12克，夜交藤60克，地龙30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

（三）丛集性头痛

方药：桃仁15克，川芎25克，赤芍30克，柴胡15克，黄芩15克，僵蚕15克，红花10克，生姜10克，川牛膝30克，葱白3根，麝香0.3克（冲服），青皮10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

（四）基底动脉偏头痛

方药：当归30克，细辛6克，熟地20克，川芎15克，赤芍30克，葛根40克，藿香10克，白芷10克，枸杞15克，丹参30克，鸡血藤30克，牛蒡子20克。水煎服，每日1剂，连服

10~15剂。

专方验方治疗

方一：地龙15克，虻虫15克，青皮15克，刺猬皮18克，土鳖虫18克，九香虫18克，蝉蜕10克，郁金18克，木香10克，川芎18克，蛭螂24克，僵蚕24克，鸡血藤24克，穿山甲21克，露蜂房12克，当归30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方二：川牛膝60克，川芎30克，茺蔚子15克，钩藤（后下）40克，香附15克，菊花15克，桂枝10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方三：吴茱萸15克，葛根60克，川芎30克，当归30克，白芷10克，僵蚕10克，细辛6克，白芍30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方四：赤芍50克，黄芪50克，党参50克，制大黄50克，黄芩50克，炙甘草50克，吴茱萸50克，茯苓50克，白芍50克，生地50克，当归50克，熟地50克，川芎50克，威灵仙50克，天麻50克，羌活50克，防风50克，柴胡50克，半夏50克，枣仁50克，五味子50克，制附片50克，蔓荆子50克，黄精50克，枸杞50克，泽泻50克，莪术50克，延胡50克，全蝎10克，蜈蚣3条，黄柏10克，生石膏100克，制马钱子10克。烘干，研末和匀，每日服20克，分2次服，温开水送服。

方五：当归30克，川芎30克，白芷12克，桃仁15克，菊花30克，白芥子10克，香附15克，柴胡20克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

加减：左侧头痛加龙胆草、黄芩；右侧头痛加藁本、独活；刺痛明显加红花、制乳香；久痛或痛不可忍加全蝎、蜈蚣、水蛭；体虚加黄芪、党参；失眠多梦加远志、菖蒲、夜

交藤；血压偏高加川牛膝、地龙、龙胆草、钩藤；食欲不振加陈皮、焦三仙。

方六：白芷30克，川芎30克，川乌12克，甘草12克，炒黄一半，研末，生熟粉末和匀，分成10包，早晚各服1包，用薄荷、茶叶煎水送服。

外治法

方一：川芎50克，白芷50克，炙远志50克，冰片7克，共研细末，瓶贮备用。

用法：用绸布或的确良一小块，包少许药末，塞入鼻孔，右侧痛塞左鼻，左侧痛塞右鼻，一般3~5分钟后头痛逐渐消失，有的塞鼻得嚏后，自觉七窍通畅而痛止。复发时再用有效。

方二：细辛10克，川芎10克，徐长卿10克，蜈蚣6克，山柰6克，冰片0.5克。分别研成细末后和匀，装瓶备用。

用法：用的确良或绸布一小块包药末少许，塞入鼻孔，左右交替塞用，每日更换1~2次，左侧偏头痛塞右鼻孔，右侧偏头痛塞左鼻孔。

方三：高良姜10克，细辛10克，羌活10克，川芎10克，白芷20克。共研细末，装瓶备用。

用法：左侧偏头痛，用手沾少许药粉闻入右鼻孔内；右侧痛闻入左鼻孔内。一般闻药后15分钟头痛即减轻，继而痛止。

方四：生草乌30克，生白附子30克，生天南星30克，葱白7根，生姜40克。各药研末后混匀。

用法：用一层纱布将药末包好，放入锅内隔水蒸热，敷痛处，但勿敷眼部。

方五：全蝎研末少许，置太阳穴，以胶布封固，每日一

换。

针灸治疗

(一) 体针疗法:

取穴: 风池、合谷、翳风。

配穴: 前额痛配印堂, 后枕痛配后溪, 体虚配足三里。

手法: 平补平泻, 留针30分钟。先针主穴, 后针配穴。

(二) 脚针疗法:

取穴: 脚底的心、肾二穴。

方法: 取一寸毫针, 刺入双脚底的心、肾穴, 先泻后补, 留针30分钟到1小时。

(三) 注线疗法:

取穴: 太阳、头维、印堂、风池、天应、曲池、合谷、足三里。

方法: 每次选2~3个穴位, 肠线注入穴位, 使局部形成强烈的良性灶, 长期不断地给皮层以冲动, 使邻近原有的病理兴奋灶被抑制。这种注线疗法能阻断痛觉冲动的诱导及阻滞恶性灶的病理充血, 能调整植物神经的功能, 使脑组织的微循环得以改善, 达到止痛作用。

(四) 穴位注射疗法:

药物: 天麻注射液或当归注射液。

主穴: 风池、太阳、合谷、阿是穴。

配穴: 攒竹、印堂、安眠、翳风。

方法: 每次选1~3穴, 每次注药1毫升。

附: 血管性头痛患者的保健措施

1. 宜常做伸颈运动: 常做伸颈运动能改善头部的血液循环, 解除紧张性刺激, 对血管性头痛患者的治疗有所帮助。

伸颈运动的全套动作是：把头转到右边，就象从右面回头向后看一样，把右手食指置于左脸颊，大拇指则置于下巴，轻轻地把头推向右边；同时用左手从头顶伸过去，把中指触到右耳顶部，然后轻轻地把头往胸部方向拉下（若这种动作会伤到筋，或感到头晕的话，应停止再拉）。

过10秒钟，改做相反方向动作，即把头转向左边也是10秒。如此反复，各做3次为1套。每天隔2小时做一套。

这项伸颈运动，作用在于伸展和放松颈部紧张的肌肉和纤维组织。肌肉和纤维组织的紧张性是由于精神压力、神经紧张、工作时头部和颈部位置不当以及头部受伤等所引起的。伸颈运动可以解除这种紧张性引起的头痛。

2. 宜采用“笑的疗法”：“笑疗”治疗头痛有较好的疗效。

英国著名化学家法拉第年轻时，长期从事科学研究工作，经常头痛和失眠，百药不效。有一位医师建议他采用笑的疗法（笑疗）。法拉第经过反复考虑，决定采用“笑疗”。从此以后，他经常看喜剧，每次都是大笑而归，全身轻松，久而久之，法拉第的顽固性头痛终于治愈了。

笑，能调节大脑神经，消除紧张，促进食欲和睡眠，增加消化液的分泌和消化道的功能，能调节植物神经系统的机能。

笑为什么能治头痛？因为很多疼痛是由于肌肉紧张造成的，或因肌肉紧张而加剧。而运用笑疗这种疗法，恰能使肌肉紧张程度缓和。

笑能刺激大脑产生苯酞二酚胺的激素，例如肾上腺素、去甲肾上腺素等等。这种激素是天然的麻醉剂，能解除疼痛，缓解慢性过敏症等。美国《星期六评论》的编辑诺尔曼·凯

迪在1964年得了一种使他只有1%生存希望的脊椎骨断裂症，疼痛异常。他违反医学正统的做法，在旅馆订了一个房间，有条不紊地阅读滑稽书并观看好笑的电影。他体会到笑可使他获得镇痛的效果，并能使他安睡2小时，他这样休养了几年，就完全恢复了健康。

由此看来，笑不仅能治头痛，而且也可以治疗全身疼痛。

3. 宜减少食盐摄入量：食盐会引起体内激素发生反应，从而导致周期性偏头痛，或者引起血管性头痛（血管突然收缩或过度扩张）。因此，在头痛时，如吃低盐饮食，就可以增加血管对几种周期性偏头痛的病因的抵抗力。反之。如果吃高盐饮食，则会加重病情，甚则疼痛难忍。因此，吃低盐饮食能减轻头痛。

4. 宜分散注意力：选择病人喜爱的音乐或戏曲，让病人听，边听边随节奏用手拍、点头等方式打拍子。听时，两眼集中注视某一处，或闭上眼睛。手可以放在收录机的音量开关上，疼痛加重时，音量开大，疼痛缓解时，音量关小，让注意力一直不放在自身的疼痛上。这样就能达到止痛的效果。

5. 宜做腹式呼吸：让病人闭目或注视某一固定物，缓慢地以鼻吸气，以口呼气，吸气时腹部凸起，呼气时腹部凹陷，呼吸尽量缓慢深长。同时用手轻轻抚摩疼痛部位。这种腹式呼吸止痛法，可使病人保持松弛，常可缓解持续性疼痛。有时，还可帮助病人入睡。

6. 宜擦清凉油：可在前额或太阳穴揉擦清凉油。因为清凉油含有薄荷脑，它可封闭疼痛传入的信号，同时它引起局部的刺激，这一刺激在大脑引起新的兴奋灶，从而掩盖了

疼痛的刺激。也有人解释，人体内的止痛物质内啡肽在薄荷脑的刺激下，可充分发挥它的止痛作用。

7. 头痛患者三忌：

(1) 忌遇事紧张。即使是健康人，遇事紧张，久而久之也会引起头痛。头痛患者更应豁达开朗，不管出了什么事也要泰然处之。这样，头痛就会渐渐痊愈。

(2) 忌睡眠不佳。睡眠不佳常易引起头痛。因此，头痛患者要保证充足的睡眠。睡前洗热水脚等措施往往有助于头痛的缓解。

(3) 忌感冒时过度用脑。人们一旦感冒，本来就有头痛等症状，此时要是再过度用脑（如写材料、作统计报表、演算等等），势必使头痛加剧。因此，除了积极治疗感冒外，应让大脑得到休息。

52. 痉挛性斜颈

痉挛性斜颈是由颈肌阵发性的不自主收缩，而引起头向一侧扭转或阵挛性的倾斜。本病可单独存在，属于中枢性的基底节病变，亦可为扭转痉挛或手足徐动症的组成部分。也有的属于癔病性斜颈，也有的属于局部刺激（颈肌炎、颈椎骨损伤或关节炎、邻近的感染灶）所引起。

痉挛性斜颈可发生于任何年龄，但以成年人起病为最多见。起病缓慢（癔病性者则骤然起病）。颈部的深浅肌肉均可受累，但以胸锁乳突肌、斜方肌及夹板肌的收缩最易出现症状。一侧胸锁乳突肌收缩时引起头向对侧旋转，颈部则向收

缩肌一侧屈曲。两侧胸锁乳突肌同时收缩时则头部向前屈曲，称“颈前倾”。两侧斜方肌及夹板肌同时收缩时，则头部向后过伸，称“颈后倾”。颈肌的收缩多呈阵挛性跳动。患肌可发生肥大。

痉挛性斜颈早期因症状轻微而往往被忽视，但以后症状严重时则必须用很大力气才能把向一侧扭转的头部搬回原位。

痉挛性斜颈的诊断十分容易，但必须辨别其为中枢性或癔病性或局部原因引起者。癔病性者起病急骤，且必有精神因素，暗示疗法有效。局部原因引起者可发现局部病灶，除此两者外则系中枢性病变所引起。

痉挛性斜颈类似于祖国医学《伤寒论》中的“项背强几几证”，中医认为多系邪入太阳，营卫失调，经气不利，阻滞津液运行，筋脉失其濡养，故见痉强之证。其治疗宜舒通筋脉，调和营卫。

方药：白芍60克，甘草15克，葛根60克，大枣30克，桂枝12克，生姜10克，路路通30克。水煎服，每日1剂，连服60剂以上。

注：本方白芍、葛根均须重用，疗效才好。

53. 腔隙性脑梗塞

腔隙性脑梗塞，是指位于大脑半球深部和脑干的缺血性微梗塞，系大脑前、中、后动脉，基底动脉及椎动脉的深穿支闭塞所致。亦称“腔隙性中风”或“深穿支闭塞”。

临床表现：一侧肢麻木或无力，语言不利，眩晕，步态不稳，突然动作笨拙，但神志清楚，或伴有面瘫、舌瘫、肢瘫及感觉障碍。

患者多于白天或晨起或睡后发病，发病高峰时间多为1~3天。冬季发病较少见。

本病经CT检查可确诊，脑电图检查也有诊断价值。

腔隙性脑梗塞属于祖国医学的中经中络范畴。《金匱要略》云：“邪在于经，即重不胜”，认为气虚淤阻、风中经络是腔隙性脑梗塞的主要病机。清代医家王清任认为，中风先兆多由于元气亏损，口眼歪斜、口角流涎、语言蹇涩皆属气虚。患者平素多有神疲乏力、语言低微、自汗、少气懒言、食少、舌胖或有齿印、脉虚弱等表现。其治疗宜益气，活血，通络。

方药：黄芪60~90克，地龙30克，当归15克，赤芍15克，川芎30克，生地20克，桃仁10克，红花10克。水煎服，每日1剂。连服30~60剂。

加减：挟风加白芷、僵蚕、防风、葛根，挟痰加瓜蒌、大黄、胆南星、菖蒲，挟火加钩藤、石决明、天麻。配用复方丹参针及低分子右旋糖酐可提高疗效。

腔隙性脑梗塞的发病与高血压有密切关系，患者大部分有高血压病史。据第一军医大学中医系报道，血压改变对腔隙性脑梗塞病程有一定影响，腔隙性脑梗塞并发高血压病时，如果发病时血压正常，其恢复反而差。

54. 肝豆状核变性

肝豆状核变性是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍所引起的家族性疾病。主要病理改变为豆状核变性和肝硬化。临床表现为进行性加剧的肢体震颤、肌强直、构音困难、精神症状、肝硬化及角膜色素环等症状。

正常人每日从饮食中摄取铜约2~5毫克。从肠道吸收的铜立即在血液中与清蛋白疏松地结合并进入肝脏，其中一部分由胆管排泄，回至肠道，再由大便排出。另有小量的铜自尿中排出。这是正常人的铜代谢。

肝豆状核变性患者的铜代谢发生障碍，患者肠道对铜的吸收量超过正常人，血液中与清蛋白疏松结合的铜不能正常转化和排出，大量铜盐沉积，引起肺、脑、肾等组织的损害，在角膜形成特征性的色素环。神经系统的主要病理变化在豆状核。肝脏通常缩小，质地坚硬，表面有结节，属结节性肝硬化。

患者肝脏合成血清白蛋白的功能差，患者的肝脏通过胆汁排铜也减少，铜滞留在肝脏，肝脏受损，发展成肝硬化。游离铜在肝脏内淤结达到饱和状态后，大量释放入血，引起红细胞受损，发生溶血性贫血。游离铜释放入血，进而侵入脑组织，脑组织受损，出现神经症状如构音不清、肢体震颤等。这种病的治疗难度较大。

肝豆状核变性在10~20岁间起病，家族中可有多同病患者。神经系统最初的症状往往是一侧或两侧上肢粗大的震

颤，这种震颤在运动时增强，静止时减轻。重者可扩及下肢、躯干及头部。有时可出现舞蹈手足徐动症、扭转痉挛或痉挛性斜颈等不自主运动。有的患者以精神异常为首现症状。早年起病者以肌强直、肌紧张不全及构音障碍为主要症状。肢体的随意运动减少。面容缺乏表情，如“面具脸”样，亦可有不能自控的哭笑。后期，四肢屈曲挛缩，吞咽困难，唾液外流，精神衰退，性格改变。个别病人可发生癫痫或偏瘫。患者感觉正常，但可因肌肉的强直收缩而引起疼痛。

患者眼部角膜边缘与巩膜交界处常有金黄色或绿褐色色素环（须用眼科的裂隙灯检查方能发现），这是肝豆状核变性的特征，也是这种病诊断的可靠依据。

少数患者的首现症状为黄疸、腹水、脾肿大、食道静脉曲张出血。多数病人有肝硬化，但却无肝功能受损的临床表现。有的患者可发生急性溶血性贫血、白细胞减少、血小板减少。有的患者有骨质疏松，容易发生骨折。

肝豆状核变性多为隐匿起病，病程进展缓慢，病程可延续30~40年。神经症状（构音困难、肢体震颤等）出现越早则病情进展越快，如不及时治疗，最后可因肝功能衰竭或并发感染而死亡。

肝豆状核变性可通过实验室检查（尿铜量、血铜氧化酶、血清铜）而确诊。

肝豆状核变性属于祖国医学的“痉证”、“瘈瘲”等范畴。中医认为，诸风掉眩，皆属于肝，肝风内动，筋脉失于濡养，导致肢体震颤等一系列症状的出现。《金匱要略方论本义》说：“脉者人之正气，正血所行之道路也，杂错于邪风，……则脉行之道路必阻塞壅滞。而拘急痉挛之证见矣。”《血证论》说：“肝主筋，肝病则惊悸、筋挛……”。《景岳全书》

说：“阴虚血少之辈，不能养营筋脉，以致搐挛僵仆。……”
《医学原理》说：痉证“有气虚不能引导津血以养筋脉而致者……。虽有数因不同，其于津血有亏，无以滋荣经脉者。”不难看出，津血亏虚，筋脉失于濡养，也是导致本病的原因之一。肝豆状核变性的治疗，宜养肝柔肝，清热息风，养阴活血。

辨证分型及治疗

(一) 肝阴不足，虚风内动：肢体震颤，流涎，口不能闭，吞咽困难，便秘，舌红少苔，脉细数。治宜柔肝养阴，活血息风。

方药：生地60克，白芍30克，麦冬30克，阿胶12克，鸡子黄1个，钩藤30克，黄连10克，枸杞15克。水煎服，每日1剂，连服60剂。

(二) 肝风内动，气血痹阻：构音不清，四肢颤动，步态不稳，全身痉挛。舌紫暗，苔黄腻，脉弦。治宜柔肝息风，化瘀活络。

方药：枸杞15克，菊花30克，丹参30克，白芍60克，赤芍30克，钩藤40克（后下），菖蒲10克，白蒺藜15克，生首乌30克，萆薢15克。水煎服，每日1剂，连服60剂。

验方治疗

方一：大黄10克，萆薢20克，黄连10克，半枝莲30克，生首乌30克，穿心莲30克，黄芩30克。水煎服，每日1剂，连服4周为1疗程。亦可长期服用本方，作为维持疗法。

方二：大黄15克，芒硝5克（冲服），枳壳10克，厚朴15克，生地30克，麦冬30克，山药15克，萆薢30克。水煎服，隔日1剂，连服30剂。

以上两方系清热解毒，通腑利尿之品。生首乌含锌丰富。

锌离子既可在肠道内抑制食物中铜的吸收，又可以促进体内铜离子的排泄。黄连、萆薢皆系低铜高锌之药，半枝莲、大黄、萆薢、黄芩均有通腑利尿之功，是排铜的理想药物。

患者注意事项

患者应进食高蛋白低铜食物，减少消化道对铜的吸收。牛奶、蛋类、大米、青菜、白菜的含铜量低，可多吃。动物肝、动物血、各种贝类、螺类、蟹类、虾类、蕈类、坚果类均为高铜食物，必须禁食，豌豆、蚕豆含铜量也高，也必须禁食。

中药蜈蚣、全蝎、僵蚕、地龙、果仁类药物（如杏仁、桃仁、郁李仁等），含铜量也高，也必须禁用。

55. 一氧化碳中毒性精神病

长期在高浓度的一氧化碳环境中工作，可产生慢性一氧化碳中毒。病人烦躁不安，容易激怒，注意力不集中，记忆力减退，工作能力下降，失眠，多恶梦，可伴有胃肠道的功能障碍。

冬季在居室内煤炉旁烤火，门窗紧闭，煤气排不出，可引起一氧化碳急性中毒，并可引起精神病。

急性中毒表现为程度不一的意识障碍，严重者则陷入昏迷。有的严重中毒患者，在从昏迷状态复苏后，经过1周至3个月精神状态几乎完全正常的清醒期（假性痊愈期），突然出现严重的意识模糊-智能减退症状群。病人迷失路途，不知归家，行为怪异而缺乏目的。病情迅速进展，在短期内即丧失

了工作能力和料理生活的能力，变得言语杂乱，词不达意，大小便失禁，定向错误，注意力涣散，领悟困难，无目的地摸索和抓握。有的患者抗拒、违拗、缄默不语，或伴有片断的幻听和妄想。病程进展，最后转入严重痴呆状态。病人表情刻板，动作缓慢，步态不稳，共济失调，容易出汗，皮肤容易起水泡。

根据患者的一氧化碳中毒病史及以上的临床表现，诊断不难。

慢性中毒患者，只要脱离毒物接触，均可康复。急性中毒引起的精神病，可采用中西医结合治疗。

中医认为一氧化碳中毒性精神病系邪毒蒙蔽心窍，或系痰火上扰神明，致成癫狂。治宜芳香化浊开窍，继则以填补肾阴，益髓通窍以复神明。

方一：苏合香丸（成药），每次1~2粒，每日服2次，连服1~2个月。

方二：辟秽丹（苏合香丸去麝香和犀角，加黄连、蚤休）5克，每日服2次，连服1~2个月。

方三：礞石滚痰丸，每次服10克，每日服2次，连服1~2个月。

方四：木香6克，沉香3克，丁香3克，檀香6克，香附10克，郁金10克，胆南星10克，共研细末，每次服6克，用甘草10克、浮小麦30克、大枣30克煎汤送服，每日服3次，连服1~2个月。

以上4方可任选一方服用，继则以补肾益髓为治：

方药：山药30克，生地30克，熟地30克，山萸肉30克，地龙15克，当归30克，川芎10克，茯苓15克，泽泻15克，桂枝10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。也可服杞菊地

黄丸、归脾丸调理。

56. 瘧病性失音

瘧病性失音属瘧病的一种表现。瘧病患者突然失去发音能力，常借助手势或书写以表达思想，有的患者可发出嘶哑或耳语声，检查患者声带，无炎症，无器质性损害，声带活动正常。

祖国医学对失音早有记载，古代称“急瘖”、“喉暗”，包括瘧病性失音在内。《医学纲目》说：“瘖者，邪入阴部也。经云：邪搏阴则为瘖。又云：邪入于阴，搏则为瘖”。《景岳全书》说：“此外复有嚎叫、歌唱、悲哭，及因热极暴饮冷水，或暴吸风寒而致瘖者……但知养息，则弗药可愈”。中医认为，寒气客于会厌，则气道不利，即不能发扬而高，又不能抑制而下，开阖俱有不便，故卒然失音。瘧病性失音多为暴惊卒恐，气机逆乱而致。“恐则伤肾”，肾伤则气下，气不能上承会厌鼓动声道，肺气不利。“惊则气乱”，气乱则扰动心神，声无所主，窍而瘖也。《直指方》有“心为声音之主，肺为声音之门，肾为声音之根”的说法。

针灸疗法治疗瘧病性失音有较好疗效。

针刺疗法

取穴：扶突、廉泉、合谷（均双侧）。

方法：用泻法，仅合谷留针15分钟。

扶突穴位于喉结旁开三寸，属大肠经，有理气化痰，清利咽喉作用，可治失音。廉泉位于喉结上凹陷中，属任脉，

有通利咽膈、清热化痰作用,可治失音。合谷是大肠经穴位,可疏风解表,通经开窍。可治音哑。

耳针疗法

耳穴:复音穴(原耳穴心与气管之间)。双耳选定穴位后消毒,快速进针,大弧度捻转,进针同时令病人发“啊”音,留针15~30分钟。

中医认为耳为经脉所聚,耳不但与经络有关,而且通过经络与脏腑也关系密切。“复音穴”所在部位很接近耳穴的心区,针感可影响心经之脉。“舌为心之苗”。通过心经之脉的经络调整而起治疗作用。

电兴奋疗法

取穴:复溜、内关、外关、风池(双侧),哑门,人中。

治疗方法:①感应电流刺激:复溜(双侧)通电30秒钟,风池(双侧)通电10秒钟,内关(双侧)通电30秒钟。②直流电刺激:内关和外关两穴对刺激,每次通电各1秒钟,反复3次;哑门和人中两穴对刺激通电半秒钟,反复3次;风池穴(双侧)每次通电半秒钟,反复3次。

[注]:在治疗时,正负电极不考虑。电量开至患者能耐受的最大限度。在操作治疗中,不时引诱病人说话,言语随音增而渐渐清楚。

57. 神经性厌食

神经性厌食是胃神经官能症的一种类型,是一种以厌食、严重的体重减轻和闭经为主要表现,而无器质性原因的综合

征。此病在国外较为常见，病人多为20岁以下的女性，均有某种与饮食相联系的精神障碍，对体内生理刺激有错误的感觉。厌食往往有企图节制饮食以保持身材苗条的动机。病人多数自我感觉良好，行动活泼敏捷。有的病人可自相矛盾地对食物保持兴趣，甚至饱餐，但事后又偷偷吐掉。有少数病例，长期少食并伴有呕吐，体重可减轻40~50%而致极度衰弱。

神经性厌食属于祖国医学的“郁证”、“食郁”范畴。《不居集》说：“……百病皆生于郁，……丹溪推而广之，则有气血痰火湿食六郁……”《景岳全书》说：“郁病大率有六，……或七情之邪郁，……食郁而成痞满……”。《冯氏锦囊秘录》说：“郁病多在中焦，中焦脾胃也，水谷之海，五脏六腑之主，四脏一有不平，则中气不得其和，而先郁矣”。《张氏医通》说：“郁症多缘于志虑不伸，而气先受病，……然郁症多患于妇人，……”《万病回春》说：“食郁者，暖气作酸，胸腹饱闷……，恶食不思，右关脉紧盛也。”《证治汇补》说：“七情不快，郁久成疾，……或为痞满，……女子则经闭……”。《证治汇补》的这段描述，与神经性厌食十分相似。可见古代中医学家的认识，并积累了丰富的防治经验。

神经性厌食的治疗，宜理气解郁，开胃健脾。

中药治疗

方一：柴胡15克，枳实10克，白芍15克，甘草10克，党参30克，鱼腥草30克，白术15克，茯苓15克，山楂30克，神曲30克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

方二：木香10克，砂仁6克，陈皮10克，生姜10克，川芎10克，槟榔10克，柴胡15克，厚朴12克，香附10克，苍术

10克，神曲30克。水煎服。每日1剂，连服5~7剂。

针灸治疗

取穴：内关、足三里、三阴交、中脘、承山。得气后留针20分钟，每5分钟行针一次。以上诸穴可交替选用。

也可单独灸足三里(双侧)，艾条悬灸、隔姜灸均可。

心理治疗

开导病人多进食，暗示身材苗条并不是美，让病人记取古代宫女为了“杨柳腰”而饿死的悲惨教训。必要时请两名食欲旺盛的妇女，在病人面前狼吞虎咽地吃东西，很可能病人也跟着不知不觉地吃起来。这样，神经性厌食症也可能不药而愈。

按摩治疗

(一) 上腹横摩法：患者仰卧，医者以手四指或两手四指掌侧并置于腹部左侧或右侧之腹哀、章门穴处，经关门、太乙、商曲至对侧腹哀、章门穴处止，反复横摩5~10分钟。横摩在腹哀、章门穴处时，用力可稍大，至腹中部时用力应缓而小。

此法之作用为补脾阳、助运化、宽胸肋，对防治神经厌食有较好疗效。

(二) 推上腹法：患者仰卧，医者站其头部前方，以两手拇指掌侧对置，其余四指分置腹部两侧，推动时自剑突下鸠尾穴处经上脘、中脘、下脘至水分穴止，反复直推3~5分钟。推动时，主要是两拇指着力，其余两手四指仅起扶定腹部的作用。如患者皮肤干燥，可蘸酒推动，以免擦伤皮肤。此法之作用，调理脾胃，顺气降逆。

(三) 顺气法：患者直坐，医者站其侧，以一手掌心置于患者胸骨璇玑穴处，另一手掌心横置于背部上方大椎穴

处，自上向下沿胸、背正中线各摩动至胸前中庭穴处及背部下方至阳穴处，反复操作5~10分钟。操作时，两手在胸、背前后应同时摩动，用力应均匀而有节律。此法之作用为顺气和胃，宽胸利膈，治疗神经性厌食有一定效果。

58. 神经性暖气

神经性暖气是胃神经官能症的一种类型。病人有反复发作的连续性暖气，企图通过暖气来解除他认为是胃部充气所造成的腹部不适或饱胀。事实上暖气是不自觉地频繁地吞入大量空气的结果。神经性暖气有癔病的色彩，常当众暖气不止。

神经性暖气属于祖国医学的“噫”、“噫气”范畴。指气从胃中上逆，冒出有声，其声沉长，不似呃逆声急短促。多因精神抑郁，胸闷腹胀，气鸣攻窜，暖气方舒。或因脾胃虚弱，或胃有痰火、食滞，使气滞中焦而上逆所致。也有因肺气不降而暖气者。治宜和胃，理气，降逆。

方一：党参30克，槟榔10克，乌药10克，沉香3克，麦芽30克，木香10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

方中党参健脾扶正，沉香、乌药、木香顺气降逆，槟榔行气消积，麦芽健脾化滞。诸药合用，有和胃降逆之功。

方二：旋覆花10克，代赭石30克，法夏10克，厚朴10克，砂仁6克，藿香10克，香附15克，白术20克，党参30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

加减：胃中寒冷加干姜、山药、扁豆。腰膝酸软、消化

不良者加炮姜、大枣、陈皮、茯苓、山药。胃中有热、口臭者加生石膏、山栀。

神经性暖气患者应适当参加文娱体育活动，使生活有规律，保持乐观开朗的情绪。体育活动可以从做广播体操开始，打太极拳，逐步增加运动量，增强体质，这样，可使暖气逐步减少以至消失。

患者及其家属可根据具体情况，作简易按摩治疗（患者也可作自我按摩）。

方法一：拇指掐住内关，食指按住外关，作内外关对按（对掐），以患者有酸胀麻重感觉为度，操作时间一般为5～15分钟。

方法二：拇指按掐神门穴，用力须稍重，以能产生酸麻胀沉的感觉为度，反复按掐5～15分钟。

59. 癔球症

癔球症是胃神经官能症的一种类型（胃神经官能症的其他类型有神经性呕吐，神经性厌食，神经性噎气）。

癔球症是主观上感觉有某种说不清楚的东西或团块，在咽底部环状软骨水平处引起阻塞不适。此病多见于绝经期妇女，少数见于青年男女。患者在发病中多有精神因素，性格上有强迫观念，经常做吞咽动作以求解除症状，实际上在进食时症状消失，无咽下困难，长期无体重减轻的表现。

体格检查不能发现咽喉部有任何器质性病变或异物。

癔球症，祖国医学称之为“梅核气”。患者自感咽喉部如

有梅核堵塞。《金匱要略》谓“咽中如有炙脔”，吞之不下，吐之不出。多由肝郁气滞痰凝所致。患者常感胸脘痞闷，气郁不畅，呕逆恶心。多见于癭病。《内经》曰：“诸气贲郁，皆属于肺”。此乃肺气不舒，宣降失常之故。治宜疏肝解郁，散结利膈。

方一：桔梗10克，枳壳10克，苏梗10克，木蝴蝶6克，郁金15克，射干10克，旋覆花10克，灵仙15克，甘松15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方中桔梗枳壳一升一降，宣通肺气，佐以苏梗郁金宽胸解郁，射干、木蝴蝶、灵仙、旋覆花利咽化痰，诸药合用，共奏疏气解郁、豁痰利咽之效。特别值得提出的是，灵仙配甘松，治疗咽喉有异物感之梅核气具有良效。

方二：苏子15克，法半夏10克，厚朴15克，前胡10克，陈皮10克，当归10克，甘草3克，沉香3克，生姜3片。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

本方以苏子为君，伍以厚朴、陈皮、沉香理气降浊，半夏、前胡、生姜疏散痰结，佐以当归之甘润，生姜、厚朴、半夏的温燥，甘草调和诸药，共奏行气散结之效。

方三：旋覆花10克，代赭石30克，党参30克，生姜6克，厚朴10克，茯苓15克，沉香3克，莱菔子30克，甘草6克，大枣30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

60. 排尿性晕厥

晕厥是一种短暂性意识丧失，常由血液循环紊乱所致

(其他原因亦可引起)。排尿性晕厥就是其中的一种。

排尿性晕厥多见于青壮年男性，大多是在睡眠起床排尿时或排尿后出现短暂性意识丧失（自觉天旋地转，立即失去知觉而倒在地上）。发作前无明显先兆，发作（晕厥）后意识亦能很快恢复。一般认为排尿性晕厥的发生与下列因素有关：①迷走神经张力增高。②体位改变，反射性使周围血管扩张。③排尿时腹压骤然降低等使血管运动中枢不能立即起调节作用，结果引起血液循环紊乱，产生暂时性脑缺血而导致晕厥。

排尿性晕厥属于祖国医学之“眩晕”范畴。中医认为多系上实下虚，气机逆乱所致。《素问》云：“诸风掉眩，皆属于肝”。《重订严氏济生方》：“肝风上攻，必致眩晕，所谓眩晕者，眼花屋转，起则眩倒是也”。《验方新编检要》说：“晕眩虽小症，然而大病皆起于晕眩，眼目一时昏花，卒致猝倒……，宜早治之”。排尿性晕厥的治疗，宜疏肝降逆，调和气血。

方药：柴胡15克，白芍30克，当归30克，黄芪60克，枳实10克，甘草10克，菖蒲10克，金樱子30克，桑螵蛸10克，柏子仁15克，酸枣仁15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

预防：夜间排尿最好采取蹲位，以增加血管外围阻力。在排尿时作平和呼吸。

61. 结核性变态反应性关节炎

结核性变态反应性关节炎，又称结核性过敏性关节炎，是由结核杆菌引起的机体过敏状态。多发于成年人，是一种比较常见的疾病。常为慢性过程，与风湿性关节炎相似，易误诊为风湿性关节炎，诊断比较困难。

结核性变态反应性关节炎，多伴有大关节为主的多发性和游走性关节肿痛，以及发热、血沉增速等症状和体征。这种病与风湿性关节炎很相似，但这两种病的病因却完全不同。风湿性关节炎是因链球菌感染后所致的自身免疫性疾病，而本病是人体感染结核杆菌后引起的过敏性关节炎。

结核性变态反应性关节炎女性发病高于男性。大多数人急性起病，症状有关节肿痛，全身发热，皮肤出现结节性红斑。只有极少数人起病缓慢。未经抗痨治疗的病人病程较长，虽经抗痨治疗但治疗不彻底的病人病程也长，可达数年甚至20年之久，关节肿痛反复发作，伴发烧、结节性红斑或皮下小结。大多数病人能在体内查出淋巴结核或肺结核病灶。极少数病人虽查不到结核病灶，而结核菌素试验往往呈强阳性，说明体内有隐伏的结核病灶。

本病虽然反复发作，但很少有进行性加重，也没有后遗症，因此往往容易造成误诊或漏诊。结核性变态反应性如误诊为风湿性关节炎，容易造成不良后果，一方面容易引起结核扩散，一方面容易造成骨骼缺血性坏死。

结核性变态反应性关节炎的诊断，除结核菌素强阳性

外，还须经X线摄片检查确诊。诊断性治疗时用水杨酸制剂无效，而用抗痨药治疗则有效。

结核性变态反应性关节炎属于祖国医学的“癆瘵”、“骨痹”等范畴。《仁斋直指方》说：“瘵虫食人骨髓”。《太平圣惠方》说：“……若微劳即发，常……骨节痛，壮热而翕翕然，……”说明古代中医学家在宏观上对结核与骨关节病变的关系已有初步认识。结核性变态反应性关节炎的治疗，宜养阴清火，扶正杀虫。

方一：天冬30克，黄精30克，茵灵芝30克，夏枯草30克，百部10克，黄芪60克，蜈蚣3条，水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

方二：白芨30克，马齿苋30克，百部10克，桃仁12克，丹参30克，夏枯草30克，羊胆粉1.5克(冲服)，黄精30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

注：由于结核性变态反应性关节炎，为慢性过程，治疗上要中西医结合，要采用抗痨药物（如异烟肼等）治疗，中药可作为辅助治疗。用抗痨药物治疗1~2周内即可体温下降到正常，大多数结节性红斑可在2~3周内消退，血沉也随之降到正常。抗痨药物治疗方案要合理，要规律用药，要完成规定的9~12个月的疗程。

62. 肩手综合征

“肩手综合征”是一种常见于老年人的结缔组织疾病。这种病与肩关节周围炎不同，肩周炎是肩关节软组织的一种慢

性退行性病变。现代医学认为，“肩手综合征”的发病原因是：①风湿；②肩臂手部和颈椎部外伤；③长时间的着凉；④姿势不良；⑤药物的影响（如长时间应用异烟肼、乙硫异烟胺、巴比妥类等）；⑥其他疾病的影响（如缺血性心脏病、颈椎病、偏瘫、颈及臂丛神经病变，脑血管病变、肺脏、肝脏病变等均可引起“肩手综合征”。

“肩手综合征”的临床表现：在上述某种诱因作用下，开始时表现为肩部或肩周围无力、疼痛、活动受限，或兼见手臂红肿，可持续数周至数月。手臂僵硬，皮肤肌肉萎缩，功能明显障碍，X线检查有助于确诊。

肩手综合征属于祖国医学的“痹证”范畴。其病因与风寒湿邪有关，风寒湿三气杂至，合而为痹也。中医还认为，肾主骨，肾虚可导致骨的病变。肩手综合征患者肱骨头、腕和手的骨骼呈片状以至弥漫性脱钙（骨质疏松），说明肾气已虚，气滞血瘀。其治疗宜祛湿除痹，活血通络，温补肾阳。

方一（用于早期）：羌活10克，独活10克，鸡血藤30克，黄芪30克，当归15克，桂枝10克，炮甲珠15克，地龙15克，姜黄10克，杜仲15克，补骨脂12克，寄生30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

方二（用于中期）：防风10克，丹参30克，续断30克，黄芪30克，桑枝30克，川牛膝30克，桂枝12克，仙灵脾30克，仙茅10克，山萸30克，骨碎补10克，土鳖虫10克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

方三（用于后期）：络石藤30克，虎杖30克，三棱10克，莪术10克，苏木10克，补骨脂15克，当归30克，黄芪60克，五灵脂10克，熟地30克，山药30克，枸杞15克，炮甲珠15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。

63. 花粉症 (过敏性综合征)

花粉症，过去曾名为花粉热、枯草热，是由于吸入植物花粉而引起的一种变态反应，也即是花粉引起的包括过敏性鼻炎的过敏性综合征。

在某些地区，每当春暖花开，百花争艳的季节，大气中漂浮着各种各样的花粉，很多人会在这时由于接触花粉而产生流清涕、打喷嚏、前额痛、咳嗽、眼痒、眼红、鼻腔奇痒、皮疹、发热及阵发性哮喘。病因主要由IgE (反应素)引起，近年报道IgG₄也可引起本症。

当本症发作时，患者有的被迫采取坐位，严重时出现紫绀。发作将停时，咳出较多稀薄痰液后，气促减轻，哮喘停止，恢复到发病前状态。胸部体征轻微或无异常体征。血液嗜酸粒细胞增高，一般可达10~20%以上。X线检查：重型表现为多发性淡薄的片状浸润，可自行消失或再发。

根据临床表现，结合皮肤过敏试验、血清或分泌物中IgE测定、X线检查等，可以确诊。

花粉症属于祖国医学的“喘证”范畴。治宜祛风解表。

中药治疗

方药：薄荷10克(后下)，辛荑10克，白芷10克，苍耳子12克，银花15克，防风12克，细辛6克，路路通30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

针刺治疗

(一) 体针：

取穴：印堂，合谷，足三里，鼻通，迎香。得气后留针30分钟。

(二) 耳针：

取穴：内鼻、外鼻、肺、大肠、气管。用胶布覆盖王不留行籽贴敷于耳穴上，每日用手按压刺激3~6次。

哮喘入夏加重，因暑湿内侵，肺失宣降，痰涎壅盛，气道受阻，故见咳嗽、气促、痰多、胸闷等症。治宜清肺化痰，理气平喘。取穴：肺、大肠、气管、内鼻、外鼻。用王不留行籽贴敷于耳穴上，每日按压3~6次。

晕动病是乘车、乘船、乘坐飞机时由于颠簸摇摆等加速运动，使较敏感的前庭神经受到刺激而发生的一种病症。患者的症状在开始旅行后数分钟到半小时出现，表现为厌食，精神抑郁，恶心，流涎，呕吐，面色苍白，出冷汗，血压降低，心动过速或心动过缓。在航海旅行时，呕吐有时可持续数日。一旦停止旅行，症状很快消失。如果呕吐严重，反复发作，可引起失水和电解质紊乱，甚至休克。

防治办法

1. 乘车乘船乘飞机以前，用“伤湿止痛膏”贴在肚脐上。

2. 擦一些清凉油或风油精在鼻唇沟处(人中)。

3. 在车子要开动时，就开始口含糖果(不要咬碎)，含完一粒再接着含一粒，直至不再有晕车感为止。如果开始坐车不含糖，当产生晕车感时再含也可以，此时如能加一滴风油精在糖果上，再放到嘴里含，效果更好。一般需要10多粒糖果就够了。糖果最好是硬质耐含的酸糖、薄荷糖等，也可用酸杨梅、橄榄果等代替糖果。

4. 晕车的人，应尽量坐在车厢前部，这样颠簸会轻一些。
5. 坐在车上不要探望窗外迅速移动的景物。
6. 旅行前睡眠要充分，旅途中不要吃得过饱，也不要饥饿，精神要愉快。
7. 用拇指按压双侧太阳、外关穴位，以局部酸、麻、胀、痛为准，一般按压20~30分钟即可。治疗时宜分散注意力。

65. 过早衰老

衰老是人体生命过程中不可避免的自然现象，但过早衰老则属病态。如体力不足，疲倦，记忆力减退，畏寒肢冷，头晕目眩，腰膝酸软，尿频，大便不调，微咳，睡眠不佳，性欲减退，易感冒，气促，多汗，耳鸣耳聋，食欲减退，流泪等等。儿童出现早衰症状（小老头）则与遗传有关。

祖国医学认为过早衰老的根本原因，一是五脏虚损，人体的精气神渐次减少；二是疾病缠身，调治失宜而损其天年。正如《内经》所说：“四十岁……腠理始疏，荣华颓落，发颇斑白，”“五十岁肝气始衰……目始不明，……”中医治疗过早衰老，宜补肾健脾，扶正固本。

中药疗法

方一：人参5克（嚼服），制首乌30克，枸杞30克，生地30克，核桃仁30克，菟丝子15克，仙灵脾30克，天冬15克。水煎服，隔日1剂，连服1年。

方二：黄芪30克，刺五加30克，人参叶30克，菌灵芝30克，茯苓30克，黄精15克，山药30克，玉竹15克，益智仁10克，锁阳10克。水煎服，隔日1剂，连服1年。

食物疗法

宜常吃银耳、蜂蜜、蜂乳、蜂花粉、芝麻、花生、生姜、甲鱼等。

针灸疗法

取穴：肾俞、关元、中极、三阴交、命门、足三里、内关、合谷。

手法：进针得气后留针半小时。每日1次，7天为1疗程。每疗程间隔1天。肾俞、关元、足三里、中极、命门等穴还可配合用灸法。可长期进行针灸治疗（保健），不计疗程。穴位可交替选取。

气功疗法

气功的门派较多，太极拳也属气功的一种，可根据患者具体情况，选择简易的气功疗法加以练习，首要的问题是要调整呼吸，作适当的深呼吸即腹式呼吸，并要意守丹田，舌抵上腭，唾液增多时将唾液咽下。

药浴疗法

用木瓜60克，茵陈60克，丹参60克，仙灵脾60克，黄芪60克，将药装入布袋内，加水浸泡，然后入锅中煎熬，用药液（放至温度适宜）洗澡。每周2~3次，坚持常年浴洗。

以上五种疗法可任意选用。

现将这五种疗法的作用分别作如下介绍。

（一）口服中药抗衰老具有广阔的前景

口服中药抗衰老，是人们广泛采用的抗衰老方法之一。

目前已初步筛选出有细胞传代作用（生命延续）和能延长实验动物寿命的中药。

细胞是生命的基地，细胞传代是生命延续的标志。近年来应用细胞传代的研究方法（细胞寿命试验）初步认定人参（包括人参茎叶）、黄芪、何首乌等具有不同程度的延缓衰老（延长细胞寿命）效能。

近年来开展的生存试验（动物寿命试验），通过观察药物对生物整体生存过程的影响，特别是对动物（家蚕、果蝇、小白鼠、豚鼠、鹌鹑等）平均寿命和最高寿命的影响，以确定其抗衰老效能。通过此项动物寿命试验的研究，目前认定的抗衰老延寿药物有：灵芝、人参茎叶、黄芪、玉竹、枸杞、黄精、大黄等。

1. 人参：人参能改善各种衰老症状，早被数千年的中医临床所证实，近年来研究，发现人参能延长细胞寿命、能提高免疫细胞数量（提高外周血淋巴细胞转化率，激活T淋巴细胞），增强机体吞噬细胞的吞噬能力，调整性激素，改善性功能，对增殖能力下降的衰老现象有延缓作用。能降低过氧化脂质，改善核酸代谢，增强人体对各种有害因素的非特异性抵抗力，使紊乱的功能趋于正常。能延长实验动物生存时限。人参根可调节大脑皮层的兴奋抑制过程，提高人的脑力和体力劳动效率，减少疲劳，延长寿命。很多报刊报道人参王国寿星多的实例，也证实人参的抗衰老作用，生活在人参王国（人参产地）中的人们喝的水、吃的饭、就连空气中都含有人参的成分，在不知不觉中，那里的人们得以延年益寿。

2. 何首乌：动物寿命试验证明何首乌有延寿作用。

脂褐质是生物体内自发产生荧光的物质，其含量随生物

年龄的增长而上升，是检验人体衰老的客观指标之一。科研单位用何首乌煎汤供小白鼠自然饮用，每日平均药量为0.12~0.15克，喂养70天后，测定其心肌中脂褐质的含量为100单位，而对照组则为178单位，经统计学处理，有非常显著的意义。这一实验为古代传说何能嗣、延秀父子服用何首乌“皆寿百六十岁”提供了科学根据，并提示何首乌是一种大有前途的抗衰老药。

何首乌体外实验能直接与胆固醇结合，在兔肠道内可减少胆固醇的吸收，还能阻止胆固醇在肝内沉积，并促进其排泄。

3. 菌灵芝：可延长果蝇的生存时限。灵芝组的平均寿命比对照组有所延长。灵芝可提高巨噬细胞和网状内皮细胞的吞噬能力，提高耐缺氧能力，还具有镇静作用，可改善肾上腺皮质激素的分泌，还能提高免疫细胞数量。

4. 黄芪：可延长实验动物的平均寿命，能提高外周淋巴细胞的转化率，激活T淋巴细胞。黄芪可促进体内干扰素生成，还具有改善因组织低氧与代谢障碍所引起的疲劳的效果。还含有大量的对延缓衰老有益的微量元素硒。

5. 黄精：可延长实验动物的寿命，提高外周淋巴细胞的百分率。有降低过氧化脂质的效能。

6. 玉竹：可延长实验动物的寿命，促进体内干扰素生成，有降低过氧化脂质的效能，并有降血糖的作用。

7. 枸杞：可延长实验动物寿命，能抑制脂肪在肝细胞内沉积，促进肝细胞新生。

8. 大黄：动物寿命试验证实大黄有延寿作用，能使人体细胞免疫功能增强。

生大黄传统用作泻下攻积药，有清热泻火、解毒、活血化

瘀等作用。近年来有人根据某些老人长期服用少量大黄的养生经验,进行了大黄抗衰老作用的研究,取得初步成果。他们选用与衰老有关的过氧化脂质为指标,利用小鼠肝脏匀浆的方法,研究了不同浓度的大黄水煎液对小鼠肝匀浆中过氧化脂质生成的影响。实验结果表明,大黄水煎液对小鼠肝匀浆过氧化脂质的生成具有明显的抑制作用。近年的研究表明,脂质过氧化物的增加与老年生理病理有着密切的关系。因此利用各种手段阻止脂质过氧化物的大量蓄积,可获得一定的延缓衰老的作用。大黄具有抑制小鼠肝匀浆过氧化脂质生成的作用。

衰老与免疫有着极为密切的关系,机体免疫机能减退能导致衰老和死亡。因此,提高免疫机能是延缓衰老的重要手段。在传统延缓衰老的药物中,不少药物具有提高免疫机能的作用。沙苑蒺藜、猪苓等,可激活包括脾脏和胸腺在内的中枢性免疫器官;百合、黄精、枸杞,可提高外周淋巴细胞的百分率;人参、黄芪、白术、女贞子、旱莲草、桑椹等,能提高外周血淋巴母细胞的转化率,激活T淋巴细胞;西洋参、人乳等,能改善B淋巴细胞的功能状态,促进抗体产生;灵芝、茯苓、仙茅等,可提高巨噬细胞和网状内皮细胞的吞噬能力;山药、黄芪、玉竹,可促进体内干扰素生成。

提高细胞免疫的中药还有鹿茸、菟丝子、白芍、首乌、阿胶、枣仁、肉桂、仙茅、锁阳、黄精、天冬、北沙参等。一些补气补血的中药对巨噬细胞有加强吞噬作用,并能促进和增强抗体合成,使免疫球蛋白水平上升及淋巴细胞转化率明显提高。

人体脂质过氧化物的增加与衰老有着密切的联系。人体产生过氧化物是引起衰老及产生各种疾病最基本的原因之

一。因此，利用各种手段阻止过氧化物的大量蓄积，可延缓衰老。除了前述的大黄以外，不少中药有抑制过氧化脂质生成的作用。补骨脂、菟丝子、枸杞子、五加皮等对大鼠肝、肾、心、脑匀浆脂质过氧化反应均有非常显著的抑制作用，作用浓度仅为补气、滋阴药浓度的五分之一，而女贞子、淫羊藿的作用浓度仅为补气、滋阴药的五十分之一即有显著的抑制作用。“寿星补汁”（由何首乌、山药、党参等中药组成）对实验小鼠有延缓衰老作用，实验研究表明连续喂饲寿星补汁3个月的小鼠，脑、肝组织脂褐质含量均明显减少，成年小鼠肝组织过氧化脂质也显著降低。寿星补汁对肝组织体外实验表明，寿星补汁可抑制过氧化反应，有延缓衰老作用。首乌、甘草能抑制大鼠肝微粒体脂质过氧化，干姜、黄芪能抑制亚油酸通空气时的过氧化作用，白术、茯苓、党参、麦冬对大鼠脏器组织体外过氧化有抑制作用。

综上所述，麦冬、党参、茯苓、白术、首乌、甘草、山药、枸杞、五加皮、菟丝子、补骨脂等能抑制过氧化反应的补益类中药，均有延缓衰老的作用。

补充或提高体内对延缓衰老有益的微量元素含量，亦是抗衰老的有效途径之一。传统延缓衰老的中药中含有丰富的对延缓衰老有益的微量元素。如：人参、白术、山药、首乌、牡蛎含多量的锌；黄芪、人乳、大蒜、沙苑蒺藜含多量的硒；鹿茸、地黄、人参、当归含丰富的铁；白术、肉桂含较高的锰；菌灵芝含锗丰富；蜂蜜含47种微量元素。经常服用这些中药，无疑有延缓衰老的作用。

近年来，随着老年医学的发展，抗衰老益寿方剂越来越多地应用于临床，不仅有传统中医方剂，也有根据中医理论新创方剂，其中有些方剂如还精煎、寿桃粉等还分别作过动

物寿命试验，证明其有延寿作用。有人通过补肾和健脾在延缓衰老作用中的对比研究，认为补肾法在神经内分泌和免疫方面延缓衰老的作用比健脾法更广泛而显著。而还精煎、寿桃粉均为补肾填精强壮方剂。证明补肾填精方剂在抗衰老延寿方面有着良好的前景。

还精煎由熟地、潼蒺藜、菟丝子、锁阳、何首乌等中药组成，有较好的抗衰老作用。

现代医学重视重要脏器——脑、心、肾及血管的增龄变化，因为这些增龄变化可直接且严重影响人的健康和寿命。人与动物衰老时，心、肾中实质细胞数明显减少，组织纤维化，胶原蛋白成分明显增多。由于胶原蛋白中含羟脯氨酸特别多，因此，测定心、肾中羟脯氨酸的含量，以反映组织纤维化和胶原蛋白的多少，作为有关衰老的客观指标。通过实验看到，大鼠、小鼠心、肾中羟脯氨酸含量有明显的增龄变化。实验结果表明，还精煎对大鼠或小鼠心、骨骼中羟脯氨酸含量的增龄变化有延缓作用，且对于大鼠尿蛋白排量的增龄变化有明显的延缓作用，说明还精煎有延缓衰老的功能。

寿桃粉由益智仁、生地、枸杞、胡桃肉等组成，有补肾生精，益气强壮的作用。有的医院将73例具有衰老见证的老年人随机分为寿桃粉治疗组和维生素E对照组，用药8周后，两组衰老见证平均值明显下降，而且寿桃粉治疗组优于维生素E对照组，并使血浆过氧化脂质含量明显下降。说明寿桃粉不仅有类似维生素E的改善衰老效应，而且比维生素E更胜一筹。另外一家医院用寿桃粉治疗303例老年人，其中疲倦、头晕、耳鸣耳聋、不寐、性欲减退、夜尿频多、畏冷等衰老症状明显改善。

综上所述，目前口服中药抗衰老的研究日趋活跃，且已

取得瞩目的成果。这一抗衰老方法易为广大中老年人接受，具有良好的群众基础和不断发展的广阔前景。口服中药抗衰老是中医抗衰老诸法中的支柱。有人预料，中国对世界的输出将主要是中医中药的输出，其中最重要的将是抗衰老延寿中药和制剂的输出。

（二）食物疗法抗衰老备受人们的青睐

食物疗法抗衰老的研究日益受到人们的青睐。动物寿命试验证明，银耳有延寿作用，花粉有延缓衰老和强壮作用。

1. 银耳：银耳可延长果蝇的生存时限。据报道，用高维银耳浆喂饲果蝇，可显著延长果蝇寿命。在此之前，有人曾对84例60~109岁长期服用银耳（1~30年）的老人进行调查研究，发现其六项免疫指标均高于未服银耳的对照组，认为银耳抗衰老有实用价值。这一结论与银耳的果蝇寿命试验相吻合。

银耳还有促进蛋白质合成代谢的作用，能对抗因放射造成的DNA代谢严重抑制。

2. 花粉：花粉有延缓衰老的作用，能促进细胞再生，花粉含维生素、氨基酸、天然酵素酶等，特别是所含的黄磷类物质和抗生素，是抗衰老的根本因子。

科学实验表明，花粉能显著提高小鼠外周血象中红细胞数和血红蛋白量。有促进糖代谢和三羧酸循环的作用。据估计，人体内2/3有机物是通过三羧酸循环分解的。同时，三羧酸循环也是有机物互变的联络机构。因此，食花粉后出现的葡萄糖-h-磷酸酶和琥珀酸脱氢酶的升高，对机体的代谢和生理活动有重要意义。

蛋白质是生命的物质基础，而生物体内的蛋白质又是不断更新、不断合成的，RAN在蛋白质生物合成中起着重要

作用。遗传物质DNA有两个基本功能，一是利用周围的有关物质复制自己，一是通过RNA控制蛋白质的合成。有了蛋白质和酶，细胞就可以进行错综复杂的新陈代谢。食用花粉小鼠肝的RNA和DNA明显多于对照组，提示花粉在促进机体蛋白质合成代谢方面有一定作用。

花粉通过影响机体代谢，产生强壮和延缓衰老的作用。

有人报道，用花粉等制成的抗衰老I号（成药），通过306例中老年人（另设对照组207例）的临床3个月观察，结果：治疗组老化症状、性机能明显改善，视敏度及听力提高，心率复常时间缩短，肺活量增加，记忆力提高，并且均显著优于对照组。

3. 蜂蜜：为传统的延缓衰老食物，含47种人体需要的微量元素，国内外盛赞其有非凡的延缓衰老效果。改善机体内环境的食物以蜂蜜为最佳。蜂蜜含有多量碱性无机盐类，能中和体内酸性代谢产物，使体液碱化，从而起到调整体内酸碱平衡的作用。

4. 蜂乳：是东西方公认的抗衰老食物，能促进细胞再生，增强细胞活力，能刺激大脑、脑下垂体和肾上腺，促进组织供氧。小鼠缺氧实验，荷重游泳实验证实，蜂乳组的存活率显著高于对照组。蜂乳具有提高耐缺氧、抗疲劳能力的双重作用，可使老年人易疲劳的症状得到显著改善。

此外，我国民间流传的一些长寿食品如花生、芝麻、生姜、甲鱼等，据近年来的研究也证实具有抗衰老作用。花生能延缓脑功能衰退，能增强记忆力。花生中所含的儿茶素，具有很强的抗老化的功效。芝麻含有丰富的维生素E，能防止过氧化脂质对人体的危害，抵销或中和细胞内衰老物质“游离基”的积聚，起到延年益寿的作用。生姜能防止含脂肪食

品的氧化变质，当生姜的辛辣成分被人体吸收后同样能抑制体内过氧化脂质的产生，从而起到抗衰老的作用。甲鱼具有养阴功效，它含有20烯代酸，是抵抗血管衰老的重要物质。

综上所述，食物疗法抗衰老由于与人们日常生活关系密切，日益受到人们的普遍关心。

（三）气功抗衰老疗效独特

抗衰老应在未衰老之前，采取有效措施，阻止衰老的发生和发展，寻求推迟衰老变化的方法，让其过程延缓下来。虽然衰老是不以人们意志为转移的客观规律，但推迟其到来，延缓其进展，不断延长寿命，这是完全可以做到的。在抗衰老的临床研究中，有人发现高血压患者坚持气功锻炼后，血压稳定，并发症减少，预后明显改善，有的合并其他老年病也获得改善。表明气功锻炼是延缓衰老的有效措施。

气功锻炼对血浆性激素和血浆环核苷酸变化也起着有益的调整作用。通过长期系统的随访观察，发现气功锻炼既能纠正阴虚，又能纠正阳虚，不仅使男性中老年高血压病患者增高的雌二醇/睾酮比值降低，更可使绝经后女性高血压患者降低的雌二醇/睾酮水平上升，从而为气功平秘阴阳、延缓衰老和防治老年病提供了部分实验依据。

通过气功锻炼防治老年病，古称“服气疗病”或“食气疗病”。气功的门派较多，服气疗病之法首要问题是要调整呼吸，特别是要进行腹式呼吸和意守丹田。腹式呼吸时唾液和胃液等消化腺体分泌量增多，腹部的温度升高，加强了胃肠的血液循环；横膈肌活动幅度增大，活动范围比平时增加约3~4倍，改变了腹腔的压力。腹腔内周期性的变动能起到“按摩”肠胃，促进肠胃蠕动，改善消化吸收机能的作用。因此，练功之后，大都能收到增加食欲，增强体质的防病健身

效果。更重要的是服气能使大脑层处于保护性的内抑制状态，从而调节皮质细胞功能，增加神经系统的活力。在调气时呼吸频率减慢，膈肌上下活动范围增大，肺泡的有效通气量增加，氧的消耗量降低，因而可以改善呼吸系统功能，减缓肺组织衰退。并且调气还可以使心率减慢，血管通透性增强，血压下降，血管舒张，血红蛋白和血小板升高，白细胞的吞噬能力与指数升高，从而有利于血液循环功能的调整和提高机体的防御机能。服气疗法还能使基础代谢率降低，提高血糖调节机能，使肾上腺皮质的血流量增加，机能改善，从而达到调整内分泌系统功能的目的。

由于气功锻炼抗衰老的疗效独特，不受练功时间和场地的限制，不需要仪器设备，易学易行。因此，这一抗衰老延寿的方法很受人们的欢迎。

（四） 针灸疗法抗衰老独辟蹊径

用针灸疗法培补肾气来延缓衰老的研究正引起人们的广泛重视。

老年人体内性激素水平下降，性功能减退，性生活减少，而性生活的减少或消失，又加剧了老化，因此延缓衰老在于提高老年性激素水平，使老年人维持一定的性功能。针灸在提高性功能方面，显示了无比的优越性。针灸治疗男性性功能减退的报道很多，效果也肯定。有人报道用针灸治疗阳痿100例，最快的只针灸一次就治愈，最慢的针灸47次治愈。又有报道用针灸治疗阳痿21例，经针刺1~7次后，阴茎均勃起如常。针灸治疗男性性功能减退，大多取穴肾俞、关元、中极、三阴交、命门等，采用培补肾元、温肾助阳之法。有人在用针灸治疗男子精子减少症时，观察了四项激素指标变化，结果发现，针前睾丸酮及人绒毛膜促性腺激素分泌量减

少，针后睾丸酮恢复正常，人绒毛促性腺激素上升。

针灸还能提高人体免疫机能，从而延缓衰老。

实验表明，针灸能加强白细胞吞噬力，提高数十种免疫功能指标，增强抗病能力。如抗过敏、抗感染、抗癌、扶正祛邪，促进多种疾病康复。如针足三里、合谷，能提高白细胞吞噬作用；针上巨虚、天枢、足三里、大椎、命门、肾俞、肝俞能提高巨噬细胞吞噬机能；针天突、内关能提高淋巴母细胞转化率；针上巨虚、天枢、足三里、大椎能调整非特异性免疫；针合谷、内关、上巨虚、天枢、足三里等穴能改善特异性免疫指标。有人以无病亦未服药老人为对象，用经穴灸疗仪照射关元、百会、足三里，分别在灸前、灸后7天、15天、40天采血收集灸照前后数值，结果灸后外周血液淋巴细胞绝对值、血清免疫球蛋白IgG、IgA、IgE含量均较灸前提高。有人用微波对肝肿瘤患者针刺治疗时，发现患者免疫功能提高，T细胞有增加趋势。

以上说明针灸可以提高免疫机能，可以延缓衰老。

当人体内某些微量元素如锌、锰缺乏时，可导致肾虚而出现食欲减退、免疫机能低下、性功能减退、睾丸萎缩等一系列衰老现象。针灸可以提高微量元素锌的含量，使虚衰的肾气得以充实，因此，针灸可通过提高微量元素含量而达到延缓衰老的目的。有人认为灸足三里可改善锌的吸收，并认为铜虽有多种生理功能，但血铜升高可增加发生动脉硬化的机会，血铜增高又会增加体内的自由基而加速人体老化，而用艾灸足三里既可提高锌含量而降低铜含量，通过这一双重作用达到抗衰老之目的。

（五）药浴是抗衰老综合措施的组成部分

药浴有延缓衰老的作用。清代慈禧（那拉氏）生前常作

药浴，取得了延缓衰老的效果。那拉氏曾经历二次蒙难，数次宫廷叛乱，内忧外患交织，然而那拉氏却未曾因此憔悴衰老，从少女到老妇始终保持着柔嫩滑润的肌肤，不能不归功于她坚持作药浴。据《清宫秘史》记载，慈禧甚喜水沐，有5日一小沐，10日一大沐的习惯。药用精草、茵陈、决明、木瓜、桑叶、苡仁、蝉衣等，将药盛于布袋内，熬水浸泡。这些药物有清风热、爽肌肤、祛湿热、解身毒、明五官之功效。木瓜有木瓜酶，具有和润肌肤的美容效果。精草，对绿脓杆菌、皮肤真菌有抑制作用。蝉衣有散风热之功。茵陈、决明具有渗利湿热、清热明目的功效。

用作药浴的尚可因地制宜地选用丹参、黄芪、仙灵脾、益母草等。

药浴，不失为抗衰老的有效措施之一。然由于药浴需要大剂量中药，其价不廉，不易普及。作为学术研究，可以进一步探讨。

66. 阿托品依赖症

阿托品依赖症系指因某些疾病长期服用阿托品，一旦停药阿托品则出现一系列症状，即类似于“上瘾”现象。患者多为胃脘痛服阿托品止痛，后因胃脘痛复发，又服阿托品。反复发作，反复服用阿托品，久则不能间断，如一旦停药，则感脘腹疼痛加重，腹胀，不思饮食，或伴小便不利，痛苦难以名状。如继服阿托品，则诸症立刻消失。经胃肠钡餐透视等检查，无器质性病变，此即阿托品依赖症。

阿托品依赖症类似于祖国医学的“中焦虚寒证”。患者长期服用阿托品，胃平滑肌处于抑制状态，运化功能减弱，气血化源不足，中阳不振，以致出现腹胀、纳差等一系列症状。治宜补益中气，温脾和胃。

方药：炙黄芪30克，党参20克，白朮15克，白芍15克，桂枝10克，茯苓15克，甘草10克，法半夏10克，陈皮10克，木香6克，砂仁6克，生姜6克，大枣10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

67. 乌头类药物中毒

乌头类药物中毒在我国较为常见。乌头类植物属于有毒的中药，临床常用于治疗各种关节痛等，如用之不当很容易引起中毒。

乌头类药物品种繁多，据《江苏中医》1988年第12期报道，临床上常用的有如下品种：

单用：川乌、草乌、天雄、附子、落地金钱、雪上一支蒿、搜山虎、雪莲花等。

合用：川乌、草乌；川乌、附子；草乌、附子；川乌、草乌、附子。

复方制剂：乌头汤加减，一粒止痛丹，风湿骨疼丸，舒筋活血丸，壮筋丸，活络丸，麝香丸，71·50丸，小活络丹，活血壮筋丹，蠲痹胶囊，临汝药酒，鹿筋酒，雪上一支蒿药酒，附子配麻黄等。

使用乌头类药物大体治疗下列疾病：风湿性关节炎（使

用最广)，类风湿性关节炎，腰腿痛，关节痛，跌打损伤。有个别患者自己买乌头类药物用于治疗高血压、痛风、咳嗽、感冒、胃痛等。有的患者把附子作为补药内服，因超量或生用等等原因而引起中毒。

中毒的原因主要有：①超量：有的医生开处方用乌头类药物超过常用量数倍，甚至《药典》的规定量百倍以上，从而引起中毒甚至死亡。②误服：有的患者误将分多次服用的散剂作一次性吞服（或煎服）而引起中毒。③生用：未经炮制的生乌头类药物比炮制过的毒性更大。④与酒同用：乌头类药物无论酒泡，还是酒煎，或以酒送服，都会加重和促进病情的发展。⑤煎法不当，煎煮的时间过短：有的患者将附片90克置于饭碗中只蒸40分钟服下，一小时后即引起中毒而死亡。有的患者将药锅置于公共厨房的炉灶上煎煮附片，自己外出，外出后邻居将其药锅移去（离火）而放上邻居的食物炖汤，2小时后又将附片药锅置于炉灶上煎煮，又未与主人打招呼，熬药的主人以为附片已煎煮了2小时（实际上这两小时并未煎煮），就放心大胆服用，结果引起中毒，教训实为惨重。⑥配伍不当：附片与麻黄合用，附片与贝母合用均可引起中毒。

中毒剂量：引起中毒的剂量多少不等，差别十分悬殊，生草乌粉1.5克即可引起中毒。

中毒主要征象：①神经系统：口舌、四肢、全身发麻并有紧束感，烦躁不安，头痛，昏倒，神志不清，痛觉消失或减弱，阵发性抽搐，个别患者失明，复视。②消化系统：恶心，呕吐，腹痛，腹泻，流涎，个别患者二便失禁。③循环系统：心慌心悸，血压下降，心律不齐，心动过缓或心动过速，个别患者心跳骤停。④其他表现：部分患者四肢厥冷，

身出冷汗，面色苍白，呼吸急促，唇颊紫绀。⑤心电图异常。

乌头类药物中毒的解救方法

1. 迅速作洗胃、导泻、输液、利尿、抗心律失常、抗休克等对症处理。紧接着作中药解毒处理。

2. 中药解毒：用犀角、绿豆、甘草煎水服（剂量视乌头类药物摄入量而定，下同）。或用甘草、银花煎汤服用。或用甘草、黄连煎水服。或用甘草、生姜、绿豆煎水服。或用生白蜜120克，加凉开水搅匀，徐徐咽下。或用肉桂5~10克，泡水服。或用银花、甘草、黑豆、绿豆、赤小豆各30克煎水、加蜂蜜30克，搅匀内服。

预防：医生应严格掌握使用乌头类药物的适应症。更宜慎用乌头类药物的生品或粉剂，应叮嘱病人要先将乌头类药物煎煮，单用最好与蜜同煎。

患者不要妄信偏方而擅自购买乌头类药物服用，更不能随意加大药量。切忌泡药酒或与酒同煎服，因为酒能增强其毒性，乌头碱在乙醇中的溶解度较大。生药泡酒，只许外搽，禁止内服。

68. 人参中毒综合征

人参中毒综合征，又称人参滥用综合征。其病因为长期或不恰当地服用人参及人参制品所致。

临床表现类似皮质类固醇中毒，主要症状有高血压、精神高度兴奋并失眠，神经过敏（欣快感、不安定、易激动），

皮疹，食欲减退，晨泻等。

出现人参中毒综合征的原因，可能是人参干扰了可的松和促肾上腺皮质激素的水平。人参毒性虽不大，但个别人对人参比较敏感。

中医认为，人参中毒综合征的发生，是补不对证的结果。人参乃大补元气之物，气不足者，服人参可愈；而气不虚者，服人参则易成气郁化火之证。“气有余便是火”，所以人参中毒综合征主要表现为阳热有余之象。其治疗，宜导气行郁。

方药：莱菔子25克，香附15克，柴胡15克，麦冬15克，天冬15克，五味子15克，远志15克，钩藤15克，大枣10克，生甘草15克。水煎服，每日1剂，中病即止。

莱菔子即萝卜的种子。民间有谓服人参忌吃萝卜，意味着莱菔子能解人参毒。临床报道，在3例红参中毒的婴儿抢救中，1例死亡，1例加服萝卜水，提高了疗效。

本方以莱菔子为主药，配香附、柴胡，意在导气行郁，壅郁之气下行，则火热无以生。配合天冬、麦冬、五味子、钩藤、远志，意在清热安神以治标。大枣、甘草化阴养心，生甘草尚有解毒功效。

广东民间认为婴儿出生后20小时内服人参对孩子的生长发育有益。这种观点是错误的。临床报道提示婴儿口服人参易引起中毒。

中医有谚语云“大黄救人无功，人参杀人无过”。说明过去人们对大黄和人参都抱有偏见。只因为人参有大补元气之功，所以服人参中了毒，人们也不会责怪人参。这种错误的偏见往往是引起人参中毒症的祸根。

妇产科

69. 月经周期性水肿

月经周期性水肿系妇女行经期间发生下肢肿胀甚至全身性水肿的周期性症状。患者多于经前7~14天开始感颜面部发胀，继则眼睑浮肿，逐渐发展为下肢凹陷性水肿。行经后则浮肿逐渐消退，一如常人。浮肿期间，烦躁易怒，乳房胀痛，腰酸，下腹冷痛。月经色紫，夹有瘀块。

月经周期性水肿属于祖国医学的“水肿”范畴。《圣济总录》说：“肾主水，脾胃俱主土，土克水，胃为水谷之海，其气虚，不能传化水气，使水气浸渍脏腑，又脾得水湿之气，土衰不能制之，水气独归于肾，肾虚三焦不泻，经络闭塞，故水气溢于皮肤，传流四肢，所以通身肿也”。中医认为月经周期性水肿责之于肾虚及经络闭阻，治宜补肾通络。

方一：山药30克，熟地20克，当归30克，黄芪60克，丹参30克，泽兰15克，益母草30克，覆盆子12克，巴戟12克，泽泻30克。水煎服，每日1剂，于水肿开始即服药，直至水肿消退。服用2~3个周期。

方二：桂枝10克，当归20克，白芍12克，细辛6克，硫黄3克（研末冲服），木通10克，大枣15克，甘草5克。水煎服。每日1剂。于水肿开始即服药，直至行经。需服用2~3个周期。

方三：麻黄5克，白朮12克，茯苓皮15克，黄芪30克，防己10克，川芎10克，仙茅10克，仙灵脾30克，泽泻30克，当归20克，桔梗10克，白芍15克。水煎服，每日1剂，于水肿开始即服药，直至行经。需服用2~3个周期。

70. 妊娠膀胱炎

妊娠膀胱炎是指女性在妊娠期间由于细菌感染而导致膀胱发炎，出现腰痛，尿频尿急尿痛等症状。尿常规检查可见大量白细胞、少量红细胞及蛋白。现代医学认为，妊娠后期，由于增大的子宫压迫输尿管，使尿流不畅而肾盂扩大，容易招致感染。

妊娠膀胱炎属于祖国医学的“下焦湿热”范畴。由于尿液滞留膀胱，气化不利，致小便淋漓而下且有灼痛。治宜祛湿清热，解毒通淋。

辨证分型论治

(一) 阴虚型：多见于疾病初期，小便频数涩痛，量少色黄，大便不畅，两颧潮红，腰酸痛，头晕乏力。舌红苔黄脉细数。治宜滋阴清热。

方药：生地30克，车前草30克，当归30克，木通10克，川贝6克，苦参30克，枸杞15克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

(二) 实热型：多见于疾病中期，小便频数而短，色黄赤，小便艰涩不利，热痛，口苦而渴，或口舌生疮。舌红苔黄燥，脉滑数。治宜清热泻火，解毒利湿。

方药：知母10克，黄柏12克，黄芩30克，当归20克，苦参30克，川贝6克，淡竹叶12克，山梔12克，沙参15克，麦冬30克，瓜蒌15克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

(三) 气虚型：多见于病程较长或平素体质素弱的患者。小便淋漓频数，解时不能制约，解后尿道疼痛，尿量不减，尿色白而清，气短乏力。舌淡苔白脉虚弱。治宜益气通淋。

方药：黄芪60克，党参30克，续断30克，黄芩30克，当归20克，苦参20克，川贝6克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

71. 妊娠胆汁淤积症

妊娠期肝内胆汁淤积症，简称妊娠胆汁淤积症，是一种在妊娠期出现的以瘙痒及黄疸为特征的合并症。不少妇产科或内科医生对此缺乏认识，常致漏诊或误诊为肝炎或胆石症。近年来越来越多的文献指出此病对胎儿有不良影响，可造成早产、胎儿窘迫以及产后出血。

目前大多数医家认为孕期雌激素的急剧升高是引起妊娠胆汁淤积症的原因，并且具有遗传性和家族性的特点。

本病在世界各国发病率有很大的不同，其中北欧的瑞典、芬兰，南美的智利、玻利维亚是高发地区。瑞典的发病率为2.8~4.2%，妊娠瘙痒者为1.6~3.2%，智利的发病率为2.4%，妊娠瘙痒者高达13.2%。但在北美、西欧的发病率就较低，美国、加拿大、德国和瑞士均在0.05%以下。中

国四川重庆的发病率为2.3%。

妊娠胆汁淤积症首先出现的症状是瘙痒。常发生于28~32孕周，亦有早至第12孕周者。瘙痒程度亦各有不同，可有偶然轻度发生的瘙痒，也有严重的全身瘙痒，有的甚至瘙痒无法入眠而需终止妊娠。手掌和脚掌是瘙痒的常见部位，瘙痒可持续至分娩。分娩后瘙痒消失。

本病在瘙痒发生后的数日至数周出现黄疸，但不是所有本病患者都出现黄疸，黄疸的发生率为15~60%。黄疸程度一般较轻，有的仅角膜轻度黄染。黄疸可持续至分娩后数日消退，个别可持续至产后1个月以上。在发生黄疸的前后，患者尿色变深，粪便色变浅。其它偶有呕吐、乏力、胃纳不佳等症状。长期呕吐可致脱水。

妊娠胆汁淤积症可通过实验室检查而确诊。实验室检查SGPT及SGOT升高，但升高幅度不大，TTT、TFT多无改变，血中胆酸明显增高，胆红素增高常低于5毫克%。排除病毒性肝炎，即可明确诊断。

妊娠胆汁淤积症属于祖国医学的“黄疸”范畴。中医认为系湿热积于中焦，治宜清热化湿。

方药：茵陈30克，大黄5克，炒山栀10克，生地15克，麦冬15克，玄参15克，竹茹10克，茅根30克，藿香10克，砂仁3克，陈皮10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

加减：乏力倦怠加党参30克，呕吐频繁加法半夏10克、旋覆花10克，胃纳不佳加生谷芽、生麦芽各30克，瘙痒严重加蛇床子10克、地肤子30克。

72. 胎儿宫内生长迟缓

胎儿宫内生长迟缓，亦称胎盘功能不良综合征或胎儿营养不良综合征，是围产期主要的并发症之一。胎儿宫内生长迟缓，可因胎盘绒毛膜血管病、局部绒毛膜发育迟缓、胎盘生长障碍，使绒毛表面积和绒毛毛细血管表面积显著减少，导致胎盘功能不全所致。胎盘母体血管病变和原因不明的慢性绒毛炎亦可导致低体重儿，如绒毛膜羊膜炎，脐血管炎，绒毛板炎，绒毛炎，胎盘和附属物的急、慢性炎症均可导致胎儿宫内生长迟缓。

胎儿宫内生长迟缓可根据以下几点进行诊断：

1. 临床估计胎重与孕周不符。
2. 宫高曲线低于第10百分位数。
3. 母体体重连续2~3周无明显增加（从第28孕周开始计算）。
4. “B”超双顶径平均值低于同期孕周2个标准差。

胎儿宫内生长迟缓属于祖国医学“胎萎不长”范畴。中医认为妊娠胎气本乎气血，胎不长者，气血不足。治宜益气养血。

辨证分型及治疗

（一）血虚型：平素血虚，面色无华，头晕心悸，精神倦怠，食欲不振，腰膝酸软，脉细无力，舌淡红苔薄。治宜益气养血。

方药：黄芪30克，党参30克，当归身30克，白芍15克，

熟地20克，山药30克，白朮15克，杜仲10克，大枣30克，制首乌10克，枸杞15克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

(二) 阴虚血热型：平素阴虚，口干唇燥，手足心热，头晕目花，脉滑数，舌红无苔。治宜滋阴养血。

方药：生地30克，麦冬30克，玄参15克，白芍15克，黄精15克，太子参30克，地骨皮15克，黄芩10克。当归15克，枸杞15克，沙参15克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

(三) 气滞血瘀型：平素忧郁。头胀胸闷，精神抑郁，肢体浮肿，舌有瘀点，苔薄，脉弦涩。

方药：当归30克，白芍30克，川芎10克，白朮15克，茯苓15克，泽泻15克，香附10克。水煎服，每日1剂，连服15剂。

专方专药治疗

方药：全当归30克，黄芪60克，白朮30克，山药30克，白芍15克，续断15克，寄生15克，党参30克，黄芩10克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

方中黄芪、党参益气，当归补血，白朮健脾安胎，白芍补肝养血，续断、寄生补肾安胎，黄芩坚阴清热安胎，山药健脾补肾。诸药合用，增强脾胃功能，生化气血，益气补血，补肾安胎，治疗胎儿宫内生长迟缓，甚为合拍。

73. 女扎术后综合征

随着计划生育工作广泛深入开展，临床上遇到因节育术出现的症候群亦日益增多。这类症候群大多无阳性指征，严

格的讲并非是输卵管结扎术后的并发症，而是神经官能症的种种表现。其发生的原因主要为精神因素，如对绝育手术不理解，也有的属于医源性刺激，如手术时间过长、疼痛、术中医务人员语言不慎，使受术者产生疑虑。手术后出现某些症状时医务人员解释处理不当而引起受术者的一些症状，如腰骶痛、腹痛、下肢痛、头痛头晕、心悸失眠、月经不调等。

中医认为绝育手术后出现的一系列症候群，与足厥阴肝经关系密切，其病机为经脉阻滞，七情内因虚于内，加上局部创伤外因，导致一系列自觉症状。中医认为肝气抑郁则血行阻滞。女子为阴柔之体，加之对绝育术认识不足，忧虑重重，心情抑郁不畅，从而影响肝之疏泄功能，导致头晕头痛、四肢痛、月经异常等。中医还认为，足厥阴肝经上至巅顶，与督脉交会，下至足底，循少腹绕阴器，下行贯膈，布散胸胁，其经长而沟通广。因此肝经病变，临床见症变化多端。另外通过肝的疏泄升发，将肝之余血下注血海，故云冲脉附于肝，又与任脉相会于曲骨。肝之生理异常，余血不能下注胞宫，血海空虚，冲任失养，因而出现腰骶痛、腹痛等自觉症状。其治疗宜疏肝解郁，活血化瘀。

方一：柴胡10克，当归30克，白芍30克，白朮15克，茯苓15克，川芎10克，香附15克，川楝子10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

本方适用于女扎术后自觉胁腹胀痛，痛无定处。

方二：木香10克，青皮10克，三棱10克，莪术10克，小茴10克，枳壳12克，川楝子10克，当归30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

本方适用于女扎术后自觉少腹疼痛，痛有定处。

方三：当归30克，桂枝10克，桃仁10克，茯苓15克，川芎10克，熟地30克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。本方适用于女扎术后月经不调。

方四：川芎10克，白芷10克，柴胡15克，当归30克，牛蒡子20克，苍朮15克，羌活12克，细辛6克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。本方适用于女扎术后自觉头痛头晕，检查又无阳性指征。

方五：夜交藤30克，柏子仁30克，酸枣仁15克，生牡蛎30克，磁石45克，刺五加30克，五味子15克，党参30克，麦冬30克，水煎服，每日1剂，连服10~15剂。本方适用于女扎术后自觉心悸失眠，检查又无任何阳性指征。

方六：山药30克，熟地20克，续断30克，寄生30克，狗脊30克，枸杞15克，仙茅10克，仙灵脾30克，山萸15克，淮牛膝30克，乳香10克，没药10克，水煎服，每日1剂，连服10~15剂。本方适用于女扎术后自觉腰痛、下肢痛，检查又无阳性指征。

74. 刮宫术后出血

刮宫术后出血，特别是术后一周以上仍有阴道持续流血，在临床上虽不多见，但易导致患者情绪紧张，因此，积极治疗刮宫术后出血，有利于计划生育工作的深入开展。中药治疗刮宫术后出血有较好疗效，安全简便，患者乐于接受。

刮宫术后出血，属于祖国医学之崩漏范畴。中医认为系

冲任损伤，气不摄血所致；或气滞血瘀，瘀血未尽，新血不得归经；或情志过激，肝气郁结，失于条达，以致形成崩漏。其治疗宜补气摄血，活血化瘀，疏肝解郁。

方一：熟地30克，三七粉6克（冲服），人参叶30克，茜草10克，黄芪30克，仙鹤草30克，枸杞15克，川牛膝30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方二：川芎10克，当归30克，益母草30克，桃仁10克，红花10克，黄芪60克，炮姜6克，山楂30克，炙甘草10克，柴胡10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

加减：气虚乏力加党参30克。腰痛加寄生、续断各30克。腹痛重，阴道流血多者，加炒蒲黄10克、三七粉6克。腹痛明显加五灵脂、生蒲黄各10克。

75. 妇科癌症放疗后阴道干涩

妇科癌症如子宫癌、子宫残端癌、阴道癌晚期，经放射治疗后，可导致阴道干涩、疼痛，性交困难等症状。患者极感痛苦。

中医认为放射治疗毒性因素对人体来说，属于外来火热，易耗气伤精，损及精血。且肿瘤中晚期患者邪盛正虚，本虚标实，气血津液虚损，放射治疗伤及下焦，易致肝肾两虚。治宜滋养肝肾。

方药：生地30克，熟地30克，枸杞15克，沙参30克，山茱萸30克，黄精30克，当归30克，丹参30克，白花蛇舌草30克，半枝莲30克。水煎服，每日1剂，症状消失后改用丸剂。

治疗，以巩固疗效。

加减：阴道剧痛加白芍，阴道出血加三七，阴道粘连或狭窄加土鳖虫，阴虚发热加银柴胡，气虚加党参、黄芪，尿路感染加知母、黄柏。

现代医学认为，放射治疗后阴道干涩，严重者可引起局部组织粘连、充血、水肿、糜烂等，因此主张每日用扩阴器扩张阴道，并用生理盐水200毫升冲洗1次。

儿 科

76. 小儿缺锌症

小儿缺锌症是一种常见病。凡小儿发锌低于110.7ppm，食欲减退，有嗜异表现，体重较正常儿童少20%以上，身高低于正常儿童，生长发育迟缓者，可列为小儿缺锌症。

小儿缺锌症尚可有下列兼证：面色萎黄或眇白，或消化不良，或毛发稀疏干枯，或神疲乏力，或睡卧露睛，或低热，或五心烦热，或大便溏薄等。

锌是人体必需的微量元素之一，锌在营养中的作用远比维生素重要，锌参与蛋白质、核酶的代谢，促进组织细胞损伤的修复。小儿缺锌则生长发育停滞，影响智力发育。由于生长迟缓，甚至可成为侏儒，还可影响性器官的发育。缺锌可造成神经系统缺陷，智力差，反应迟钝，厌食，嗜异癖（小儿爱吃泥土、羽毛、粉笔、砖块、石灰等），小儿缺锌，还易患感染，包括上呼吸道感染、气管炎、喉炎、肺炎、扁桃体炎等，易患肠胃疾病，伤口延期愈合，缺锌还可引起视力减退。总之，人体缺锌可引起多种疾病。小儿处于迅速生长发育阶段，容易造成锌的缺乏，特别是牛乳喂养的婴儿更容易缺锌（牛乳含锌量较低，不敷婴儿生长发育的需要）。小儿易缺锌还有一个重要的原因，就是小儿偏食性强，家长对小儿的溺爱，一时不易纠正其偏食的不良习惯，

膳食结构的不合理，也容易造成小儿缺锌。

综上所述，小儿缺锌是一种常见病、多发病。

小儿缺锌症属于祖国医学的“小儿疳”范畴。中医认为小儿系稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩脾胃虚弱，如喂养不当，易致疳证。其治疗宜健脾益胃，消食补气，养血安神。

方一：制首乌10克，白术15克，补骨脂6克，枸杞10克，女贞子10克，山楂6克，神曲6克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

方二：白术10克，黄精10克，麦芽10克，龙骨15克，莪术3克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

以上方药中的何首乌为补锌良药，小儿缺锌者毛发疏稀干枯，服用何首乌可补肾荣发，收效良好。白术具有促进肠道分泌作用，调节肠粘膜细胞的含锌量，增强对锌的吸收，是治疗小儿缺锌症的良药。

中药补锌，药性平和，补而不滞，无副作用，优于单纯锌制剂。

小儿缺锌症除服药治疗外，还要纠正小儿偏食的不良习惯，设法使小儿吃些含锌食物如瘦肉，苹果等。

77. 儿童乙型肝炎相关性肾炎

近年来临床上诊断为肾炎性肾病、不典型的肾炎患儿，以及单纯性肾病伴肝脏肿大或急性肾炎有肝大而不能以心力衰竭解释的患者，常规检查血清HBsAg或HBcAg阳性，说明乙型肝炎病毒与儿童肾炎及肾病综合征的发病有密切关

系。有部分急性肾小球肾炎患者，在肝炎恢复过程中，血清SGPT降至正常，HBsAg阴转，肾炎也随之有明显好转。此即乙型肝炎相关性肾炎。

乙型肝炎相关性肾炎是由乙型肝炎病毒引起的免疫复合物肾炎。多见于儿童，病情缠绵难愈，尿蛋白转阴缓慢，疗程可长至1~1.5年。

病因：乙型肝炎抗原在循环中形成的免疫复合物沿肾小球基底膜沉积是导致本病的原因。近年来亦有实验证实，肾小球沉积物是由循环的抗体与肾小球本身的结构或与“种植”的抗原在原位结合而形成。

儿童乙型肝炎相关性肾炎的临床表现：有蛋白尿、血尿等肾炎或肾病综合征表现，病程迁延，对糖皮质激素及免疫抑制剂多不敏感，肝脏轻度肿大或中等度肿大，可见SGPT增高。有乙肝病毒感染的证据，血清HBsAg及HBcAg阳性。少数病例可见血清尿素氮，肌酐增高。

关于乙型肝炎相关性肾炎的诊断，目前尚无统一的标准。有学者提出本病确诊须具备以下6个条件：①有蛋白尿、血尿等肾炎表现。②有乙型肝炎病毒感染的证据，如HBsAg、HBcAg阳性。③肾组织免疫荧光检查有乙型肝炎抗原，IgG和C₃沉积。④电镜检查肾小球毛细血管壁基底膜外侧或内侧有致密物质沉积。⑤由肾组织浸出的IgG为HBsAg特异性抗原。⑥血清中有免疫复合物存在。

祖国医学无乙型肝炎相关性肾炎之病名，但中医认为肝肾同源，肝肾在病理上有一定的关联。且患儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩，气血不足，阴阳失调，易虚易实，故本病的治疗，宜调补气血，滋养肝肾，佐以活血化瘀。

方药：太子参10克，黄芪15克，当归10克，熟地10克，

山药10克，山萸6克，丹皮5克，茯苓5克，泽泻10克，茅根10克，鹿角胶5克，人参叶5克，白术5克，菟丝子5克。水煎服，隔日1剂。连服1年。

加减：纳差加山楂、神曲、鸡内金，肾虚明显加仙灵脾、黄精，肝功一直不正常加板蓝根、茵灵芝，并重用人参叶。考虑到“久病必夹瘀”，方中还可伍用丹参、赤芍、三七粉等活血化瘀药。

78. 小儿高热惊厥

高热惊厥是小儿时期常见的急症，自新生儿至各年龄小儿均可发生，但多发生在6个月至4岁之间，表现为突然发作的全身或局部肌群强直性和阵挛性抽搐。惊厥多在体温上升早期发生，发作时间短暂。发作后意识恢复快。没有神经系统异常的体征。退热后1周脑电图检查可正常。据统计小儿高热惊厥在全部小儿人口中约占5~8%，也就是说，世界上的孩子中，5~8%都发生过高热惊厥，男孩比女孩多。

小儿高热惊厥患者约有1/3病例在以后的感染发热时常可引起抽搐复发。小儿高热惊厥的病因多为细菌感染或病毒感染。脑炎、脑膜炎引起的发烧抽搐不在小儿高热惊厥之列。

根据小儿高热惊厥的发病年龄、发作类型等不同特点，医学上分为单纯性高热惊厥和复杂性高热惊厥两类。详见下表：

单纯性与复杂性高热惊厥

特 点	单纯性高热惊厥	复杂性高热惊厥
发病年龄	6个月至4岁为常见	不定,可在6个月以前或6岁以后
惊厥与发热的关系	发病早期(6小时以内)体温上升,体温多在38~40℃之间出现惊厥	起初高热引起惊厥,发作数次后低热甚至无热也发生惊厥
惊厥持续时间和发作次数	数十秒钟至数分钟,极少超过10分钟,多数仅1次	可达15~30分钟以上,反复发作多次
惊厥发作类型	多为全身性、对称性(婴幼儿可不对称)	明显局限性
神经系统症状	惊厥前无异常,抽搐后意识恢复快	惊厥前后有异常(原有脑外伤、窒息、中毒史)
脑电图	热退1周后正常	热退1周后有异常波型
预 后	良 好	差

小儿高热惊厥属于祖国医学的“急惊风”范畴。早在《内经》上已有惊痫的记载,认为“热则生风,风生痰”。宋以前的中医文献中有“惊证”、“惊候”、“惊痫候”的记载,多与痫证相混。北宋初期的《太平圣惠方》首次出现急惊风、慢惊风的病名、病因病机等记载,指出“夫小儿急惊风者,由气血不和,风有实热,为风邪所乘,干于心神之所致也。心者神之所舍,主于血脉,若热甚则血乱,血乱则气并于血,

气血相并，又被风邪所搏，故惊而不安也。其候遍身壮热，痰涎壅滞，四肢拘急，筋脉抽掣，项背强直，牙关紧急是也”。宋·钱乙《小儿药证直诀》也有急惊风的记载，对惊风阴阳虚实的辨别，比《太平圣惠方》更为明确、严格、适体得多，为后世辨治小儿惊风树立了楷模。中医认为小儿急惊风的病因病机为：①外感邪热。②湿热宿食停滞。③惊恐。惊恐客忤为小儿常见之病因，一般不易被人察知，小儿肝常有余，“惊则气乱”，心神为之不安，肝风极易妄动；恣食肥甘乳食，“肠胃乃伤”，积滞生痰生热，为急惊之变的又一诱因。外感风热不得解散，挟痰热内扰，而成急惊。总之，必具心肝之热，痰滞之积，外有风邪之引，三者合一，乃易发搐。老中医张锡君认为小儿脏腑娇嫩，肌肤薄弱，腠理不密，外邪侵袭肌表，邪易入里，郁而化火生热，火甚生痰，热极生风，导致发惊。其病因病机可概括为“惊、风、痰、热”。中医还认为，痰滞胶结胸中，阻其气机升降之道，风邪外引以痰滞为据点，热升则不得降，邪热挟心肝之火上凌，冲击及脑，而致惊搐昏瞀。中医还认为急惊之因除受大惊之外，高热也是其因，这与现代医学的高热惊厥有相似之处。

现重点介绍中医对小儿高热惊厥的防治。

中药治疗

（一） 辨证分型治疗

1. 风温之邪逆传心包：初期出现上呼吸道感染症状，发热，咽红，脉数等，继则逆传心包，引动肝风，神志昏迷，抽搐惊厥。治宜疏风清热，开窍镇惊。

方药：银花10克，连翘10克，竹叶6克，荆芥6克，牛蒡子6克，薄荷10克（后下），羚羊角粉1克（冲服），水煎

服。每日1剂。连服3~7剂。另服安宫牛黄丸1粒。

加减：热甚加青黛、栀子。抽搐甚加蜈蚣、全蝎、僵蚕。

2. 邪热直中引动肝风：高热烦渴，白睛赤色，手脚抽搐，牙关紧闭，脉洪数。治宜清热解毒，熄风开窍。

方药：黄连6克，龙脑10克，龙胆草6克，防风3克，青黛6克，钩藤10克，牛黄1克，麝香0.1克（冲服），黄芩6克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

加减：大便干燥加大黄、芒硝，抽搐甚加紫雪丹。

3. 气血两燔：高热烦渴，衄血、尿血或斑疹，惊厥，舌红绛，脉洪数。治宜清热解毒，凉血熄风。

方药：生石膏30克，生地20克，犀角粉1.5克（冲服），栀子10克，黄连10克，黄芩15克，竹叶10克，连翘10克，玄参10克，赤芍10克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

加减：便秘加大黄、芒硝；呕吐甚加玉枢丹；喉间痰鸣加菖蒲、郁金、胆南、竹沥。

4. 邪热炽盛，内传营血：手足痲疯，角弓反张，多部位出血。治宜凉血解毒，凉肝熄风。

方药：犀角1.5克，生地15克，丹皮6克，赤芍10克，钩藤10克，羚羊角粉1克（冲服），川贝3克，桑叶10克，菊花15克，茯苓10克，竹茹10克，白芍15克，甘草3克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

（二） 验方治疗：

方一：薄荷10克，连翘10克，栀子6克，黄芩10克，大黄6克，钩藤10克，全蝎6克，石决明15克，龙齿15克。水煎，兑服蜂蜜15克，每日1剂，连服3~7剂。

本方从“痰热”二字上着眼，开壅散结，清散风火，双管

齐下，痰热去则热自降，风热散则惊自平。

方二：银花15克，大黄6克，僵蚕6克，天竺黄6克，鲜芦根30克，川贝3克，钩藤10克，连翘10克，黄芩10克，黄连6克。水煎服，每日1剂连服3~7剂。

本方针对邪热入里，热积搏结而成“胃家实”引起小儿高热惊厥，有通腑泻实、豁痰止搐之功效。

方三：犀角粉1.5克（冲服），栀子10克，玄参10克，麦冬10克，桑叶10克，菊花10克，银花10克，连翘10克。水煎服症状减轻后改服以下方药：人参6克，生石膏20克，知母10克，甘草6克，粳米10克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。本方适用于新生儿败血症引起的高热惊厥，并反复发作。

方四：胆南星6克，鲜竹沥15克（兑服），天竺黄6克，菖蒲6克，沉香3克。水煎服。并选用猴枣散（成药）1支，每日服1次，礞石滚痰丸，苏合香丸（均为成药）交叉服用，外用牙皂1克，麝香0.1克，研末吹鼻。

针灸治疗

方一：取穴内关、中冲、期门、太冲。重捻，反复提插，配合用安宫牛黄丸。针刺内关、中冲，可清心包之火，针刺期门、太冲，可泻肝经之热，治疗小儿高热惊厥，收效较好。

方二：取穴曲池（双侧），合谷（双侧）。强刺激，不留针，并用三棱针刺印堂放血（出血量如黄豆大血珠即可），严重者加刺人中，并用退热药作辅助治疗。

合谷为大肠经原穴，与肺相表里，针刺合谷可清宣肺气而退热。曲池为手阳明合穴，治热病。印堂，泄热镇惊。三穴合用，有清热镇惊之效。

方三：取穴大椎、合谷、人中，强刺激15分钟，出针，再在双合谷各注入安痛定0.3毫升，约10分钟左右每能收搐止惊平之效。

方四：取穴：百会。用1寸半不锈钢毫针沿头皮刺入针体2/3，留针6小时，上午针刺，下午起针。隔日针1次，5次为1疗程。

配穴：抽搐发作时刺人中。高热者加大椎、曲池、合谷，强刺激。呕吐者加上脘、梁门、气海、内关。腹胀者加中脘、章门。腹泻者加足三里、天枢。咳嗽加肺俞。食欲不振加四缝（点刺挤出黄白色组织液）。全部配穴不留针。并配合治疗原发病（如上呼吸道感染、肺炎等）。

针刺百会可以改变脑神经的失常状态。对脑神经的调节是自然的调节，不会对脑组织产生任何副作用。

方五：取耳廓神门穴，兼刺神门穴处怒张的血管放血，并加捏皮质下、枕和脑干穴处。

神门穴有镇静、安神、止痛、退热作用。放血有止痛、发汗、消炎、退热之功。皮质下、脑干及枕穴区，能刺激脑神经，使其恢复调节机能，增强抗病能力，达到镇惊、消炎、退热、止痛的效果。

方六：取穴：后溪透劳宫、足三里。强刺激，得气后即出针。对顽固性持续性的惊厥，可予留针，并配合用银花、连翘、板蓝根等清热解毒药物。

按摩治疗

按摩、推拿治疗旨在治风先治惊，治惊先豁痰，祛痰先解热，作为一种辅助治疗，有较好疗效。

方法一：揉阳池，平肝清肺，清天河水，捣小天心。

纳呆呕吐者加顺运八卦，清胃。腹泻者加揉外劳宫。发

热者加退六腑，去天河水。

揉阳池能清脑安神镇惊。平肝经能平肝熄风，开郁除烦。清肺经能疏风清热，顺气化痰。清天河水能清热除烦安神。捣小天心能通窍散郁，安神定惊。

方法二：按揉人中、合谷、中冲、足三里、中脘、天枢、涌泉，并冲服紫雪丹，推上三关，退下六腑，开天门，分阴阳，引水上天河，揉内外劳宫，掐精威二穴，两扇门，苍龙摆尾，赤凤摇头，点大肠俞，捏脊。

方法三：医者以左手握住患儿的右手或左手（男左女右），使患儿手掌伸平，右手拇指沿患儿食指第二指间关节尺侧横纹起始端掐起，并逐渐推到中央四缝穴处，然后再沿第二指间关节桡侧横纹起始端，逐渐推到中央四缝穴处，也称“挤掐四缝穴”。以下中指、无名指的操作方法皆同，按次序连续掐完3指为治疗1次，每天1次。

其他治法

（一）中成药保留灌肠法：取安宫牛黄丸1粒，大黄苏打片10片，用温开水100毫升化开，用注射器直接将药液推入肛门，或用灌肠器直接将药液灌入直肠。保留15分钟，即可出现肠鸣腹泻，排出燥屎，这样就能使高热退而抽搐停止，效果良好。

（二）药酒擦浴法：事先泡好药酒（银花、薄荷、乙醇制成擦浴剂。取银花30克，薄荷15克，75%酒精50毫升，将银花、薄荷泡入酒精中，置三天三夜，即可开瓶使用），重点擦洗曲池、大椎、风池、风府及腋下等处，治疗外感引起的小儿高热惊厥，收效良好。

用药注意事项

（一）由于外感高热而引起惊厥者，首先应鉴别其是风

寒还是温热之邪。由风寒引起高热惊厥者可采用葛根15克，柴胡10克，青蒿10克，防风6克，黄芩10克，钩藤15克，石决明15克，全蝎3克，僵蚕6克。水煎服。不可发汗太过，以防津伤热炽，反致病情加重。解表也不可用辛香走窜之药。由温热之邪引起高热惊厥者，可用辛凉解表及清热解毒药物如银花、连翘、生石膏、知母、薄荷、芦根、黄芩等并加钩藤、石决明、全蝎、僵蚕等熄风止痉药物。

(二) 治高热惊厥无表证者，可用犀角1.5克，赤芍10克，丹皮10克，黄芩15克，黄连10克，生地15克，钩藤15克，石决明15克，羚羊角粉1克（冲服），桑叶10克。

(三) 凡高热引起之惊厥，兼见神昏谵语，舌绛，脉细数者，应及时选用“三宝”（即紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄丸）。至宝丹开窍力强，安宫牛黄丸清热解毒力胜，紫雪丹熄风镇惊为优。但由于“三宝”价格昂贵，药源也比较紧张，不能满足临床需要。凡遇惊厥先兆的患者，可早期使用菖蒲10克，郁金15克（剂量小了效果不理想），蜈蚣1条，僵蚕10克，钩藤15克，蝉衣6克，全蝎6克，以镇痉熄风，及时控制病情。

(四) 除了及时使用“三宝”或上述“三宝”的代用品以外，须重视养阴药的使用。因为小儿高热惊厥来势暴急，病情凶险，急则治标。小儿稚阴未充，体属纯阳，多出现阳热之证，最易伤阴，故治疗时应注意顾护阴液，所谓“存得一分津液，便留得一分生机”。宜配合使用生地、麦冬、元参、石斛、玉竹等养阴药。高热之后，常出现余热未清，痰热未净，神疲乏力，烦躁不宁，舌微黄而腻，脉滑数者，不能再峻猛之品，可用琥珀抱龙丸清热镇惊，益气和中，熄风化痰。

预防性治疗

《内经》说：“上工治未病”。小儿高热惊厥为危急重症，严重威胁小儿的生命。故发作前的治疗（即预防性治疗，亦称预防法），意义较大。临床上见到小儿高热惊厥的先兆症状，应及早使用“三宝”。先兆症状是：高热不退，口渴喜饮，面红目赤，时有惊跳现象，烦躁不安，摇头弄舌，两目呆视，舌红绛，苔黄燥，此时应高度警惕，当预防高热惊厥的发生。在治疗原发病（引起高热的原发病如上呼吸道感染、肺炎等）的同时，及早加用“三宝”或“三宝”的代用药物（即大剂量菖蒲、郁金、及蜈蚣、僵蚕、钩藤、蝉衣、全蝎）。

小儿发热渐炽，面赤，二目直视似怒或斜视，哭时少泪或无泪，或哭声重而不连续，嗜睡，或梦中惊醒，咬牙齧齿，手足微有抽动，神识不如寻常，此亦高热惊厥将要发生之预兆也。宜用羚羊角粉、安宫牛黄丸等作预防性治疗。

家庭护理注意事项

当家中有小儿发烧突然抽风时（小儿高热惊厥），当家长的首要不要慌乱，不要大声呼叫或拍打摇晃孩子。如果孩子全身发烧，头向后仰（角弓反张），不要用力弯曲孩子，不要把孩子扶成坐位搂在怀里。应把孩子放在床上或桌面上，不要枕头，把孩子的头歪向一侧，免得口腔里的粘液吸到气管里而影响呼吸。

以往很多学者认为，当孩子抽风时，迅速用缠上纱布的压舌板或筷子塞到孩子的上下牙之间，避免把舌头咬伤。现在看来，这种作法没有必要。重要的倒是应该及时将小孩的领扣解开，免得因领口过紧而影响呼吸道的通畅。

当发现小儿高热惊厥时，应急送医院检查治疗。在送医

院之前应争分夺秒，用毛巾浸泡凉水冷敷孩子头部，放冰糕、冰块也行。用少量白酒擦小儿颈部、腋下、大腿根部（鼠蹊部），以利散热。

小儿高热惊厥经过治疗痊愈后，怎样预防复发？

单纯性高热惊厥（临床表现见本文开头的叙述）一般不需要长期服药以防复发。而复杂性高热惊厥（临床表现见前述），则需长期服药以防复发（或减轻复发症状）。服药1~3年（预防性服药），待过了高热惊厥的好发年龄，就可以逐渐停药了。

科学研究发现，微量元素镁对预防小儿惊厥有效，镁对维护中枢神经系统的结构和功能，抑制神经、肌肉传导的兴奋性，保障心肌的正常收缩和冠状动脉的弹力和反应，调节酶的活力都有重要作用。小儿血镁下降，容易出现惊厥。

含镁丰富的食物有紫菜（海产品）等。小儿惊厥患者可适当多吃紫菜。

79. 小儿脑性瘫痪

小儿脑性瘫痪是一种进行性的脑损伤综合征。病变主要累及大脑皮质、锥体系、锥体外系，以及脊髓等。其临床表现，是以大脑功能发育不全，智力低下，四肢运动障碍为主。有的患者尚伴有癫痫、失语、失明等症状。

根据患儿的运动障碍情况，临床可分为四型：

（一）痉挛型：握力增强，肌肉张力增高，将患儿垂直抱起时，两下肢垂直，两足内收或内旋，甚而两腿交叉呈剪

刀样。肘关节屈曲，上肢内收于胸前，两腕及指关节变形。

(二) 舞蹈型：以舞蹈样徐动症为主，步态不稳，行走时身体歪斜前倾。

(三) 混合型：以上两型的表现兼而有之。

(四) 精神意识障碍型：智力低下，愚笨，行走倾斜欲倒，或下肢瘫痪，伴有癫痫及语言障碍、听觉障碍、视觉障碍。

小儿脑性瘫痪属于祖国医学的五迟、五软范畴。中医认为，肾为先天之本，肾主骨生髓通于脑。脑为髓海。肾虚则脑髓失养。中医还认为，心主血脉，主神智，心肾阴虚则大脑发育不良，心肾阳虚则大脑功能低下。中医还认为，脾为后天之本，脾主肌肉四肢，脾虚则肌肉萎缩甚至瘫痪。

小儿脑性瘫痪的治疗，宜益气养血，补肾填精。

中药疗法

方药：熟地30克，山药30克，巴戟10克，菟丝子15克，黄精30克，枸杞30克，黄芪30克，党参30克，当归30克，紫河车粉30克，红参30克，僵蚕10克，天麻10克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重3克。1~2岁小儿每服1丸，3~6岁每服1.5丸，7~10岁每服2丸，每日服2次，开水送服。连服1年。

食物疗法

软瘫肌肉萎缩患儿，可吃健脾生肌的鸡肉松、牛肉汤、莲子大枣小米粥或补益气血的桂圆莲子汤、黄芪当归炖鸡；如硬瘫肌肉挛急患儿，可吃滋阴潜阳并养血柔肝的生地羊肝汤、枸杞葡萄干银耳糯米粥；如弱智患儿可吃补益心脾的核桃、桑椹、山药、黑芝麻、百合枣仁小米粥、紫河车牛骨髓油茶面。平素吃的食物应注重动植物蛋白互相补充，多吃鱼虾与新鲜蔬菜、坚果类（如核桃）、瘦果类（如葵瓜子）等

食物。

针灸疗法

取穴：智能低下取百会、风池、四神聪。语言障碍取通里、廉泉、金津、玉液。颈项软瘫取天柱、大椎。上肢瘫痪取肩髃、曲池、外关、合谷。下肢瘫痪取环跳、髀关、伏兔、足三里。腰部软瘫取肾俞、腰阳关。肘关节拘急取手三里、支正。指关节屈伸不利取合谷透后溪。腕下垂取外关、阳池、阳溪。足内翻取绝骨、昆仑、承山外一寸。足外翻取三阴交、太溪、照海、承山内一寸。足掌下垂取解溪、商丘、丘墟。剪刀步态取风市、阳陵泉、绝骨。抽筋取阳陵泉、太冲、承筋。食欲不佳取足三里。

方法：每日针刺1次，补法为主，捻转提插后不留针。3个月为1疗程。每疗程间隔1周。

按摩疗法

可在患处施以下手法：

- ①按法：采用指按或掌按或肘按患处。
- ②摩法：术者用手掌大面积抚摩患处（圆形摩动）。
- ③推法：用手掌在患肢作水平推动。
- ④拿法：拿持紧握，固定患处或关节。
- ⑤捏法：捏持皮肤或肌腱兼提拉。

⑥揉法：按兼揉摩，力垂直向下兼圆形移动，范围比摩法小，用力比摩法大。

80. 川崎氏病 (皮肤粘膜淋巴结综合征)

川崎氏病, 又名皮肤粘膜淋巴结综合征(简称MCLS), 是一种儿童期所特有的以全身血管炎为主要病理表现的急性发热性出疹性疾病。1942年川崎富作在日本首先发现, 故又名川崎氏病。病因尚不明。多发于5岁以下的儿童。持续高热, 眼结合膜充血, 口唇充血皸裂, 杨梅舌, 颈淋巴结肿大, 四肢远端硬性肿胀疼痛, 后期指端充血脱皮, 临床表现比较特殊, 病死率约为1~2%, 多突然死亡。根据日本MCLS研究委员会制定的诊断标准, 具备5项以上主要症状即可确诊: ①发热5天以上, 抗生素治疗无效。②急性期出现四肢末端非凹陷性浮肿, 指趾末端红斑, 恢复期指趾甲皮肤移行部呈膜样脱屑。③多形性皮疹(躯干部较多), 无水疱、痂皮形成。④两侧球结膜充血。⑤口唇鲜红, 杨梅舌, 口腔粘膜弥漫发红。⑥非化脓性颈淋巴结肿胀。目前对本病尚无特殊疗法。西医一般应用抗生素、阿斯匹林治疗。

皮肤粘膜淋巴结综合征, 属于祖国医学温病、暑温范畴。中医认为温热邪毒侵入营血, 正邪交争则出现持续高热; 内迫营血, 从络而出, 发为皮疹; 热毒极甚, 心营受灼, 见于心窍而见杨梅舌; 肺胃热毒上逆故见唇红干裂, 口腔粘膜弥漫性发红; 温热邪毒搏结则致淋巴结肿大; 炽热邪火上逆于肝, 发为两目红赤; 热毒流注经脉导致四肢末端红斑、浮肿、膜样脱皮。本病之发生, 心、肝、脾、肺均受其累, 尤以营血为甚。其治疗宜清热凉血, 透热解毒, 佐以生

津止渴。

方一：犀角3克，丹皮10克，赤芍10克，生地30克，蝉蜕10克，青蒿（后下）30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，紫雪丹1支（溶入），生谷芽30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方二：银花30克，连翘30克，生石膏30克，知母10克，青蒿（后下）30克，玄参10克，麦冬10克，生地10克，丹皮10克。水煎，频服，每日1剂，连服10~15剂。

方三：水牛角屑30克，生石膏30克，竹叶12克，板蓝根30克，芦根30克，生地30克，玄参10克，桔梗10克，连翘15克，银花30克，麦冬30克，紫雪丹1支（溶入），丹皮10克。水煎服，每日1剂，频频与服，连服10~15剂。

81. 先天性巨结肠

新生儿先天性巨结肠是儿科少见病症。以便秘、腹胀、呕吐为主证。现代医学认为，由于直肠及乙状结肠远端肠壁肌间神经丛发育不全，神经节细胞减少或缺如，致此肠段经常处于痉挛状态，呈功能性梗塞，粪便通过困难。结果，粪积近端结肠，肠管扩张，肠壁增厚，巨结肠由此形成。小儿外科主张作巨结肠根治术。

目前认为先天性巨结肠是在胚胎6~12周时神经母细胞向消化道壁内移行的过程中，出现发育停顿所致。导致发育停顿的原因可能与母亲在妊娠早期受病毒感染或其他环境因素（物理的或化学的）影响有关。

临床表现：多数病例出生后胎粪排出延迟，24~48小时不排胎粪，或每天只排出少量，必须灌肠或用其他方法处理，才有较多的胎粪排出，持续3~5天尚未排净。以后婴儿经常便秘，3~5天或更长时间排便1次，量较少，少数病例经过几个月后才逐渐出现便秘，且越来越顽固。先天性巨结肠病儿易发生小肠结肠炎，而出现腹泻，故便秘与腹泻交替出现，也是这种病的特点。呕吐是常见症状，一般次数较少，但也有频吐者。呕吐物中有胆汁，偶可吐出粪便样物。多数病儿均有腹胀，以上腹部最为明显，有时可见巨大的肠型和蠕动波。可于左下腹部触到巨大的粪块，有的坚硬如石，有的较软，压迫时可使其凹陷变形。病儿可伴消瘦、贫血、呼吸困难和下肢水肿。直肠指检可发现直肠扩张，并积存大量粪便。

X线检查常可确诊。

先天性巨结肠属于祖国医学的“臌胀”范畴。中医认为“浊气在上，则生臌胀”（《素问·阴阳应象大论》），先天阴阳错乱，气滞血瘀，痰湿壅阻，脏腑气机升降失调。其治疗宜益气健脾，化痰逐瘀。

方一：党参10克，麦芽10克，茯苓6克，枳实6克，鸡内金6克，法夏6克，厚朴6克，白术6克，砂仁3克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。同时外用甘油栓润肠通便。

方二：广明参10克，茯苓10克，白术10克，丹参10克，陈皮5克，鸡内金6克，酒制大黄6克，枳壳6克，法夏6克，桃仁6克，红花6克，当归6克，川芎6克，木香3克，砂仁3克，甘草3克。水煎服，每日1剂，此方可随证加减，一直服至小儿食欲及二便正常，腹胀消除。

方三：莱菔子10克，茯苓10克，当归6克，苡仁6克，白

术6克，桔梗6克，陈皮6克，白芍6克，玄明粉6克，大腹皮6克，酒制大黄6克。共研粗末，加麸皮少许，共炒黄后喷醋，乘热敷脐部。每天1次，每次敷1~2小时，坚持敷药1~2年，可避免手术。

82. 小儿肺不张

小儿肺不张是小儿多种胸部疾病引起的一种并发症。肺炎、肺结核、支气管异物、佝偻病、营养不良等均可引起小儿肺不张。

肺不张在小儿中比较常见。小儿支气管软骨发育尚不健全，管壁软弱，管腔狭窄，易于受压和阻塞。肺不张病因较多，以肺炎最为常见，尤以新生儿肺炎和吸入性肺炎为甚。婴幼儿肺炎易并发肺不张的因素大致有：支气管因炎性刺激引起痉挛，使管腔狭窄；炎性分泌物聚集，支气管粘膜水肿引起阻塞；肺泡与肺泡之间，肺泡和肺泡导管之间的侧支通道发育不完善；患肺炎时，肺泡表面活性物质减少，婴幼儿多处于仰卧位，痰液不易引流。

临床表现：胸闷气短，咳嗽不止，或咳吐涎沫。患儿体温不高，白细胞总数及分类正常。一侧肺不张起病急，以呼吸困难为主，患侧呼吸运动受限。肺段性肺不张多由肺炎粘稠分泌物阻塞所致，症状与原发疾病（肺炎）有关。肺段不张本身多无症状。肺叶性不张临床最多见。起病可急可缓，呼吸困难少见。

X线特点：受累肺叶呈均匀致密阴影。如完全不张，肺

叶体积缩小；上叶不张在正、侧位片均呈楔形，其尖端向下并指向肺门；右中叶不张正位片呈大片状致密阴影，前弓位呈三角形影相，同时可见原发疾病的表现。伴发于肺炎时可见肺部云絮状或点片状阴影。原发结核者则可见肺门淋巴结肿大，心脏病者可见心脏扩大，佝偻病者可见肋骨有相应的改变。

小儿肺不张经X线检查可以确诊。

小儿肺不张属于祖国医学的“肺痿”范畴。中医认为系痰热内阻，肺气不宣所致。治宜清热化痰，宣肺理气。

方药：瓜蒌10克，枳壳5克，黄芩10克，黄精10克，桑白皮5克，茯苓5克，前胡5克，百部3克，连翘10克，蒲公英10克，天竺黄3克，甘草3克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

外科

83. 急性附睾炎

附睾炎常继发于尿道炎、前列腺炎、精囊炎。细菌主要经尿道、射精管、输精管逆行而到达附睾。血行感染较少见。病原菌为大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌等。急性附睾炎早期病菌首先侵犯附睾尾部，附睾管上皮充血、水肿。后期炎症逐渐蔓延到附睾体和头部，有时形成脓肿，大多数炎症消退后留下纤维疤痕。

急性附睾炎起病急骤，一侧阴囊内红、肿、热、痛，压痛明显，疼痛沿精索放射到腹股沟。患者体温升高，白细胞数升高。诊断主要靠局部检查。

急性附睾炎属于祖国医学的“子痛”范畴。中医认为外寒客于足厥阴肝经，使气血凝滞，肝脉环绕阴器，寒滞肝脉，则阴囊内（附睾管）拘挛疼痛。或湿热下注肝脉，郁而化热，附睾红肿热痛。其治疗宜分辨寒热，辨证施治。

辨证施治

（一）寒滞肝脉：附睾肿大，疼痛，小腹牵扯不适，腰酸，四肢无力、舌淡苔白，脉沉弦。治宜暖肝散寒，行气活血。

方药：小茴香15克，肉桂3克，茯苓30克，当归15克，青皮10克，陈皮12克，白芍30克，木香10克，川牛膝30克，

橘核30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

(二) 肝脉湿热：附睾管红肿热痛（灼痛），发烧不适，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜清热利湿，疏肝理气。

方药：龙胆草15克，车前草30克，川牛膝30克，赤芍30克，丹皮10克，黄柏10克，知母10克，泽泻30克，木香10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

外治法

方一：桉叶150克，千里光150克，松树叶100克，将上药洗净后，放入砂罐内，加水1000毫升，煎20分钟，用消毒纱布滤取药液，装瓶备用。用时取药液热敷患处，每次20~30分钟，早晚各敷一次（用于肝脉湿热型）。

方二：胡椒7~10粒。研末备用。用时加适量面粉调成糊状，平摊于纱布或软纸上，敷于患侧阴囊，每日或隔日1次，5次为1疗程（适用于寒滞肝脉型）。

84. 急性睾丸炎

急性睾丸炎多发于青壮年男性。起病急骤，初期仅感阴囊（睾丸）胀痛不适，不久出现肿胀（不是附睾管肿胀，而是睾丸肿胀）和剧烈疼痛，有的伴有恶寒发烧，身软乏力，口渴，小便短赤、小便刺痛，少腹痛，会阴部不适。检查可见一侧阴囊红肿灼热，皮纹消失，皮肤紧张光亮，扪之睾丸肿大，质地坚硬，触痛明显。白细胞总数可升高，中性粒细胞可升高。有的患者小便化验可有白细胞、红细胞、脓球等。

急性睾丸炎患者常合并尿道炎、膀胱炎、前列腺炎等，

多伴尿路感染的症状（尿频尿急尿痛）。

急性睾丸炎属于祖国医学的“子痈”范畴。中医认为系肝胆湿热循经下注厥阴之络，以致湿热壅积下焦，气血凝滞而成。其病位在肾（睾丸为外肾），而病变在肝。盖肝脉绕于阴器，上抵少腹。因此在治疗上宜清热泻火，利尿除湿、软坚散结，行气止痛。

方一：龙胆草15克，车前草30克，生地30克，柴胡12克，葶草60克，大黄10克，橘核30克，荔枝核30克，枳实10克，地龙15克，木香10克，昆布30克，海藻30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。服药后大便稀溏，不需处理。

患者须卧床休息，患处冷敷，并用阴囊托悬吊。

方二：玄胡10克，桃仁10克，茅根30克，泽泻30克，木通10克，当归30克，山梔12克，黄芩30克，车前仁30克，黄柏15克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂，局部用金黄膏外敷。

方三：大黄12克，白花蛇舌草（水线草）30克，青皮10克，赤芍30克，制附片5克，丹皮15克，川楝子12克，玄胡12克，夏枯草30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

方四：贯众60克。去毛洗净，加水700毫升，煎至500毫升，每日早晚各服250毫升，或分次当茶饮。

方五（外治法）：大青叶30克，大黄30克，芒硝30克，蜂蜜适量。用法：前三味药共研为细末，用蜂蜜调匀，外敷于患处，纱布固定，每天换药1次，3次为1疗程。

急性睾丸炎采用灸疗法也有一定疗效。方法如下：取艾绒捻成绿豆大的艾炷，在阳池穴的穴位表面涂凡士林，上置艾炷，每次灸3炷，每日灸1次，连灸1星期。

85. 蛇伤性溃疡

蛇伤性溃疡系指患者被毒蛇咬伤经抢救脱险后，但未能及时处理伤口，导致神经血管广泛受损，组织大面积坏死而形成的溃疡。蛇伤性溃疡与一般的下肢慢性溃疡(臁疮)，在预防、治疗上均有所不同。

辨证施治

(一) 邪毒未尽，正气已虚：疮形平塌，根盘散漫，腐肉不脱，疮口流脓，日久不愈，舌淡苔白，脉迟缓。治宜益气活血，托毒消肿。

内服方：黄芪60克，党参60克，苡仁30克，银花30克，丹参30克，赤芍30克，半枝莲30克，半边莲30克，白花蛇舌草30克、三七粉6克(冲服)，乳香10克，没药10克。水煎服，每日1剂，连服30~40剂。

外用方：先用拔毒生肌膏外敷，后用生肌玉红膏外敷。

(二) 邪毒炽盛：伤口红肿热痛，或伴发热，大便秘结，尿黄，舌红苔黄，脉弦数。治宜清热解毒。

内服方：黄连10克，栀子10克，黄芩30克，黄柏10克，生大黄10克，车前草30克，赤芍30克，丹皮15克，皂刺15克，紫花地丁30克，银花30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

外用方：半边莲30克，紫花地丁30克，苦参30克，夏枯草30克，芙蓉花叶30克，鱼腥草30克，蚤休30克，野菊花20克。煎水洗患处。

验方治疗

方一：龙胆草15克，水煎饮服。重者每2~3小时煎服一次，每日量不超过45克。

方二：龙胆草15克，半边莲30克，青木香15克，银花30克，苡仁30克，菊花15克，赤芍30克，大黄10克，紫花地丁30克，夏枯草30克，土茯苓30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

方三：大黄10克，黄连10克，黄柏10克，天花粉20克，白芷12克，甲珠20克，僵蚕10克，半边莲30克，麦冬30克，白花蛇舌草30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

外治法

方一：桉树叶30克，生甘草3克，煎水外洗，并用此煎汁浸纱布湿敷。

方二：鱼腥草30克，槐花30克，野菊花30克，芙蓉花10克，煎汤待冷外洗患处。每次洗半小时，每日1~2次。

方三：白芷24克，山慈菇45克，大黄45克，冰片6克，猪油180克，制成油膏，外敷患处。

方四：虎杖60克，水煎，用煎液湿敷伤口。

方五（适用于脓性分泌物多者）：龙骨40%，黄连、黄柏，大黄各20%，共研细末，撒于患处。

方六（适用于脓性分泌物少者）：青黛3克，红升丹3克，轻粉1.5克，冰片1.5克，炉甘石6克，煅石膏15克，共研细末，撒于患处。直至伤口痊愈。

86. 糖尿病趾端坏死

趾端坏死是糖尿病的一种较常见而又较严重的并发症之一。坏死部位多在下肢特别是足趾，局部发黑、疼痛，夜间疼痛尤甚，趾端相继破溃，周围组织红肿发热，坏死区（溃疡面）可逐渐扩大。检查白细胞总数可升高。

糖尿病趾端坏死多由腿部大动脉硬化，血管弹性减弱，血管腔内阻塞，足趾供血不足所致。微循环障碍是糖尿病趾端坏死的病理基础。本病多见于长期患严重糖尿病、缺乏体力活动的患者。

糖尿病趾端坏死属于祖国医学的“坏疽”范畴。中医认为多由消渴伤阴，阴液虚亏，久则阴损及阳，阳气不能敷布温煦，乃致趾端阴寒凝滞，血脉瘀阻而成。《读医随笔》说：“叶天士谓：久病必治络。其说谓病久气血推行不利，血络之中必有瘀凝，故致病气缠绵不去，必疏其络而病气可尽也”。糖尿病趾端坏死的治疗，宜活血化瘀，疏通经络，消肿止痛。

方一：丹参注射液14毫升，川芎嗪80毫克，用0.9%生理盐水50毫升稀释，经患侧股动脉注入，每天1次，用药10天休息3天，30天为1疗程。

本方能改善患肢血液循环，增加患肢血液供应，促使缺血性溃疡愈合。本方还能缓解血管痉挛，扩张血管，能活跃和疏通微循环，活血化瘀，消肿理气，消炎止痛，扩张小动脉。

方二：桂枝50克，生附片50克，丹参100克，银花藤100克，生黄芪100克，乳香24克，没药24克，放锅内，加水5公斤，煮沸20分钟，将药液倒入木桶，降温至50℃时，将患肢放入木桶内浸泡，药液可浸至膝部。为了防止药液温度下降过快，可在桶外套一塑料袋，袋口扎在腿部。每次浸泡30分钟。每晚泡1次，每剂药可浸泡5天。每次浸泡前，将药液煮开放冷至50℃再用。

方中丹参、乳香、没药、银花藤活血化瘀，疏通经络，消肿止痛；桂枝、附子温经散寒，通脉回阳；黄芪益气生肌。诸药合用，共奏活血化瘀、温经散寒、消肿止痛、益气生肌之功。浸泡可直接使患肢血管扩张，血流加快，改善趾端血液供应，促使坏死部愈合。

87. 急腹症术后综合征

外科急腹症术后综合征，是手术后（手术本身为物理性创伤）胃肠功能紊乱的症状群，表现为脘腹疼痛，痞塞胀满，恶心呕吐，食欲不振，膈肌痉挛（呃逆），泄泻或便秘，甚至导致肠梗阻、肠粘连等。

急腹症术后综合征属于祖国医学的“升降失常”、“气滞血瘀”、“肝郁脾虚”等范畴。中医认为手术失血耗液，损伤脏腑经络，元气亦为之损伤，又因患者对手术恐惧，情志抑郁，常造成气机郁结逆乱，而致肝之疏泄失司。《丹溪心法》云：“血气冲和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉”，诚为经验之谈。急腹症术后综合征的治疗，宜疏肝解郁，活血

化痰，理气通腑。

辨证分型及治疗

(一) 肝郁血瘀：多见于胆道手术后，胸胁胀痛或刺痛，或痛有定处，入夜尤甚，或疼痛攻窜不定，伴憋闷不舒，口苦欲呕，治宜活血化瘀，理气解郁。

方药：丹参30克，柴胡10克，元胡10克，川楝子10克，郁金15克，枳壳10克，川芎10克，当归10克，炮甲珠10克，生大黄10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(二) 肝气犯胃：多见于上腹部手术后，胸胁胀满，呕吐吞酸，食入即吐，甚则呕胆汁，暖气频频，舌红苔腻脉弦。治宜疏肝和胃。

方药：法半夏12克，厚朴10克，藿香10克，竹茹10克，吴萸10克，黄连10克，生大黄6克，旋覆花10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

(三) 肝郁热结：多见于胃肠手术及阑尾手术后，胸胁疼痛，痞塞胀满，腹痛拒按，便秘尿黄，舌红苔黄厚，脉弦。治宜泻热通腑。

方药：生大黄10克，柴胡15克，厚朴10克，枳实10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

验方治疗

方一：丹皮10克，苡仁30克，冬瓜子20克，桃仁10克，熟大黄6克，甘草10克，赤芍10克，柴胡10克，枳实10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

方二：莱菔子10克，神曲30克，槟榔10克，厚朴10克，茯苓15克，麦芽30克，谷芽30克，山药30克，苡仁30克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

患者注意事项

1. 腹部手术后宜取半卧位。人体腹腔的表面和腹壁内侧各有一层腹膜保护着腹腔内的脏器。它的总面积几乎与皮肤的面积相等。在正常情况下，腹膜能分泌少量浆液来润滑腹腔，使内脏活动时减少接触面之间的摩擦，同时，腹腔对液体和微小的颗粒又有强大的吸收能力，特别是对液体的吸收，每小时可多达体重的8%。然而，腹膜各部分的吸收能力又有所不同，上腹部比下腹部强。根据这一解剖生理特点，腹部手术后的病人取半卧位，可使手术后的渗出物因重力作用沿肠襻间下流，最后聚集局限在盆腔内。这样，一方面可减少腹内器官与渗出物的接触面，减少继发感染，减少腹膜对细菌毒素的吸收。另一方面，有利于局部开口引流，使手术伤口早日愈合。而且，半卧位还有利于排出呼吸道的分泌物，避免得吸入性肺炎。总之，腹部手术后取半卧位是保证病人及早康复的重要的一环。

2. 腹部手术后宜早期下床活动。腹部手术后宜早期下床活动，这是因为人在正常情况下，腹膜会经常渗出少量液体以减少脏器之间的摩擦，脏器间不会发生粘连。然而，由于腹部手术使腹膜受到不同程度的损伤，腹膜为了抵御手术创伤、出血、异物、炎症等对它的刺激，就进行“自卫”，渗出大量的白细胞、吞噬细胞和抗体，还围歼细菌，吞噬异物，清除坏死组织。同时腹膜损伤面还有纤维素渗出，伤面周围的毛细血管内皮细胞和成纤维细胞沿着纤维素进入创面，分别生成新生毛细血管和胶原纤维。这种新生的结缔组织象伤口愈合过程的结疤一样，使肠管之间、肠与大网膜、肠系膜之间相互粘合在一起，于是形成肠粘连。另外，手术中肠管受到了牵拉翻动，肠管过久暴露在腹腔外，以及麻醉等因素，均能引起肠管反射性麻痹，使肠管的运动机能发生障碍。

在这种情况下，病人如能早期下床活动，则由于体位的变换和重力的影响，肠管就能恢复正常的生理排列，尽快恢复肠蠕动，也能尽早“拉断”新生的结缔组织，有利于防止肠粘连。

一般来说，阑尾炎手术后第二天宜下床活动，胃、肠、胆道等手术后第三天，拔除胃管后即可下床活动。虽然，引起肠粘连的因素很多，但实践证明，手术后早期下床活动无疑是免除术后腹痛反复发作、预防肠粘连的重要措施之一。

3. 宜做腹部轻柔按摩。在胃肠手术后，出现胀气，可用掌根和手指在腹部从上至下做圆形循环移动（按摩），动作要轻柔，以病人自觉舒服，能耐受为度。一般按摩15分钟后，病人的肠胀气感觉就会减轻，说明已有肠蠕动出现。

4. 宜用松节油热敷腹部。胃肠手术后，为促进肠蠕动恢复，宜用松节油热敷腹部。方法是：准备一只盛有松节油和植物油混合液（1：4）的药杯，再盛一盆热水，内放一条小毛巾。操作时，暴露腹部，腰下垫一块塑料布和一块干净棉布，先将排气肛管插入肛门，用胶布固定，随后用棉签蘸松节油混合液涂于腹部（脐下3厘米至耻骨联合，两侧至髂前上棘），再将小毛巾拧干抖开，铺在涂油处的腹部皮肤上，再盖上塑料布、棉布和热水袋，盖上被子，5分钟后再换毛巾1次，5～10分钟涂油1次，一般热敷20分钟，即可出现肠蠕动。

5. 宜用艾卷熏腹部。胃肠手术后，为促进肠蠕动恢复，宜用艾卷熏腹部。将艾条点燃后，置于脐上四寸中脘穴之上，距皮肤1厘米左右，有患者局部有舒适温热感，熏烤5～15分钟，一日3～5次，可逐渐使肠蠕动恢复。

6. 术后病人宜常吃鱼。手术后（包括急腹症手术后）痔

人，由于组织损伤，血液流失，蛋白质破坏分解增多，如果病人不补充营养，蛋白质摄入少，则伤口愈合缓慢，对病人十分不利。

鱼营养丰富，蛋白质含量高，消化吸收率可达96%，鱼所含蛋白质氨基酸的组成和人体相似，它可供给人体所必需的氨基酸。鱼所含的磷、钙也丰富。鱼肉细嫩，结构细致，煮熟后损失水分极少。鱼所具有的这些优点，对急腹症手术后的病人是非常合适的。

至于说吃鱼会引起伤口化脓是没有根据的。伤口化脓系细菌感染所致，即使不吃鱼，伤口感染后也会化脓。吃鱼的手术后病人，若伤口无细菌感染，照样不会化脓。

88. 腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症，又名腰椎间盘突出纤维环破裂症，这是青壮年人的一种常见病。由于腰间盘退变或遭受外力引起间盘向后方（椎管内）突出，压迫神经根，导致放射性神经痛和神经功能障碍。

成年后椎间盘开始退变。除纤维环边缘外，椎间盘没有血液循环，修复能力较差；椎间盘经常遭受强大的挤压、牵引和扭转应力，加重其生理退变；这些因素是腰间盘突出的基础或内因。搬取重物或不慎转身倾跌撞击等外伤、弯腰劳动、积累劳损引起纤维环破裂；风寒湿引起肌肉张力增高，导致间盘内压升高；这是腰间盘突出的条件或外因。下腰部活动多，负重大，故腰4、5椎间盘突出最为多见。

80%腰间盘突出症患者为青壮年，1/3有腰外伤史，1/2以上为体力劳动或曾参加过比较长期的体力劳动或运动。

临床表现：1.腰痛：突出的椎间盘压迫纤维环外层、后纵韧带或硬膜引起腰痛。部分患者发病前有慢性劳损症状，另一部分患者则突然发病。

2. 下肢放射性疼痛：放射性腿痛可与腰痛同时出现，或发生在腰痛缓解之后。腿痛多为单侧坐骨神经痛，疼痛由臀部开始，沿大腿后面、腘窝、小腿向下扩展直至足部。咳嗽、喷嚏、用力排便及一切使脑脊液压力增高的活动，都可使神经根更加紧张而加重症状。步行、弯腰、伸膝起坐等牵拉神经根的动作也可使疼痛加重。屈髋、屈膝卧床休息时疼痛减轻。病程较长者，其下肢放射痛部位感觉麻木。

体征：1.腰部畸形：是人体缓解神经根紧张度的代偿体位，约90%的腰椎间盘突出症患者有不同程度的脊柱侧弯，多数突向患侧，少数突向健侧。

2. 运动障碍：约90%的患者腰部运动受限，屈伸和左右侧弯呈不对称限制。

3. 有压痛点：间盘突出的椎间隙棘突旁有深在压痛，按压痛点可引起或加剧下肢放射痛，故压痛点的位置有定位意义。患侧环跳、委中、承山、飞扬等穴位常有明显压痛。

4. 腰肌痉挛：突出的间盘刺激脑膜支末梢或神经根，可引起同侧反射性或根性肌痉挛。骶棘肌、髂腰肌、大腿后方肌群和梨状肌都可发生痉挛。痉挛的肌肉触之硬韧，如长期肌痉挛不得缓解，可引起肌肉继发变化，产生疼痛和压痛。肌痉挛亦可增加间盘内压，加重突出倾向，引起恶性循环。

5. 直腿抬高试验阳性，坐骨神经牵拉试验阳性；膝腱

反射减弱或消失，肌力减退和肌肉萎缩；皮肤感觉减退；屈颈试验、颈静脉压迫试验、挺腹试验阳性。

腰间盘突出症患者经休息和治疗，其症状和体征可减轻或消失，劳累或轻微外伤后又可再现。时愈时发是腰间盘突出症的特点之一。

CT腰椎扫描，X线摄片检查可以确诊。

大多数腰椎间盘突出症患者，可根据病史、症状和体征做出诊断。

腰椎间盘突出症属于祖国医学的“腰腿痛”的范畴。《内经》说：“肾者，作强之官”。肝肾亏损则不能作“强”，致筋骨懈堕，转摇不能，不能久立。其治疗宜滋肾养肝，舒筋活络。

中药治疗

方一：土鳖虫、川牛膝、甘草、乳香、没药、全蝎、僵蚕、苍术各30克。

制法：乳香、没药先置铁锅内加热，并以灯芯去除油质，烘干。然后研成细末。其余各药分别研成细末，和匀，装瓶备用。

用法：每晚临睡前服15克，用黄酒或白开水送服。连服4周。本方适用于腰间盘突出症腰痛症状突出的患者服用。

方二：制附片（先熬）15～30克，熟地20克，肉苁蓉15克，巴戟10克，仙茅10克，仙灵脾30克，乌蛇15克，桂枝10克，蜈蚣2条，陈皮6克。水煎服，每日1剂，连服4周。

本方适用于肾阳虚（腰腿痛，喜暖怕冷，面色苍白，唇淡）患者服用。

方三：熟地20克，白芍30克，女贞子30克，木瓜30克，制首乌30克，枸杞15克，知母12克，全蝎10克，川牛膝30克，泽泻15克，羚羊骨30克。水煎服，每日1剂，连服4周。

本方适用于肾阴虚（消瘦，面色潮红，咽干，唇红）患者服用。

方四：茵陈30克，苡仁30克，苍术30克，桃仁12克，威灵仙15克，山梔10克，黄柏10克，防己15克，滑石30克，桑枝30克。水煎服，每日1剂，连服4周。

本方适用于湿火型（面红目赤，肢体烦热，或有低热，口苦欲饮，尿短赤）患者服用。

方五：生地30克，赤芍30克，川牛膝30克，三七粉6克（冲服），桃仁12克，大黄10克，红花10克，玄胡10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，枳实10克。水煎服，每日1剂，连服4周。

本方适用于气滞血瘀型（腰痛严重，俯仰不便，转身困难，近期有外伤史，腰部肿胀有瘀斑，拒按，舌有瘀点）患者服用。

方六：当归80克，续断30克，杜仲15克，寄生30克，独活12克，狗脊30克，枸杞15克，钩藤30克，熟地30克，川牛膝30克，威灵仙15克，白芍15克。水煎服，每日1剂，连服4周。外用麝香舒活灵（药酒）或舒筋活络酒外搽。本方对各种类型的腰间盘突出症患者均适用。有补益肝肾、强筋壮骨、通利经脉之功效。

针灸治疗

取穴：肾俞、大肠俞、环跳、阳陵泉、悬钟、委中、志室、腰阳关、承扶、殷门、昆仑。

方法：每次针刺（选穴）6~8穴，针感以下传为佳，针刺得气后留针30分钟，其间催针3次。并可在针刺结束后即行推拿。

推拿治疗

推拿治疗腰椎间盘突出症有较好疗效。推拿的手法和流派较多，兹择要介绍如下：

1. 三板法

(1) 侧卧斜扳法：患者侧卧，医生用一手抵住患者肩前部，另一手抵住臀部，把腰被动旋转至最大限度后，两手同时用力作相反方向扳动。

(2) 俯卧后扳法：患者俯卧，医生用一手托住患者两膝部，缓缓向上提起，另一手紧压在腰部患处，当腰后伸到最大限度时，两手同时用力作相反方向扳动。

(3) 直坐旋转扳法：患者取坐位，医生用腿夹住患者双膝，左手抵住患者右肩前部，右手拉住患者肩后部，两手同时向相反方向扳动。

隔日操作一次。三板法操作必须连贯，快速，切忌动作粗暴，用力要稳。

三板法可帮助患者被动活动，利用韧带与纤维环的紧张与松弛，使突出错位的椎间盘核回纳到正常生理状态的位置，以解脱它对神经根的压迫，则腰腿疼痛麻木自除。

2. 四步七法

第一步：仰卧位

(1) 对抗牵引：助手固定患者两腋下，术者握住双踝部，并抬高 $30\sim 40^\circ$ ，牵引3~5分钟。

(2) 屈膝压髌：先屈患肢，术者两手分别扶住膝踝部，屈膝屈髌后向腹部按压6次；再做健侧，屈膝屈髌按压6次；最后双下肢屈膝屈髌向腹部按压6次，操作时尽量带动腰椎在床面上作纵向屈伸滚动。

第二步：侧卧位

(3) 扭腰斜扳：先扳患侧，后扳健侧。患者健侧卧

位,健下肢在下伸直并稍加牵引,患下肢在上尽量屈髋屈膝。术者一手按肩部,一手按臀部,向相反方向扭动腰椎到最大限度时,双手突然同时用力轻巧扳动腰椎4~6次,扳动时暴力不宜太大,以闻及响声为宜。

第三步: 俯卧位

(4) 对抗牵引3分钟。

(5) 抖动振腰: 助手双手托起患者两下肢,向上抬高45°,术者双手掌重迭按压于突出部位,稳准有力弹性按压6次,使腰部弹性上下振动。

第四步: 仰卧位

(6) 抬腿扳足: 先扳健侧,后扳患侧,下肢被动抬腿90°位,助手按压足底向下扳动,使足过度背伸,反复6次。

(7) 对抗牵引3分钟。

尔后平卧15分钟,待血压平稳,仰卧硬板床休息,24小时后翻身,7~10天后带腰围下地,逐步增加活动。

3. 推拿六法

(1) 屈压法: 适用于腰不能前屈者。此法的特点是先屈后拉(紧接着要使用抖拉法)。

患者仰卧躺正,嘱患者精神不可紧张,全身放松,医者将病人的患腿弯曲,左手按在被屈的膝盖略向下一点部位,用力往下按,右手把住复位床的边缘。双手齐用力,把患腿屈到胸前,以紧贴胸前为度,如此可使髓核变形,产生弹性回缩力,随即抖拉。这样突出部位就可以复位了。

(2) 抖拉法: 患者仰卧躺正,嘱患者精神不可紧张恐惧,全身放松,固定两腋窝部。医者两手握住患侧踝上部,先向胸前一送,随即猛一拉,再仿此法拉健侧一次,这样一送一拉即称“抖拉法”。

以上两种手法，能运动关节，可促使血液和淋巴循环增快。由于病变部位血液和淋巴循环的改善，能加速水肿和病变产物的吸收而使瘀血得化，肿胀消除。并可解除软组织的痉挛、粘连嵌顿和错位。

（3） 膊运法：复位后再用此法。运腰部最痛点（即天应穴）。

病人俯卧，医者用前臂尺侧腕屈肌，在病人的患部，顺时针或逆时针一个方向（带动肌肉）地作圆形旋运，务必使局部发热，越热效果越好，不热则无效。此法能舒筋腱、活血脉、通经络、止疼痛、祛风湿、散寒邪。

要想知道是否复位，可令病人下床站立，两腿略分开，呈八字式，脚跟着地，双手下垂不扶膝部，自然蹲下，再次站起来，说明已复位。根据临床观察若复位不好，多半蹲下站不起来，或根本蹲不下。复位好的，可立即下床直腰，蹲起自如，甚至能跑步。

（4） 指旋法：患者俯卧，医者握拳，拇指直伸，呈手屈一指式，拇指峰按住患者的最痛点，较用力地带动肌肉，一个方向旋转地运转，称“指旋法”。此法能分筋拔络，缓痉止痛，适用于小关节隙孔深处痛重的部位。

（5） 背整法：又称“对背整复位”，适用于腰不能后伸者。

医者和病人背贴背，医者双肘弯部用力勾住病人的双肘弯，将病人背起来，把病人略向下一坠沉，这时病人头努力向后仰，紧贴医者颈部，病人的突出部位就贴在医者的骶骨部，医者向前屈腰，病人自然腰后伸，医者再直腰，再向前屈，多次反复，会听到病人的腰部有响声，告诉病人千万不可放开手，出现响声不可怕，一撒手就要跌倒地上出危险。

医者作完这些动作后，需将病人轻轻放在床上，仰卧休息几分钟，病人再俯卧，用膊运法运疼痛部，运至发热为好。

患者腰部通过背整法，反复多次前屈后伸，下肢坠沉，可使前纵韧带和后纵韧带松紧伸缩，产生弹性活动力，这时髓核可跟随变形而还纳。

(6) 挠力法：又称“鹰爪力法”。适用于腰前后都不能弯者。

医者的一只手，五指伸直分开，然后用力将每指第一指关节屈曲成勾状在患者的脊背部，由颈部至腰背部用力迅速向下摩脊数次，越快越好，摩得脊背发热如火烧即可。这时患者感觉全身轻松，就可弯腰。

此法能鼓舞活力，通畅血液循环，温经活络，散寒祛湿，大补真阳。

4. 分期推拿法

此法分急性期推拿手法和慢性期推拿手法。

(1) 急性期。因组织水肿明显，刺激或压迫神经根，症状严重。此期手法不能过重，需用温和手法，在疼痛部位采用推、滚或轻肘按法，促进局部血液循环加快，水肿吸收，纤维环修复，使症状缓解。被动手法可用对抗牵引，或用屈伸腰法，即患者侧卧位，术者立于患者身后，一臂托住患腿，用托腿的手使屈髋，并使大腿尽量贴近腹壁，另手推同侧肩部，使身体屈曲，再做后伸腰部动作，这样连续3~4次，使后纵韧带处于一松一紧状态，使突出物回纳。此时再辅理疗，使血液循环进一步改善，水肿更快吸收，症状和体征可进一步得到改善。

(2) 慢性期。在急性期后症状可较前缓解，但常因劳累等多种因素，出现反复，症状时轻时重，由于病程较长，

突出物和神经根周围软组织已粘连，故此期需用较强的手法（但需在病人能耐受的情况下），除一般的推、滚等手法外，更重要的是做被动手法：①斜扳法：即患者取侧卧位，患肢在上屈曲位，术者两肘分别置于肩前及髋后作相反方向推旋，听到“喀嚓”响声效果更好。②腿后伸法：患者取俯卧位，术者一手压腰骶部，一手拖大腿近膝关节处，当拖腿的手臂用力向上一掀时，同时另一臂压腰，有时能听到“喀嚓”响声。③压腰：即在胸部和大腿部各垫一二个枕头，腹悬空，术者双手重叠压于腰骶部一压一松连续三四次，压腰的幅度逐渐增大，以能作用到腰椎体间为度。④扳腿：术者一手置于患肢足后跟，一手压于膝盖上方，将腿强行抬高至超出病理活动范围，但不能超出正常生理活动范围。以上手法根据病人具体情况选择应用。

总的说来，推拿治疗腰椎间盘突出症有较好疗效，但必须早期发现，早期治疗。

就其作用来说，推拿手法除了可松弛腰部紧张肌肉，促进血液循环，促使水肿炎症吸收，达到消肿止痛的作用外，主要是推拿被动手法通过脊柱后伸，过屈和扭转动作迫使突出的椎间盘组织回纳。但通过推拿手法是否能回纳，学术界有不同看法。但大多数学者认为，腰椎间盘突出能否回纳，固然同推拿手法有关，但根本问题是不同的病情起着决定作用。早期幼弱型和中间型腰椎间盘突出症，经过推拿、牵引、休息可自行回纳缩小，压力减低，组织水肿消退，纤维环修复，症状消除而治愈。但对于那些不可逆的成熟型腰间盘突出症（纤维环已完全破裂，突出物已进入椎管），已与附近组织产生粘连，则推拿难以使其回纳，仅能使髓核组织改善病理位置，同时可减轻突出物与神经根和周围组织粘连，从

而减轻对突出物的刺激和压迫，改善症状。

因此，腰椎间盘突出症患者一定要及时治疗。

患者注意事项

腰椎间盘突出症患者要注意休息，切勿劳累。合理的休息加上早期治疗（包括推拿、牵引等等），可使突出物回纳。

患者宜睡硬板床休息，这样可减轻体重对椎间盘的压力，使椎旁的肌肉松弛，促进血液循环，减轻症状。

患者切勿睡席梦思软床。由于席梦思软床太软，人睡上去后，脊柱就会形成弧形弯曲，造成脊柱变形，加重腰部的负担，会使腰椎间盘突出症加重。

当病情好转后，患者应在医生指导下从事功能锻炼。因为功能锻炼是巩固疗效的极为重要的措施。

患者可在床上做三点支撑式功能锻炼（图1）、弓桥式功能锻炼（图2）、飞燕点水式功能锻炼（图3）。



图 1

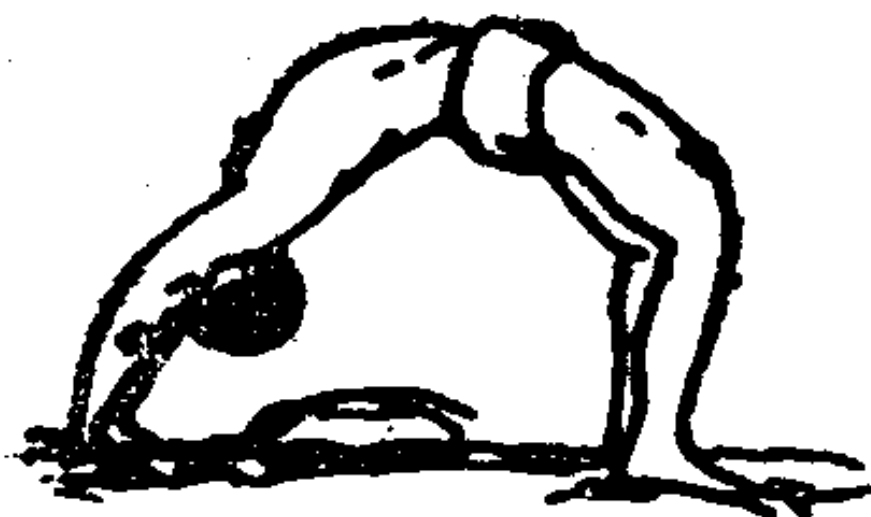


图 2



图 3

89. 桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎

拇长展肌腱及拇短伸肌腱，经过桡骨茎突部的骨沟，上有韧带覆盖，形成纤维骨性鞘管，肌腱出鞘管后折成一定角度分别止于拇指及第一掌骨。当拇指及腕活动时，折角更加大，从而更增加管壁对肌腱的压迫和摩擦。久之，局部发生炎症反应，肌腱变粗，管壁变厚，逐渐产生症状。

手工操作者因经常用拇指捏持操作，拇长展肌腱常处于紧张状态，故发病率较高，女性患者多于男性，女性的拇长展肌及拇短伸肌腱，从腕到手的折角较男性为大，发病率高。哺乳期及更年期妇女患此病者更为常见。

本病起病缓慢，但也有突然发生症状的。桡骨茎突部疼痛，可放射至手或肩、臂。腕及拇指活动时疼痛加重，伸展拇指受限。桡骨茎突部可触及硬结节，有明显压痛。

中药外敷治疗和针灸治疗、按摩治疗有较好的疗效。

中药外敷治疗

方药：白芷30克，南星30克，天麻30克，羌活30克，防风30克，生白附子60克。

用法：上药共研细末待用。用时先以黄酒适量炖热，加入药末调匀如厚糊状，按患处肿痛面积的大小，摊于油纸上，约1厘米厚，趁热敷于患部，外缠绷带。每日更换1次，连换3~5次。

针灸治疗

主穴：阳谿、偏历。手腕屈曲疼痛加刺外关，拇指、食

指疼痛加刺合谷；前臂疼痛加刺曲池或手三里。每次针灸取2~5穴，主穴必取，均取患侧。阳谿穴可针刺7分深。偏历穴可针尖向手之方向刺入1~1.5寸深，针体与皮肤呈15~35°角。采用捻转或刺入捻进或速刺进针法，待针感逐步放散至疼痛部位或拇指后，根据病情的轻重，可留针30~60分钟。留针时间内兼施灸法，以艾卷灸针柄（重点是阳谿、偏历穴）10~30分钟。

按摩治疗

1. 推前臂三阴法：患者直坐或仰卧，左或右前臂平放于床上，手掌向上，医者坐其侧。

医者用两手拇指掌侧对置于肘内曲泽穴处，其余四指扶定前臂，自上向下沿经前臂伸侧正中线经内关至大陵穴推动2~3分钟。

使患者前臂微向桡侧倾斜，以两拇指掌侧对置自肘内尺泽穴处，由上向下推动沿桡侧外缘经孔最至太渊穴止2~3分钟。

再使患者前臂微向尺侧倾斜，以两拇指掌侧对置自肘尺侧少海穴处，由上向下推动沿尺侧缘至神门穴止2~3分钟。

操作时患者上臂与前臂均应平放成一直线。

推动时两拇指应用力均匀，用力大小以皮肤微红为度。

2. 分掌法：患者直坐，手掌向上，医者坐其侧。

医者以手拇指置腕关节掌侧大陵穴处轻轻指揉后，再以拇指掌侧自上向下经劳宫推动至中指端止1~2分钟。

再以两手拇指对置大陵穴处，其余四指置患者手背之两侧扶定，然后以两手拇指掌侧沿大、小鱼际分摩至拇指少商穴及小指少泽穴处止，反复摩动3~5分钟。

推动或分摩时着力应轻缓而有节律。

3. 梳手背法：患者直坐或仰卧，前臂放于桌上或床上，手掌向下，手指直伸，医者坐其侧。

医者以四指掌侧置腕关节阳池穴处，摩动时再将四指分置于1~2指、2~3指、3~4指、4~5指之间掌关节间隙，自上向下呈梳状摩动至液门穴平高处止，反复操作2~5分钟。

操作时掌心应尽量放平。梳摩动作应缓慢而着力。

治疗时有牵拉及舒适感，治疗后有局部温热的感觉。

90. 屈指肌腱狭窄性腱鞘炎

屈指肌腱狭窄性腱鞘炎，又称“扳机指”，拇指及中指较多见。好发于家庭妇女、轻工业操作工人、使用管弦乐器的音乐家。又称“弹响指”或“弹响拇”。腱鞘炎多发生在拇指掌指关节，子骨与韧带形成的环状鞘管处；其余各指多发生在与掌骨头相对应的指屈肌腱纤维鞘管的起始处。此处鞘管厚、硬，是指屈肌腱屈曲时力量向远方传达的支点。手指屈伸活动时，该处的纤维鞘管反复压迫和摩擦肌腱，局部鞘管渐增厚，形成环状狭窄，肌腱渐呈梭形膨大，色暗黄，失去原有光泽。

发病初期，手指屈伸时，膨大的屈肌腱还可勉强通过鞘管的狭窄环，产生扳枪机样动作及弹响。严重时手指常交锁在屈曲或伸直位。可触及局部皮下有硬结节，手指屈伸时结节可随之稍活动，并有弹动感。局部压痛明显。

屈指肌腱狭窄性腱鞘炎属于祖国医学的“筋结”范畴，中医认为系气滞血瘀所致。根据中医“结者散之”的理论，可采取

中药外敷治疗和针挑法治疗。

中药外敷治疗

生穿山甲片7片，大蜘蛛7只，全蝎7只，大蜈蚣7条，僵蚕7条，麝香1克，公丁香3克，母丁香3克，冰片3克，飞滑石3克。

用法：上药各研细末，和匀，再研至极细，每次用0.3克左右，将药粉摊于患处，需敷在压痛点及其周围，然后用4厘米见方的胶布覆贴药粉，需完全盖没，以免影响疗效。亦可用此药粉掺于膏药上贴敷。冬季5~7日换药1次，夏季每日换药1次。

针挑法治疗

1. 工具：三棱针。

2. 术前准备：患手仰掌，腕背置脉枕上，术者以右拇指摸定患指最痛点，即结节间沟，用自来水笔点上标记。常规皮肤消毒，再用普鲁卡因2毫升作局部浸润麻醉。

3. 手法：三棱针针体垂直接原定标记刺入皮下（患指向术者），当针进入皮下层有一种空虚感时，针尖应缓进轻探，当针尖探得中等硬实感即抵达腱鞘，再略微进针（约0.3毫米）刺入腱鞘，控制该深度，然后术者利用腕部旋转力和中指的顶推力，将三棱针沿腱鞘纵轴方向斜向上方挑拨。挑拨时若有拨断绊索感或“沙沙”声，即为正常信号。否则，针尖未达病所，再控制该深度沿腱鞘纵轴方向倾斜针体，平移针尖继续挑拨数次（5次左右），直至绊索感消失，便将针尖退到皮下，令患者屈伸手指，若仍有轻度弹响，再以上法深挑。若无弹响，患指活动即可自如，说明手术成功。取出三棱针，包扎伤口。4小时后作患指屈伸活动，每日活动3次，3日后痊愈。

皮肤科

91. 梅 毒

梅毒是由梅毒螺旋体（亦称苍白螺旋体）引起的慢性传染病。主要通过性交传染，属于性病的一种。初起时即是全身性感染，病程缓慢。在疾病发展过程中可以侵及人体任何器官和组织，产生各种症状。有时可潜伏多年甚至终身不产生任何症状。梅毒有时可自愈，但易复发。

梅毒螺旋体在人体外的生活力较低，在干燥环境中和阳光直射下迅速死亡。普通的消毒剂 and 热肥皂水均能在短期内使其死亡。在40℃时失去传染力，48℃可生存30分钟，60℃时存活3~5分钟，100℃时立即死亡。但在-10℃可生存3小时。

传播途径分直接传染、间接传染、胎盘传染三种。与梅毒患者接吻、性交可直接传染。间接传染的途径有：接触被梅毒患者污染的用具、物品如餐具、马桶、浴盆、出租的游泳衣裤等。医生对梅毒患者检查或手术，不慎也可被感染。误输入梅毒患者的血液，梅毒患者喂奶等，均可引起间接传播。孕妇可通过胎盘传给胎儿，称为胎传梅毒。

梅毒的临床表现

（一）自得梅毒（直接传染和间接传染的）

1. 第一期梅毒：大约在感染后3周左右发生硬性下疳。

硬性下疳通常发生于外生殖器，如男性的冠状沟及其邻近部位，女性的阴唇和子宫颈。非性交的传染可见于唇、舌、肛门、乳头、手指等处。硬性下疳初起时患处微红，以后逐渐变为硬结直径约1厘米，单个，偶有2~3个，圆形或椭圆形，呈红铜色，表面糜烂，有少量粘性分泌物，或覆盖灰色薄痂，边缘整齐。

患早期硬性下疳时，局部淋巴结肿大，晚期则全身淋巴结肿大，血清反应阳性。病程5~7周。下疳可“不治自愈”。

2. 第二期梅毒：(1)第二期早发梅毒疹。于感染梅毒后6~8周发生。其特征为：①在发疹前2~3天有低热，头痛，肌肉和关节疼痛，食欲减退。②梅毒疹损害对称、广泛、稠密，疹与疹之间不融合。③不痛不痒。④有全身淋巴结肿大。⑤血清反应强阳性。

二期早发梅毒疹有下列几种类型：

①玫瑰疹型或斑疹型梅毒疹。惯发于躯干前面、侧面及上肢。斑疹约1厘米大小，圆形或椭圆形，或略带不规则形，初起为淡红色，2~3周后带青色或棕色。

②丘疹型梅毒疹。好发于躯干和四肢，亦可见于面部和掌跖。丘疹大小不一，米粒大或黄豆大或蚕豆大，成簇排列，或排列成环形，为红铜色，丘疹消退时则呈褐色，表面可有少量鳞屑。

③脓疱型梅毒疹。较少见，有严重的全身症状，发生深浅不一、大小不等的脓疱，在丘疹的基础上发生脓疱，直径约0.5厘米左右，分布稠密，愈后不留疤痕。

以上三型早发梅毒疹，均可“不医自愈”，但可复发。复发时则称为第二期复发梅毒疹（2~4年内复发）。

(2)第二期复发梅毒疹。形态与早发梅毒疹相似，均为

全身性和对称性，但数目较少，分布范围较小，仅见于面部及四肢，或仅见于掌跖，或仅见于皮肤粘膜交界处。

3. 第三期梅毒（晚期梅毒）：第三期梅毒的损害不仅限于皮肤粘膜，并可侵犯任何内脏器官或组织，破坏性大，病程长，可危及生命。血清反应阳性。

第三期梅毒有以下两种类型：

①结节型梅毒疹。发生于皮内或皮下，呈成群的结节状或片块状。结节如黄豆大或葡萄大，几个到几十个，面部和四肢多见，分布不对称，排列成环形或多环形。如系片块状梅毒疹，则可能一边呈活动性，另一边呈退行性。触之坚实，呈红铜色或棕红色。病程长。有的结节型梅毒疹可被吸收，有的则形成溃疡，持续甚久。愈合后可形成萎缩性瘢痕和暂时性色素沉着。

②梅毒瘤。初起时为皮下结节，可自由移动，逐渐向上扩大，与皮肤及周围组织粘连，非常坚硬，小如橄榄，大如胡桃，圆形，高出皮面，青红色或暗红色。梅毒瘤的中心逐渐软化，表面破溃，形成圆形、腰子形或多环形的溃疡，渗出少量脓液，愈后形成萎缩性疤痕。梅毒瘤惯发于头部、小腿上半部外侧、颈侧、前臂、胸锁骨交界处，一般无自觉症状。

第三期梅毒如治疗不彻底，患者的病情又可处于静止的状态。此时称为第三期隐性梅毒。

（二）胎传梅毒

1. 早期胎传梅毒：一般于生后3周至3个月之间发生。常见的症状有：①营养障碍。如消瘦，皮肤萎缩，貌似老人。②皮疹。发生于口腔外围及臀部，严重者皮疹可泛发全身。皮损为深红色或紫铜色浸润性斑块，其外围有丘疹。掌

跖皮肤损害多为大疱或大片脱屑。口周损害愈合后遗留放射性疤痕,有一定的诊断意义。③粘膜损害。多为梅毒性鼻炎,有时发生喉炎。皮肤粘膜交接部位也可发生湿丘疹和扁平湿疣。④骨损害。可发生骨炎、软骨炎,导致假瘫痪。⑤肝、脾及全身淋巴结肿大。

2. 晚期胎传梅毒:可发生结节性梅毒疹和梅毒瘤。此外尚有以下特殊临床表现:①8~15岁时可发生角膜炎,视力受严重影响。②神经性耳聋,多在10岁左右发病。③楔状齿,马鞍鼻,马刀胫。

梅毒可通过实验室检查及X线检查等确诊。

梅毒属于祖国医学的“杨梅疮”、“横痃”、“疳疮”等范畴。李时珍在《本草纲目》中写道:“杨梅疮古方不载,亦无病者。近时起于岭表,传及四方”。按十六世纪初欧亚交通发展情况查考,梅毒似乎是在1500年后传入我国,先传至广东,然后自南而北广泛传到全国。中医认为杨梅疮可分①精化传染(直接传染):与杨梅疮患者交媾,精泄时毒气乘肝肾之虚入里而得;②气化传染(间接传染):接触病人或同厕、同寝等传染,毒从外入,内犯肺脾而成;③胎中染毒。

中医辨证要点

(一) 疳疮

1. 大多生于男女前后阴,亦可见于口唇、乳房、眼睑等处。

2. 初起为粟米大丘疹或硬块,四周焮肿,亮如水晶,破后成溃疡,色紫红,并无脓水,四周坚硬凸起,形如缸口,中间凹陷成窝,基底平坦清洁。

(二) 横痃

1. 病发于疳疮之后。

2. 在胯腹部一侧或两侧发生、初起形如杏核，渐大如鸡卵，色白坚硬不痛，皮核不相亲。

3. 很少破溃，可存在数月或数年，如经治疗，可迅速消退。

4. 偶可出现红肿、灼痛破溃，脓有臭味，疮口形成空壳。

(三) 杨梅疮

1. 病发于染毒后10周左右。

2. 生疮前头痛发热，骨节酸痛，咽痛。2~3天后出现皮疹。

3. 皮疹形态颇多，有色如黄蜡，破烂肉翻的翻花杨梅；形如赤豆，嵌入肉内的杨梅豆；形如风疹的杨梅疹；先起红晕，后起斑片的杨梅斑。

4. 杨梅疮先见于胸部，以后续见于腰腹、四肢屈侧、颜面及颈部，最后见于手部。

(四) 杨梅结毒

1. 病发于梅毒后期。

2. 发无定处，随处可生，不但侵犯皮肤，亦可侵及脏腑而危及生命。

3. 生于皮肤者，结毒逐渐肿起，小如豌豆，大如胡桃，皮色变褐，但无疼痛，将溃时皮色暗红；溃后疮口凹陷，边缘整齐，腐臭不堪，经年累月，难于收口；愈后形成疤痕。数目有数个至数十个。

4. 发于头部巅顶，能引起头痛、眼胀，渐至脑顶塌陷。

5. 发于口鼻者，可形成鼻塌、唇缺，硬腭穿孔与鼻腔相通。

(五) 小儿遗毒

1. 发于出生后3周至3个月之间。
2. 婴儿消瘦，干枯。
3. 口角发生皲裂，愈后结疤。手掌足底可有光亮斑片及大水疱；臀部皮肤剥脱，形成烂斑。
4. 鼻孔肿胀，有脓血性鼻涕，乳儿呼吸、吮乳皆感困难。如不治疗，可致鼻骨塌陷。
5. 膝及踝关节可发生肿胀和剧痛，引起四肢运动困难。

梅毒总的治疗原则是清血解毒

(一) 内治法

方一：土茯苓60克，银花60克，威灵仙30克，白藓皮30克，苍耳子15克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服两个月为1疗程。

方二：大蟾蜍一个，土茯苓150克，白酒1000克，将活蟾蜍及土茯苓泡入酒内，以酒淹没药为度。瓶口封严，泡1周，每次服药酒30毫升，每日服2次，连服两个月为1疗程。本方适用于梅毒的各个阶段。

方三：银花30克，土茯苓30克，夏枯草30克，龙胆草12克，木通10克，泽泻30克，车前草30克，柴胡12克，生地30克，当归15克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。本方适用于梅毒肛门部下疳。

方四：紫草30克，银花30克，土茯苓30克，连翘30克，紫花地丁20克，蒲公英30克，水煎服，每日1剂，连服1~2个月。本方适用于肛周及其他部位的梅毒疹。

方五：银花60克，土茯苓60克，黄连15克，黄芩30克，黄柏15克，白头翁30克，苡仁30克。水煎服，每日1剂，连服1~2个月。本方适用于梅毒瘤。

(二) 外治法

方一：黄连、黄柏、五倍子、儿茶、没药、乳香、珍珠、铅粉、轻粉、象牙末各等份，共研极细末，先用淘米水（烧开冷却）洗患处，再撒此药末。适用于下疳及梅毒疹溃烂。

方二：槐枝30克，桑枝30克，地骨皮30克，蛇床子60克，土茯苓60克，银花30克。水煎取液外洗患处。适用于各期梅毒皮肤溃烂。

方三：煅石膏、炒黄柏、轻粉各等份，共研为细末，撒布患处。适用于梅毒疹溃烂。

梅毒的预防

1. 严格遵守性道德，不乱搞两性关系。
2. 未婚男女应坚持婚前检查，以杜绝梅毒的蔓延和传播。
3. 有梅毒感染可疑的人，应及早就医。
4. 所有孕妇应作胎前检查，尤其是4个月以前的，都应坚持检查，以预防胎传梅毒的发生。
5. 梅毒患者的家属应及时检查，及时治疗。

92. 麻 风

麻风是由麻风分枝杆菌感染引起的一种慢性传染病，主要侵犯皮肤和周围神经。少数病例病变可累及深部组织和内脏器官。麻风很少引起死亡，但可导致肢体残废和畸形，使患者丧失劳动力。

麻风可通过直接接触而传染。亦可间接传染(飞沫传播)。

儿童对麻风杆菌免疫力较低,但随年龄增长而增强。成年人绝大多数对麻风杆菌有较强的抵抗力,不易受感染。但少数人对麻风杆菌无免疫力,易受感染。

麻风既不胎传,也不遗传。

麻风杆菌感染后,平均潜伏期为2~5年,但最短的感染3个月可发病,长者可达10年。

麻风杆菌除了侵犯皮肤及周围神经外,也可侵犯粘膜及淋巴结,甚至眼球、睾丸、卵巢、骨组织、肝、脾及其他内脏也常被累及。

临床症状

1. 皮肤损害:形态多样化,有斑疹、丘疹、结节、斑块、浸润、水疱、溃疡及萎缩等。皮肤附件如毛发、眉毛、毳毛可脱落;汗腺和皮脂腺可被破坏,造成汗闭及皮肤干燥。患者皮肤还有温觉障碍、触觉障碍、痛觉障碍。

2. 周围神经症状:受累的周围神经可呈梭状,结节状或均匀地粗大,有痛感或压痛,有时可出现干酪样坏死、纤维性变化及钙化等。常被侵犯的周围神经有尺神经、耳大神经、正中神经、腓总神经、眶上神经、面神经、桡神经、胫神经等。皮支神经亦可粗大。患者手、足、面部肌肉萎缩或瘫痪。尺神经受累可引起小指和无名指弯曲,小鱼际群及骨间肌萎缩,对指活动障碍,造成“爪形手”畸形。正中神经受累可使大鱼际肌瘫痪和萎缩,拇指旋后内收,掌面与手掌平行,形成“猿手”状。桡神经受累则形成垂腕及垂指畸形。腓总神经受累可产生足下垂。面神经受累则出现面神经瘫痪。

晚期麻风患者可出现皮肤干燥萎缩,易产生水疱或溃疡,指(趾)甲增厚失去光泽易破裂,肌肉萎缩,手足骨质

疏松，手足畸形，手足紫绀、温度降低、肿胀等。

麻风反应

麻风病患者病情发展很慢，但有的患者在病程中可突然发生急性或亚急性症状，这就是麻风反应。麻风反应是一种变态反应，气候变化，某些生理变化（如月经、妊娠、分娩等），并发其他感染，应用某些药物，预防注射，精神创伤，手术外伤等因素常可诱发麻风反应。

麻风反应可分Ⅰ型和Ⅱ型。

Ⅰ型麻风反应的临床表现：皮损红肿、浸润，局部发热，但无全身症状。受累的神经干粗大，有疼痛和触痛，手足或面部浮肿。

Ⅱ型麻风反应的临床表现：发热，头痛，皮肤出现结节性红斑，亦可出现多形红斑或坏死性红斑，神经干粗大并有压痛。其他尚有急性虹膜睫状体炎、急性睾丸炎和副睾丸炎、全身淋巴结肿大、关节肿痛、白细胞计数及中性粒细胞增高等。

不论Ⅰ型麻风反应和Ⅱ型麻风反应均须积极治疗，否则可引起畸形加重。

麻风病可通过麻风菌素试验，组胺试验，出汗试验，组织切片检查（找到麻风杆菌），并根据有皮损出现并伴有浅感觉障碍，闭汗，有麻木区，周围神经干或皮支神经粗大等确诊。

中医认为麻风系感染疔气，内侵血脉而成。治宜祛风化湿，活血杀虫。

治疗

（一）内治法

方一：白芷30克，全蝎30克，人参30克。共研细末，每次

服10克，每日早晚空腹时服用，白酒送服。连服半年。

方二：60度白酒1000毫升，放入大的活蝮蛇一条，醉死浸泡，再加入参30克，密封，置于冷处，一个月后取酒应用，每次口服5~10毫升，每日服2次。连服半年。

方三：苍耳草不拘多少，于小暑节采取，连枝带叶，洗去泥土，切细晾干，水煎2次，去渣滤净、再煎、浓缩成膏。装瓶备用。每次服一匙，每日服3次，开水送服。连服半年。

（二）外治法

方一：苦参60克，蛇床子30克，白芷15克，银花30克，野菊花30克，地肤子30克，紫花地丁30克，黄柏15克，蒲公英30克。水煎去渣，用药液外洗患处。每日洗1次，每次洗30分钟。

方二：熟石膏20克，升丹10克，共研细末，撒布患处。

93. 生殖器疱疹

生殖器疱疹主要是通过性交传播的传染病，仅次于淋病和梅毒。本病由单纯疱疹病毒Ⅰ型引起，主要侵犯生殖器部位，正常人可作为病毒携带者。人是单纯疱疹病毒唯一的自然宿主。病毒经过呼吸道、口腔、生殖器等侵入人体，当机体抵抗力降低时，可促使本病发生。

单纯疱疹病毒Ⅰ型，主要存在于女性的宫颈口、阴道、外阴和尿道；男性则存在于阴茎和尿道口。其传染性极强，凡与患阴茎疱疹男性发生一次性接触的女性，约有半数可发

病，危害严重，并可引起女性不孕、流产或新生儿死亡。许多学者并认为本病与子宫颈癌和阴茎癌发生有较密切的关系。

临床表现：感染病毒后到发病平均为1周，先在局部起红斑，遂出现成群的水疱，伴灼痒感，5天后变成脓疱，破后形成糜烂，最后结痂。可继发化脓感染，愈后遗留色素沉着。可继发尿道炎、膀胱炎或前列腺炎。

生殖器疱疹一般发生于龟头、包皮、阴囊、阴唇，少数见于臀部肛周。本病易复发，一年内复发率可达50%左右。复发诱因有发热、消化不良，性交等。

生殖器疱疹可通过实验室检查确诊，可在疱疹内液中查出疱疹病毒及病毒性巨细胞。疱液接种于家兔角膜可引起树枝状角膜炎。

中医认为生殖器疱疹系热毒(湿热)下注，治宜清热解毒。

治疗

(一) 内治法

方药：大青叶30克，板蓝根30克，生石膏30克，银花30克，连翘30克，贯众30克，土茯苓30克，白花蛇舌草（水线草）30克，知母15克，黄柏15克。水煎服，每日1剂，连服1个月。

(二) 外治法

方药：土茯苓30克，蚤休30克，皂刺15克，大青叶30克，贯众60克，银花30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，芙蓉叶30克，千里光30克。加水浓煎，坐浴，每次坐浴半小时，每日2次。

生殖器疱疹的传染性极强，夫妇双方应同时治疗。治愈后还必须重视预防，避免不洁性交。本病系通过性交传播

的，因此，必须自尊自爱，对两性关系必须持慎重态度。平时注意外生殖器部位的清洁卫生，也是十分必要的。

94. 激素制剂皮炎

激素制剂皮炎（简称激素皮炎）是滥用或长期应用激素制剂引起的一种接触性药物皮炎。是目前常见的一种皮肤病。激素皮炎易反复发作，应引起医务人员和病员的重视和警惕，加强防治。

激素皮炎患者多因曾患痤疮、脂溢性皮炎、单纯糠疹等皮肤病而用激素软膏治疗（包括肤轻松软膏、去炎松尿素软膏等），初起感觉良好，皮损改善，但久用则引起激素皮炎。还有一种情况也是滥用激素软膏而引起激素皮炎，患者曾错误地认为激素软膏能美容（能使皮肤细腻）而滥用之（如用强的松片剂调化妆品涂擦面部），久而久之则引起激素皮炎。

激素皮炎的临床表现为患处皮肤潮红、肿胀、丘疹、灼热、瘙痒，甚者起脓头、流水。或患处干燥脱屑、发热、红斑，口鼻气热。或原有之痤疮更为增多增大，患处发红、油湿、瘙痒。

激素皮炎属于祖国医学之“阳斑”范畴。《明医指掌》亦称阳证发斑。中医认为，凡发斑（皮炎）属于实热性者统属阳斑的范畴。激素皮炎表现为患处潮红、灼热，乃一派热象，故证属阳斑。治宜凉血解毒，清热止痒。

1. 内服方

方一：生地30克，丹皮15克，赤芍30克，丹参30克，紫草30克，连翘20克，白茅根30克，大青叶30克，甘草10克。水煎服（空腹时服），每日1剂，连服7~10剂。

加减：面部红肿，热感较重，或伴月经提前者加生石膏、生山栀。月经延后者加茜草、益母草。月经有瘀块，伴腹痛者加桃仁、红花、川芎。大便干燥加大黄。面部脓头较多加蒲公英、紫花地丁。

方二：桑叶15克，菊花30克，荆芥10克，银花30克，连翘30克，牛蒡子20克，蝉衣10克，生石膏30克，大青叶30克，乌梢蛇10克，百部10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

方三：紫草30克、猪苓30克，大青叶30克，百部10克，苡仁30克，茯苓30克，黄连10克，连翘20克，桑白皮30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂（本方适用于长期用激素制剂治疗痤疮反而引起痤疮增多，患处油湿者）。

2. 外用方：

苦参30克，百部30克，大黄15克，蛇床子30克，大青叶30克，银花30克。加水浓煎，外洗患处。

五官科

95. 球后视神经炎

球后视神经炎是脑炎的常见眼部并发症，以儿童为多见，是由于脑部炎症下行蔓延，经过视神经鞘而波及视神经，视力丧失很快。起初为视神经炎，而后导致视神经萎缩。

患者多于患流行性乙型脑炎或流行性脑脊髓膜炎或化脓性脑膜炎后，出现瞳孔散大，对光反应迟钝，眼球转动不灵活，或出现斜视。眼底检查，可见视盘色泽较苍白，边界清楚，视网膜静脉郁血。

球后视神经炎病情发展快，应及时治疗。

球后视神经炎属于祖国医学的“暴盲”、“青盲”、“视物昏渺”等范畴。《审视瑶函》中论述暴盲症时说：“此症谓目平素别无他症，外不伤于轮廓，内不损乎瞳神，倏然盲而不见也”。这很简要地概括了暴盲症的特征。中医认为青盲症“眼本无异，瞳子黑白分明，目内外并无障翳气色等病，只自不见”。《诸病源候论》载：“青盲者……但五脏六腑之精气，皆上注于目，若脏虚，有风邪痰饮乘之……，是脏腑血气不荣于睛”等所致。《审视瑶函》又有“……是乃玄府幽深之源郁遏，不得发此灵明耳”的记载。故凡肝肾亏损，精血耗伤，或久病虚弱，目失涵养，肝失条达，玄府阻闭，精营

不能上注等因皆可致之。此外，小儿青盲，又多由病后，热留经络，壅闭玄府，精华不能升运于目而成。

暴盲症的病因病机，历代中医学家归纳为三大类型，即“阴寡”、“阳寡”、“神离”。而这三者都可形成气血、经络闭塞不通。中医还认为久患热病可发为暴盲。脑炎一般均持续发热，久热必耗损津液，导致“阴寡”。津液属阴，津液不足，阴损及阳，则阳气失其所依，这就形成“阳寡”。津液耗损，经脉失养，阴阳失去平衡，导致“关格闭塞不通”。

球后视神经炎的治疗，宜疏肝解郁，滋阴养血，健脾清热。

中药治疗

（一）辨证分型治疗

1. 肝经郁热，玄府郁闭。头痛，眼痛，视物昏雾，胸胁隐胀，烦躁易怒，情怀不畅，口苦咽干，脉弦细，舌润无苔。治宜疏肝解郁，健脾清热。

方药：当归15克，柴胡10克，白芍10克，丹皮10克，栀子6克，枸杞15克，茯苓10克，白术10克，丹参10克，赤芍15克，升麻6克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

2. 肾阴不足，脉络郁阻：视物昏雾，视力下降，双目干涩，头晕耳鸣，腰酸，脉细数，舌红少苔。治宜滋阴补肾，滋水养肝。

方药：枸杞15克，菊花10克，熟地15克，山萸10克，山药15克，丹皮6克，茯苓10克，泽泻10克，当归10克，赤芍10克，磁石15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

（二）验方治疗：

方一：党参15克，白术10克，当归10克，茯苓10克，枸杞15克，大枣10克，柴胡10克，丹皮6克，川芎6克，冬虫夏

草6克，熟地10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方中党参、当归、熟地 益 血 养 阴，川芎理血活血，白术、茯苓、大枣补益脾胃，丹皮清热凉血，柴胡疏肝养肝，枸杞明目益肝肾，冬虫夏草 补 益 精 髓。诸药合用，补益肝肾，疏肝明目，防治球后视神经炎有一定疗效。

方二：熟地10克，巴戟10克，益智仁10克，山萸10克，远志6克，菖蒲6克，当归10克，枸杞15克，菊花10克，五味子10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方中熟地填精补肾，生精血，补五脏，尤其能治视物昏渺。巴戟强精，安五脏，补中增志，补五劳益精。王好古说：“巴戟入肾经血分药”，巴戟又能祛风散寒除湿，益精补血，故有明目之效。益智仁益精安神。刘完素说：“益智辛热，能开发散结，使气宣通。”由于气味辛温，能暖脾胃，补命门，益脾虚，能治心肾不足，有温肾之功。山萸补肾益肝，固涩精气。远志宁心安神定志。石菖蒲开窍。当归补血养血。枸杞、菊花明目，五味子能治瞳孔散大。诸药合用，滋补肝肾，生血益智，防治球后视神经炎有一定疗效。

方三：枸杞120克，白菊花60克，白酒500克，将枸杞菊花放入白酒中浸泡，泡3天即可饮用，每日服用药酒10~20毫升，分3次服用。连服1个月。

李时珍云：“枸杞甘平而润，性滋而补，不能退热，只能补肾润肺，生精益气，此乃平补之药，所谓精不足者补之以味也。”枸杞为目疾要药，对目不明有特效。白菊花久服利血气，养目明目。刘完素云：甘菊可“养目血、去翳膜”，故菊花具有清风明目，益肝补阴之效。白酒少少与服有活血通络功效。三药合用，可培补肝肾、通络活血，防治球后视神经炎有一定疗效。

针灸治疗

(一) 头针疗法

取视区，即从枕骨粗隆尖端向两侧水平地旁开1厘米，由此上引，使与头部前后正中中线平行的4厘米长的直线。病员正坐，术者选用26—30号、长1.5—2.5寸毫针，持针使与病员头皮呈30°角，沿头皮快速进针，刺入帽状腱膜下层时，拇指与食指指掌关节不断伸屈，使针体来回快速旋转（200次/分，每次左右各旋2转），持续1分钟后，即可起针，起针时如针下无沉重感，可缓慢出针。起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻，以防出血。每日1次，15天为一疗程。

(二) 体针疗法：

取穴：睛明，球后，风池，太阳，足三里，三阴交。

每次选2—4穴，得气后留针20分钟，中间行针1—2次。每日针刺1次，10天为1个疗程。间隔3天，可行第二疗程。

96. 青 光 眼

青光眼是一种以眼内压增高为特征的眼病。正常的眼球，经常保持一定的紧张度，这种紧张度是由眼内容物对于眼球壁所加的压力所形成，这种压力称为眼内压。我国人的正常眼内压在10~21毫米汞柱之间。影响眼内压的因素极为复杂，而主要是房水和眼球内血流量的影响，尤其是房水的产生和排出的平衡，直接影响眼内压的稳定性。房水主要由内睫状突产生，它的循环路径是先到后房，通过瞳孔而流入前

房，再由前房进入静脉系统。其中任何一个环节异常，均可造成眼内压增高。

青光眼初起时自觉症状不甚明显，或仅在久用目力、失眠或疲劳后，出现视力疲乏，眉心重坠，头胀晕眩，眼珠轻度隐胀不适，久则头旋、额痛或偏头痛、目内痛，或视灯有彩虹，或见飞花频频，或视物昏蒙。亦有突然头痛如劈，额头及眼眶胀痛，常有口苦咽干，目赤咽痛等伴随症状。若久治无效，可见瞳孔明显散大，视力急剧下降，眼珠按之坚硬如石。如病情继续恶化，可见瞳仁完全扩散，色呈绿色或黄色，视力严重丧失，终成瞎盲。

青光眼常双眼先后并发或同时并发，妇女易患此病。

青光眼属于祖国医学“瞳仁散大”范畴。中医又称“五风内障”。五风：即青风、黑风、绿风、黄风、乌风五种病症，乃根据瞳仁色泽而定名。“青风内障”为早期病变；“绿风内障”为青风内障进一步发展引起的急性发作阶段；“黄风内障”为绿风内障失治形成；“黑风内障”与“青风内障”类似，也属早期病变；“乌风内障”则由“黑风内障”继续发展，或由“绿风内障”缓解后传变而致。本病有急性与慢性之分，危害相似，应重视早期治疗。如治疗失当或失时，视力亦受影响，若瞳仁散大呈绿色或黄色，则预后不良。

中医认为青光眼的病因病机，多由七情内伤，气机失调。这与现代医学所指的血管神经舒缩不稳定所产生的局部微循环障碍，致使血液流变学和房水动力学异常而致眼压升高有关。中医认为“血不利则为水”，这与血液循环不畅，巩膜静脉压高，房水淤滞或分泌过多等学说相近。中医认为，眼乃五脏之精华，上注于目而为明，皆从肝胆发源，内有脉道孔窍，上通于目皆能视。目属肝，肝主怒，怒则火动痰

生，痰且阻隔肝胆脉道，则通光之窍受碍，两眼昏蒙。

治疗

(一) 辨证分型论治

1. 风热上壅，痰气滞目：瞳仁渐散，或兼现目赤，视灯虹彩，头目掣痛，胸闷泛恶，心悸眩晕，口干渴，烦躁不宁，呕吐痰涎，舌淡红苔薄黄，脉浮数。治宜疏风，清热，化痰。

方药：葛根30克，升麻10克，赤芍30克，青荷叶15克，黄芩15克，薄荷10克(后下)，钩藤30克，生地30克，白芍15克，菊花15克，羚羊角粉1克(冲服)，竹茹10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

2. 阴虚火旺：瞳孔微散，视力疲乏，眉心重坠，头眼胀痛，视灯虹彩，颧红唇赤，口苦咽干，五心潮热，舌绛，脉细数。治宜滋阴泻火。

方药：知母10克，黄柏10克，生地30克，山药30克，山萸10克，丹皮12克，泽泻30克，茯苓10克，菊花15克，阿胶10克，麦冬30克，白芍30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

3. 肝胆火炽：青光眼急性发作，瞳孔扩散，头痛昏眩，目胀痛，面赤，口苦咽干，呕吐泛恶，大便不畅，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。治宜清肝散热。

方药：龙胆草10克，木通10克，泽泻30克，柴胡10克，车前草10克，生地30克，当归30克，夏枯草30克，香附子10克，生大黄6克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

4. 肝阳上亢：头目眩晕、疼痛，瞳仁耗散，面红耳鸣，心中烦热，易怒，虚烦少寐，舌红，脉弦数。治宜滋阴潜阳，平肝息风。

方药：石决明30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，白芍30克，地龙15克，代赭石30克，天麻10克，香附子10克，车前子10克，磁石30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

5. 肝肾不足：瞳仁散大，反复发作，头痛，虹视，视力锐减，眼胀不适，舌红少苔，脉细数。治宜滋补肝肾。

方药：熟地20克，当归30克，枸杞15克，女贞子30克，麦冬30克，川芎10克，杜仲15克，山药30克，沙参15克，菟丝子15克，巴戟15克，山萸15克，车前子10克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

(二) 专方验方治疗

方一：车前子60克，加水200毫升，一次煎服，病势缓解后，用枸杞、当归、生地、沙参、山萸等善后治疗。本方适用于急性充血性青光眼。

方二：荠菜花30克，夏枯草30克，菊花15克，五味子10克，黄芩15克，白术15克，法半夏10克，竹茹10克，萆薢10克，茜草10克，梔子10克，丹参30克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。本方适用于痰湿较盛的青光眼的治疗。

(三) 针灸治疗

取穴：合谷、太阳、攒竹、太冲、行间、列缺、内关、足三里、内庭，每次任选2~4穴。

方法：针刺得气后留针30分钟，每10分钟行针1次。

(四) 调养注意事项

1. 宜戒烟酒及大蒜等辛辣食物。
2. 宜多吃蜂蜜。在食物疗法中，治疗青光眼疗效最好的要数蜂蜜。急性青光眼患者一次口服蜂蜜100毫升，症状可以立即缓解。因为蜂蜜属于高渗剂，口服蜂蜜后，血液中的渗透压就会增高，就会把眼内的水分吸收到血液中来，以

降低眼压。同时，蜂蜜还有润肠通便的作用。临床上的急性青光眼病人多数都兼有大便秘结。大便秘结能引起自体中毒，因为肠内的某些细菌毒素有类似蛇毒样作用，能溶解血管内皮细胞及间质，影响正常的血液循环，同时也能促使眼内房水分泌增加而引起眼压升高。蜂蜜通过润肠通便的作用而缓解青光眼的症状。因此，对患有青光眼的病人来说，多吃蜂蜜有助于康复。

3. 宜保持乐观情绪。人与外界在相互交往的过程中，难免会遇上一些不愉快的事情，当遇到这些烦恼时，会使人心烦意乱，情绪波动，意志消沉。在这种状态下，机体内的环境就会失去协调而发生病变。青光眼病人每当悲伤或大怒之后病情就会加重。因为眼睛各部的肌肉都受大脑神经的自然调节。当人情绪不佳时，就会导致这种自然调节功能失调，而使病情加重甚至恶化。

4. 宜合理安排工作或休息。青光眼病人应适当地减少脑力劳动，多从事自己力所能及的体力劳动。注意改善劳动和工作场所的照明条件。看书学习的时间不宜过长。必须伏案读写时，应有短暂的休息，如闭眼、看远方、转头等，通过这些简单的运动，调节一下大脑神经，不使神经过于疲劳。神经过于疲劳，会使眼压升高而加重病情。

5. 宜坚持体育锻炼。体育运动会使血流加快，眼底瘀血量减少，房水循环加快，可使眼压不同程度地下降。所以，青光眼病人应养成每天坚持体育锻炼的习惯，坚持早起并到户外活动，坚持在上班时做工间操，坚持练气功或打太极拳。

6. 宜注意饮食调摄。青光眼病人的饮食与病情的关系十分密切。过度的饥饿会使胃肠的一部分血液集中到头颅，

增加眼内的血量，促进房水产生，增高眼压。因此，饮食间隔时间不能太长，宜少吃多餐，多吃富含维生素C的蔬菜和水果。

7. 宜在光线充足的环境中生活。亮光可使瞳孔缩小，可缓解青光眼的症状，减少发作。相反，暗处会使瞳孔散大，使眼压增高，这也是青光眼的诱发因素之一。因此，青光眼患者宜多在室外活动。在室内工作时，应尽量使工作环境保持一定的光亮度，同时，不要到暗室工作，不要到电影院看电影。如果必须到暗室工作，宜事先用缩瞳剂滴眼。

8. 宜保持充足的睡眠。人熟睡后，瞳孔就会缩小到最低限度，眼压可降低到一定程度。相反，人在失眠时，睁眼不睡则相当于暗室工作，可使青光眼发作。因此，保持良好的睡眠是十分必要的。睡前1~2小时要避免过度用脑，做短时间室外散步，用热水泡脚。睡眠用的枕头宜稍高些，以免血液积于头部和眼内。

此外，患者切忌做倒立锻炼（瑜珈功），忌服阿托品、颠茄、普鲁本辛、胃复康、安定、口服避孕药等，因为这些药物能使眼压增高。忌吃浓茶和咖啡。

97. 老年性耳聋

老年性耳聋是老年人的常见病，系耳蜗神经渐进性萎缩，听觉细胞退行性改变的一种病变。听器在胚胎中是最晚发生的器官，其衰竭亦较早。由于听器终生受到声音的刺激，故其功能易于衰竭。听力可随年龄增长而衰退。也有认

为老年性耳聋系耳部微循环障碍所致。

老年性耳聋的临床特点是高音频率先降低，听力损失呈双侧对称性（双侧听力均减退或消失）。患者戴助听器后，听力可有明显提高。

老年性耳聋属于祖国医学的“虚聋”范畴。中医认为气虚、血虚、肾虚皆能导致耳聋，而老年性耳聋以肾虚为多见。《素问·阴阳应象大论》认为，肾主耳。中医还认为，肾开窍于耳，耳为肾之官，肾气足则听觉聪敏，肾气衰则耳鸣耳聋。《灵枢·脉度》说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣”。中医认为，耳通于脑，脑为髓海，髓海赖肾的精气化生和濡养，肾虚则失于濡养，故耳聋昏聩。《医林改错》说：“两耳通脑，所听之声归于脑”。《灵枢·海论》说：“髓海不足，则脑转，耳鸣”。老年性耳聋的治疗，宜补肾荣脑。

治疗

（一）中药疗法

方药：黄精30克，肉苁蓉15克，枸杞15克，仙灵脾30克，仙茅10克，葫芦巴10克，巴戟天10克，菟丝子30克，覆盆子10克，续断30克，磁石45克，五味子15克。水煎服，每日一剂，连服30~90剂，或作成蜜丸常服。

补肾的成药如杞菊地黄丸、龟龄集、雄狮丸等均可常服，作为辅助治疗。

（二）食物疗法

1. 山药枸杞猪肾粥：山药30克，枸杞30克，猪肾一对，大米100克。猪肾剖开，去腺腺，切成薄片备用。大米、山药先煮烂，后加入枸杞及猪肾薄片，稍煮熟即可食用，不可久煮。食用时可加盐及味精等调料。

2. 核桃枸杞羊肾粥：核桃仁30克，（捣如泥），枸杞30克，羊肾一对，大米100克。羊肾剖开，去腺腺，切成薄片备用，先将大米煮成稀粥，后入核桃仁泥、枸杞及羊肾薄片，稍煮熟即可，不宜久煮。久煮则无效。吃时可加盐及其他调味品。

3. 虾仁炒牛肾：虾仁30克（鲜品），牛肾半个。牛肾切成薄片（去腺腺），加酱油及豆粉，调匀备用。用大火分别炒虾仁及牛肾，然后合并炒匀（不宜久炒），可加盐、味精、葱、姜、蒜等调料，佐餐。

（三）简易气功疗法

气功锻炼对防治老年性耳聋有一定效果。它是借用主观意念的作用，引导内气上行于耳，使耳部的气血流通而改善其听力。具体方法是：坐式（站式或卧式也可），含胸，挺背，直腰，垂帘（即眼皮下垂盖住视线），调和鼻息后，澄神内视，意守听宫穴（在耳屏的前方凹陷中）及翳风穴（在耳垂后凹陷中），约15~30分钟，局部会产生酸胀发热的感觉，每天早晚各一次。但必须持之以恒，才能产生作用。

（四）简易按摩疗法

1. 双指捏按法：食指在同侧耳前，拇指在耳背，用拇指食指的指腹对耳廓进行相对捏按。捏按的顺序是：耳廓脚→耳垂→耳舟→三角窝→对耳轮→对耳屏→耳甲。如此操作3~5遍，通常耳朵有发热感。

2. 食指掐按法：拇指指腹贴于同侧耳背，用食指指峰或指甲沿着上述顺序慢慢地在耳廓上掐掐1—2遍，如有异样痛觉（刺痛或剧痛）可重按数次，以能忍受为度。

3. 双指搓摩法：拇指指腹仍置于同侧耳背，用食指桡侧偏峰，或屈曲食指，以其远侧的桡侧面，相对搓摩全耳

廓，时间约1分钟。这时耳朵有剧烫的感觉。

使用以上这几种自我按摩法，体位不拘，次数不限，多多益善。如耳有外伤或化脓性感染或皮肤病者，则不宜采用。

在采用上法后，再用双手食指腹放在外耳门上，一按一放，反复数十次。

中医认为，“耳为宗脉之聚”，“十二经脉通于耳”，“一身之气贯于耳”。耳和全身各部位通过经络气血而互相联系。生物全息律学说认为，耳穴分布形式是人体各部穴位分布形式的缩影，如同一个头足倒置的胎儿。耳廓按摩就是通过手法的良性刺激，达到运行经脉之气，调整全身气血的目的。操作时耳朵有发烫感，这是一种得气的反应。这种感觉越持久，越渗透，推动气血在周身运行的作用就越大。本法有病能治，无病可防，对机体有百利而无一害。

（五）患者注意事项

1. 宜戒烟酒：在老年性耳聋患者中，男性听力下降比女性严重。一般认为这种性别差异与男性吸烟、饮酒较多有关。烟草燃烧时所产生的二氧化碳、尼古丁等有害物质会刺激交感神经，引起小动脉痉挛，招致听觉末梢破坏，螺旋神经节及听神经的变性。另外，长期饮酒往往影响维生素B的摄入，对听神经也十分不利。

2. 宜常吃含铁较高的食品：医学研究表明，老年性耳聋与耳部微循环障碍有关。老年人血液中的红血球发生硬性改变，硬变后的红血球往往不能通过耳部的微血管，使得微循环慢慢中断，因而导致听力减退。同时发现，红血球硬变与体内缺铁有关。据分析发现，老年性耳聋患者的血液铁平均含量均低于正常。同时内耳含铁酶活性降低，导致血管纹

萎缩，螺旋神经节细胞减少，听毛细胞损伤。因此，老年人应增加含铁丰富的食物，适当吃些动物肝脏、瘦肉、大豆制品、鸡鸭血、猪血、芹菜、菠菜及新鲜水果。因为新鲜水果含维生素C，能提高食入铁的吸收率。

3. 宜少吃动物脂肪：医学家曾对4000余名老年人作过历时六年的健康追踪调查，他们按膳食的偏重将老年人分为两组：第一组控制动物脂肪的摄入，第二组吃高脂肪膳食。结果发现，第一组不仅心脏病发作低于第二组，而且听力敏锐也明显优于第二组。然后将两组的膳食调换一下，结果第二组的听力不仅有所改善，而且部分人还优于第一组。于是认为过食动物脂肪与老年性耳聋有关。其机理是高脂肪膳食能引起全身的动脉粥样硬化，供血给耳部的动脉硬化后会损害听力，引起耳聋。因此，老年人少吃动物脂肪，对听力有益。

4. 患者三忌：

(1)忌强声噪扰。日常生活中的声音凡超过90分贝以上就为噪声，这种声音对耳内的鼓膜有物理性损伤，如鞭炮声，家电音响电器音量过大等皆应避免。

(2)忌滥用药物。常用药物中有不少药物对听觉神经有直接的损伤，如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素和红霉素等。因此，老年性耳聋患者应尽可能不用以上药物。

(3)忌挖耳。挖耳很容易造成机械性鼓膜损伤，易引起外耳道感染。老年性耳聋患者切忌挖耳。

98. 骨刺 鲠 喉

骨刺鲠喉是五官科的常见病，鲠喉最多的是鱼骨（鱼刺），其他如鸡骨、鸭骨、鹅骨、兔骨、猪排骨等等，均可鲠喉。鲠塞不严重而又年老体弱无法耐受手术者，可用中药治疗。

方一：沙姜（山柰）30克，威灵仙30克，桔梗15克，甘草10克，乌梅15克，砂仁5克，山楂15克。水煎，徐徐含服，日1剂。并含嚼橄榄6枚（无鲜橄榄，可用咸橄榄代）。

注：沙姜系民间治食道骨鲠的单方。威灵仙、砂仁治骨鲠，在《本草求真》中已有记载。桔梗治喉中如梗，在《金匱要略》中已有记载。故本方系综合三方加减而成，有较好疗效。

方二：仙灵脾15~20克。置锅内以文火焙焦后，洒入饱和糖水（白糖、红糖均可）150~200毫升，拌匀焙干，再加水400毫升，煎至350毫升左右，稍凉即服。症状较重者，可先服米醋20毫升，10分钟后再服仙灵脾药液。

若连续两次服本方治疗无效，应作手术。

方三：指甲2克，冰片1克，威灵仙10克。洗净指甲，炙炭，加冰片，共研细末贮瓶备用。先将威灵仙煎汤，含漱数次，并徐徐咽下，然后把指甲冰片药末适量吹入咽喉部。隔时重复吹之。

方四：苎麻茎（鲜品60克，干品30克）。

用法：被某种骨（鱼骨、鸡骨等）鲠喉，须以该骨与本药加清水同煎，徐徐咽下。

口腔科

99. 舌下腺囊肿

涎腺囊肿多见于舌下腺，系腺管闭塞和涎液滞留所形成。囊壁极薄，半透明并呈灰蓝色，内容为无色的粘液。这种囊肿多发生在舌下区的一侧，亦可扩展到对侧或穿过下颌舌骨肌扩展到颌下区。由于囊壁很薄，囊肿在增大时常自发破裂，粘液流出，囊肿迅速消失，但不久又复发。舌下腺囊肿常将舌抬起，使进食和说话都感不便。

舌下腺囊肿属于祖国医学的“痰包”范畴。中医认为痰包乃痰饮乘火流行凝于舌下而发，并认为，脾主运化津液，脾开窍于口，运化失常则生痰湿，过食辛燥之物，积为热毒，痰湿与热毒凝聚于舌下而成痰包。治宜燥湿化痰，清热泻火。

方一：淡竹叶12克，木通10克，生地30克，黄芩30克，黄连10克，黄柏10克，炒栀子12克，炒甲珠15克，赤芍30克，丹皮15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方二：茯苓30克，白术30克，夏枯草30克，连翘30克，苡仁30克，生大黄10克，丹皮15克，败酱草30克，芦根30克，皂刺15克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

方中茯苓淡渗利湿，白术燥湿利水，夏枯草利尿清热散结，连翘清热解毒，苡仁利水渗湿，生大黄清热泻下，活血

化瘀，丹皮清热活血，败酱草清热排脓活血，芦根清热，皂刺活血化瘀。诸药合用，共奏清热泻火，活血化瘀排脓散结之效。

100. 口腔粘膜白斑

口腔粘膜白斑是口腔粘膜中较常见的疾病，多见于中年以上的男性患者。表现为口腔粘膜上出现擦不掉的白色角化斑块，表面略粗糙，可有沟纹，或呈疣状突起、大小不等的白色角化颗粒，亦可在白斑的基础上伴有溃疡。少数白斑病例可发生恶变（须经病理切片检查确诊）。口腔粘膜白斑大致可分为以下4型：①皱纸型：白斑呈乳白色，稍高于周围粘膜，界限清楚，表面如皱纹纸样。患者有局部粗糙感，但无压痛。②疣状型：白斑较厚，高出粘膜面，表面不平，粗糙感明显。③颗粒型：在充血发红的粘膜上有颗粒状白色角化隆起，表面不平，进食时可有刺激性疼痛。④糜烂型：在白斑的基础上有糜烂或溃疡，往往溃烂时间较长，且易反复发作，有时伴粘膜皸裂，进食或局部受刺激时，疼痛感明显。由于口腔粘膜白斑有癌变的可能，因此应积极加以防治。

口腔粘膜白斑属于祖国医学的“口糜”、“口舌疳腐”等范畴。中医认为系热毒为患，或脾虚湿困，或气滞血瘀，或阴虚血热，导致口糜。

（一） 辨证分型治疗

1. 气滞血瘀型：白斑局部僵硬、粗糙，进食时疼痛，

反复发作，舌质紫暗，苔薄黄，脉涩。治宜活血化瘀。

方药：当归30克，赤芍30克，桃仁10克，红花10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，乳香10克，没药10克，三棱10克，莪术10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

2. 脾虚湿困型：白斑有轻浅溃疡，伴头重，食少便溏，舌淡苔白厚，脉弦滑。治宜健脾利湿。

方药：太子参30克，白术30克，茯苓30克，苡仁30克，泽泻30克，扁豆15克，苍术15克，神曲15克，山药30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

3. 阴虚血热型：白斑干燥、疼痛，口干不欲饮，伴失眠，心烦，大便干结，舌红无苔脉细数。治宜养阴清热凉血。

方药：沙参30克，麦冬30克，生地30克，石斛15克，枸杞15克，制首乌30克，赤芍30克，丹皮12克，大黄10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

（二）验方治疗

1. 蜂胶（蜜蜂用以填塞蜂巢的粘性物质，低温下可变硬）涂敷于白斑上。蜂胶有消炎、止痛和软化角化组织的作用，外用能治多种皮肤病，内服也无不良反应。

2. 锡类散（成药）涂敷于白斑上。每日涂2次。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第六集

作者=贾河先 吴家福 邱运梨编著

页数= 2 4 1

S S 号= 1 0 4 6 1 2 3 0

出版日期= 1 9 9 2 年 0 8 月第 1 版